LINHA DE CUIDADO PARA ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL, DOMÉSTICA E FAMILIAR

Brasília, 2025

Secretaria de Saúde

GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Governador

Ibaneis Rocha

Vice- Governadora

Celina Leão

Secretário de Estado de Saúde

Juracy Cavalcante Lacerda Júnior

Elaboração e Colaboradores/as

Grupo Condutor Distrital da Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (GCD- RAV/ SES DF)

Revisão 1ª edição

Ana Luiza Bulkool Mantovani

Elizabeth Maulaz Lacerda Ferreira

Enzo Ernani Sousa e Silva

Guaia Monteiro Siqueira

Lígia Maria Carlos Aguiar

Marcela Novais Medeiros

Priscila Nolasco de Oliveira

Renata de Souza Reis

Renata Rodrigues de Melo Almeida

Sumário

1. Introdução.....5
2. Metodologia.....6
2.1. Bases de dados consultadas.....6
2.2. Palavra(s) chaves(s).....6
2.3. Período referenciado e quantidade de artigos relevantes.....6
3. Objetivos.....7
3.1. Objetivo geral.....7
3.2. Objetivos específicos.....7
4. Justificativa.....8
4. 1. Conceitos, tipos e natureza das violências.....8
4.2. O impacto da Violência na Saúde Pública.....15
4.3. Perfil Epidemiológico da Violência Sexual, Doméstica e Familiar no Brasil e no DF.....17
Dados do Distrito Federal.....21
5. Público alvo.....24
6. Rede de Atenção à Saúde.....24
6.1. Atenção Primária à Saúde – APS.....28
Atendimentos na Atenção Primária – APS.....29
Prevenção de Agravos e Promoção da Saúde.....34
6.2. Atenção Especializada em Saúde.....35
Centro de Especialidades para a Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (CEPAV) e Programa Violeta:.....36
Programa de Interrupção Gestacional Prevista em Lei (PIGL).....39
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS):.....40
Centro de Orientação Médica e Psicopedagógica (COMPP).....41
Adolescentro.....42
Policlínicas.....42
Centro Especializado em Saúde da Mulher (CESMU).....43
Ambulatório Trans.....44
6.3. Atendimento pré-hospitalar e Atenção Terciária.....44
Atendimento pré-hospitalar móvel (APH móvel) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).....45
Atendimento pré-hospitalar fixo (APH fixa): Unidades de Pronto Atendimento (UPA).....45
Serviço Hospitalar de Emergência (SHE):.....46
Serviços de Internação.....47
7. Dimensões do Cuidado.....48
7.1. Acolhimento às Pessoas em situação de Violência no âmbito da SES/DF.....49
7.2. Atendimento às pessoas em situação de violência no âmbito da SES/DF.....50
Atendimento às pessoas em situação de violência sexual no âmbito da SES/DF.....52
Atendimento às pessoas em situação de violências físicas e outras violências no âmbito da SES/DF.....53
7.3. Notificação das situações suspeitas ou confirmadas de violência no âmbito da SES/DF.....53
7.4. Seguimento em rede e cuidado compartilhado.....56
Itinerário e Compartilhamento de Cuidado em Saúde.....57
8. Sistemas de Apoio.....62
9. Vigilância em Saúde.....63

9.1. A Vigilância em Saúde na SES/DF..... 63
10. Rede Intersetorial..... 64
10.1. Comunicação Externa de situações de violência..... 67
11. Educação em Saúde..... 70
11.1. Educação Permanente dos Profissionais de Saúde da RAS..... 71
11.2. Educação da Sociedade: Promoção da saúde, da cultura de paz e prevenção de violências.. 72
11.3. Indicadores para o Monitoramento e a Avaliação da Vigilância na Temática da Violência..... 73
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 74
13. FLUXOGRAMAS ASSISTENCIAIS..... 76
14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 79
15. ANEXOS..... 85
ANEXO I - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA (Link para baixar a Ficha)..... 85
ANEXO II - FORMULÁRIO INFORMATIVO DE SUSPEITA DE VIOLÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOA IDOSA E PESSOA INDÍGENA..... 87
ANEXO III - FORMULÁRIO INFORMATIVO DE SUSPEITA DE VIOLÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA EM CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER..... 89
ANEXO IV - FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - FONAR..... 91
ANEXO V - BASES LEGAIS..... 97

1. Introdução

Este documento se destina a trabalhadores e gestores da Rede de Atenção à Saúde (RAS) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Com ele, pretende-se contribuir para a ampliação do acesso e a qualificação da atenção às pessoas em situação de violência, sendo um importante instrumento para efetivação, monitoramento e avaliação do cuidado a este público.

A elaboração desta Linha de Cuidado (LC) é o resultado de um processo participativo que envolveu trabalhadores e gestores da SES/DF, nos diferentes níveis de atenção à saúde, representados pela Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (SAIS) e suas coordenações; a Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), representada pelo Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências (NEPAV); as Regiões de Saúde, representadas pelos Núcleos de Prevenção e Assistência às Situações de Violência (NUPAV e UPAV HMIB) e pelos Centros de Especialidades de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (CEPAV).

Essa construção se deu, inicialmente, por meio da Portaria nº 900, de 21 de agosto de 2018, que instituiu o Colegiado Gestor Técnico da Atenção Integral à Violência, para estruturação desta Linha de Cuidado em todos os níveis de atenção nas Regiões de Saúde do DF - operacionalizado em coordenação conjunta pelos representantes mencionados. Ao colegiado, competia o compromisso de organizar a Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência, definir fluxos para os serviços e implementar ações estratégicas de enfrentamento à violência; além de construir uma linha de cuidado adequada às necessidades dos usuários, na perspectiva de rede. Nesse sentido, para o fortalecimento dessas ações, o Colegiado foi substituído pelo Comitê Permanente de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência do Distrito Federal, publicado pela Portaria nº 347, de 19 de abril de 2021.

Em 2023, como resultado da “Força-Tarefa para propor, no âmbito do Distrito Federal, políticas públicas voltadas à prevenção do feminicídio, à proteção, ao acolhimento e à eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres” (Decreto nº 44.206), foi instituída a Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência (RAV), por meio da Portaria nº 108, de 20 de março de 2023. Por meio dela, o Grupo Condutor Distrital da RAV (GCD-RAV) substituiu o referido Comitê. Desde então, foi retomada a produção desta Linha de Cuidado.

A intervenção no contexto da violência no âmbito da saúde demanda articulação e coordenação entre os serviços, em todos os níveis de atenção e complexidade, com o foco na continuidade da assistência. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de ações transversais que tenham como eixos norteadores a promoção da saúde e de uma cultura de paz; a prevenção de todas as formas de violências; a notificação (compulsória, sigilosa e anônima); o atendimento e o seguimento na rede intra e intersetorial de cuidados; bem como a proteção e a responsabilização adequadas a todos os ciclos de vida.

Para o aprimoramento dessa intervenção, faz-se necessária a compreensão dos principais conceitos relacionados à violência, do diagnóstico situacional e do contexto sociodemográfico e epidemiológico do território, possibilitando uma abordagem interseccional das vulnerabilidades das pessoas em situação de violência. Isso requer a organização do setor saúde em modelos de atenção

multiprofissionais, que contemplem, com integralidade, a determinação social da saúde e as suas consequências no processo saúde-doença.

Assim, esta LC tem como finalidade estabelecer diretrizes técnicas, normas, critérios e fluxos para a organização dos serviços de saúde no âmbito da SES/DF, estabelecendo o itinerário do cuidado em saúde para pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica. Os pontos de atenção e de gestão voltados às pessoas em situação de violência devem ter como horizonte ações articuladas, sob a concepção ampliada da saúde e da equidade. Dessa forma, os serviços de saúde estarão organizados para contribuir com a promoção da cultura de paz e com o combate à violência.

2. Metodologia

Trata-se de material fundamentado por abordagem científica mista quali-quantitativa. A pesquisa de métodos mistos possui delineamento transversal e de natureza analítica e compreensiva, considerando-se que, a partir da vinculação entre tendências estatísticas (dados quantitativos) e elaborações qualitativas, promove-se um melhor entendimento dos problemas ou fenômenos da pesquisa (MINAYO; GUERRIERO, 2014; SOUSA, 2022).

2.1. Bases de dados consultadas

Para a construção desta Linha de Cuidado, foram utilizadas as bases de dados: Google Acadêmico, para pesquisa de produções científicas pertinentes ao tema; os sítios eletrônicos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES DF), para consulta aos ambientes virtuais onde há sistematização de protocolos e outras tipologias de publicações técnico-científicas, políticas, programas, estratégias e ações institucionalizadas de saúde pelos órgãos sanitários competentes em âmbito federal e distrital; sítios eletrônicos de entidades profissionais de referência na produção e orientação técnica e científica das categorias profissionais atuantes nas equipes multiprofissionais de atenção às pessoas em situação de violência, também para consulta de protocolos e outras tipologias de publicações técnico-científicas orientadoras da assistência às pessoas em situação de violência.

2.2. Palavra(s) chaves(s)

Violência, Violência Sexual, Violência Doméstica; Acesso aos serviços de saúde, Notificação compulsória, Acolhimento, Assistência integral à saúde, Redes Intersetoriais, Humanização

2.3. Período referenciado e quantidade de artigos relevantes

Não houve período e número de produções previamente estabelecido para a pesquisa em bases de dados. Tendo em vista a relevância da temática, optou-se por analisar produções técnicas e

científicas referenciadas como clássicos na abordagem ao tema, bem como os protocolos assistenciais e orientações técnico-científicas mais atualizadas.

Quanto às legislações, foi realizada revisão documental geral sobre o tema, até que se alcançasse a saturação dos dados de forma contemplativa à necessidade de embasamento legal e fundamentação teórica deste documento.

Esta trilha de pesquisa levou à diversidade de períodos de publicação, compreendendo materiais publicados entre 2002 e 2023. Da mesma forma, consultou-se diversos artigos científicos; manuais técnicos; dispositivos normativos e legislativos, dentre leis, portarias, decretos e notas técnicas.

3. Objetivos

3.1. Objetivo geral

Implantar a Linha de Cuidado: Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica na SES/DF, para organização do itinerário do cuidado em saúde nos diferentes níveis de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS), bem como orientar e articular os demais serviços de proteção e garantia de direitos da Rede Intersetorial.

3.2. Objetivos específicos

1. Definir os pontos de atenção às pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica em cada nível de atenção à saúde;
2. Organizar as ações, competências e responsabilidades de cada ponto e nível de atenção da Rede de Atenção à Saúde;
3. Orientar profissionais e gestores da saúde no desenvolvimento e estabelecimento de estratégias para o enfrentamento da violência, em articulação com a rede intra e intersetorial;
4. Subsidiar iniciativas de educação permanente dos profissionais de saúde, desde a promoção da saúde, prevenção de agravos, até a assistência, reabilitação e seguimento das pessoas autoras e sobreviventes de situações de violência;
5. Orientar o acolhimento humanizado e ético da pessoa em situação de violência sexual, familiar e doméstica, com vistas à integralidade, à abordagem biopsicossocial, incluindo terapias, medicamentos, atendimentos e redução de danos e agravos em saúde;

6. Sugerir elementos relevantes ao planejamento de cada Região de Saúde no tocante à atenção às pessoas em situação de violência, com base nos princípios e diretrizes de universalidade, equidade, integralidade, regionalização, hierarquização;
7. Direcionar o uso dos sistemas de informação para o acompanhamento do cuidado, gestão dos casos e regulação do acesso aos serviços de atenção especializada, subsidiando o monitoramento e a avaliação das ações e dos serviços;
8. Contribuir para o enfrentamento das violências, dos preconceitos e discriminações às populações vulnerabilizadas;
9. Apontar os recursos intersetoriais necessários à atenção integral à pessoa em situação de violência;
10. Articular ações intersetoriais para garantia dos direitos dos usuários e para promoção da cultura de paz.

4. Justificativa

4. 1. Conceitos, tipos e natureza das violências

A Organização Mundial de Saúde – OMS (KRUG et al., 2002, p. 2) define violência como:

> Uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grandes possibilidades de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.

Nesta Linha de Cuidado (LC), para fins de conceituação, além da classificação de violência proposta pelo Relatório Mundial da OMS (KRUG et al., 2002), adota-se conceitos referendados pelos instrutivos do Ministério da Saúde, tipificações do Código Penal Brasileiro, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outras normativas. O uso de normas e diretrizes da máxima autoridade sanitária do país, bem como de legislações vigentes e suas respectivas atualizações, tem o objetivo de adequar esta produção técnica às definições sanitárias e jurídico-legislativas vigentes, assim como refletir sobre os contextos socioculturais relativos à pauta, consolidando uma concepção alinhada ao conceito integral e equitativo de saúde.

Além dos aspectos legais e normativos, a compreensão da violência como fenômeno exige a observação dos ciclos de vida dos envolvidos e de variáveis como vulnerabilidades e condições socioeconômicas. Também é preciso considerar os elementos socioculturais da atualidade, os quais propiciam novos cenários para manifestação de violência, a exemplo do uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) como maneira de contato entre autor e vítima, favorecendo a ocorrência da violência no próprio ambiente virtual ou utilizando-o como ferramenta.

A ocorrência da violência evidencia um crime e, portanto, há necessidade de ações em rede que envolvam prevenção de danos e recorrências, atendimento à pessoa sobrevivente e responsabilização de autores. Por se tratar de um problema de saúde pública, cabe ao setor da saúde viabilizar ações de cuidado e proteção, contemplando o acolhimento, o atendimento, a notificação e o seguimento do atendimento nos diversos serviços da rede intrasetorial, bem como o acionamento da rede intersetorial com a finalidade de contribuir para romper o ciclo da violência e a prevenção de reincidências de violências.

Portanto, a violência é um problema de saúde pública e uma grave violação de direitos humanos com inúmeros agravos físicos, psíquicos e sociais. A manutenção deste fenômeno ocorre por aspectos multifatoriais e questões socioculturais que estão na base da constituição da sociedade. Para o seu enfrentamento é necessária a compreensão destes fatores, dos determinantes sociais envolvidos, das dinâmicas de funcionamento do fenômeno, além de romper com a invisibilização e a naturalização das violências. A superação destes desafios passa pelo conhecimento e nomeação dos tipos de violência.

Conforme o Instrutivo "Viva", do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016) e Instrutivo para Notificação da Violência no DF, da SES/DF, nos quais são oferecidas orientações para o Preenchimento da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada, as violências podem ser classificadas conforme a relação entre a pessoa que comete a violência e a vítima. Seguindo tal classificação, as violências são divididas em três amplas categorias: violências interpessoais, violências contra si mesmo e violências coletivas.

- **Violências interpessoais:** são divididas em intrafamiliar, entre parceiros(as) íntimos(as) e comunitária.
- **Violência intrafamiliar e entre parceiros(as):** compreende a violência cometida por membros da família e namorados(as), companheiros(as) ou ex-parceiros(as). Frequentemente ocorre no ambiente doméstico, porém a ocorrência de violência entre familiares ou parceiros(as) íntimos(as) fora do lar não exclui a categorização nesse eixo. Adota-se a diferenciação do Ministério da Saúde entre violência doméstica e intrafamiliar.

> A violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à outra. O conceito de violência intrafamiliar não se refere apenas ao espaço físico onde a violência ocorre, mas também às relações em que se constrói e efetua. A violência doméstica distingue-se da violência intrafamiliar por incluir outros membros do grupo, sem função parental, que convivam no espaço doméstico. Incluem-se aí empregados(as), pessoas que convivem esporadicamente, agregados (BRASIL, 2002, p. 15).

- **Violência comunitária**: ocorre entre pessoas sem parentesco, podendo ser conhecidas ou desconhecidas da vítima. Exemplos desse tipo de violência são a violência juvenil, as agressões físicas, os estupros e a violência institucional, as quais podem acontecer em escolas, nas ruas, locais de trabalho, serviços de saúde e asilos.
- **Violências contra si:** são as violências autoprovocadas, como automutilação, comportamento suicida (ideação, planejamento, tentativa e auto-extermínio consumado).
- **Violências coletivas:** são divididas em violência social, política e econômica, conforme as motivações subjacentes ao comportamento agressivo.
    - ➔ **Violência Social**: está relacionada a pautas sociais, como, por exemplo, crimes de ódio cometidos por grupos organizados, atos terroristas e violência de multidões.
    - ➔ **Violência Política**: agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual, com a finalidade de impedir ou restringir o acesso e exercício de funções públicas e/ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade.
    - ➔ **Violência Econômica:** envolve atos que visam impactar a atividade econômica ou impossibilitar o acesso a serviços essenciais.

Outra forma de categorizar as violências é subdividi-las em violências física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e negligência/abandono (KRUG et al., 2002; BRASIL, 2016):

- **Violência física**: atos violentos, nos quais se fez uso da força física ou não, de forma intencional, não acidental, com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento à pessoa, deixando ou não marcas evidentes no seu corpo. Manifesta-se de várias formas, como tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, entre outras. A violência física também ocorre no caso de ferimentos por arma de fogo (incluindo as situações de bala perdida) ou ferimentos por arma branca.

  → **Transtorno Factício Imposto a Outro (TFIA):** pode ser classificado como um tipo de violência física contra a criança ou adolescente. É caracterizado pela simulação ou criação, por um dos responsáveis ou cuidador (com grande frequência a mãe), de sinais ou sintomas que caracterizam doenças em seus filhos. Esses responsáveis podem chegar a falsificar material colhido para exames, induzindo profissionais de saúde a tratamentos desnecessários ou investigações cada vez mais complexas e invasivas. Nesses casos o(a) cuidador(a) costuma demonstrar grande conhecimento da doença simulada ou provocada e parece ser extremamente cuidadoso e protetor com a criança. O diagnóstico é feito por meio de avaliações multiprofissionais e deve-se identificar qual o ganho secundário para o(a) autor(a) da violência. Dificilmente seu diagnóstico é feito em outros âmbitos que não o da saúde, por isso a importância de sensibilizar e capacitar profissionais que trabalham em emergências e internações pediátricas.

- **Violência psicológica:** é toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, manipulação, desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes, perseguição, insulto e utilização da

pessoa para atender às necessidades psíquicas de outrem. Envolve ações que colocam em risco ou causem danos à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa.

- **Violência sexual**: toda relação de natureza sexual à qual a pessoa é obrigada a se submeter contra sua vontade, por meio de força física, coerção, sedução, ameaça ou influência psicológica, mesmo quando praticada por um familiar. Também é considerada violência quando a pessoa que a comete obriga a vítima a realizar estes atos com terceiros. A violência sexual pode ser melhor compreendida a partir das tipificações previstas na legislação, cujas classificações estão sistematizadas na tabela abaixo:

TIPO DE VIOLÊNCIA SEXUAL	CONCEITO
Assédio sexual	É a insistência inoportuna, independentemente do sexo ou da orientação sexual, com perguntas, propostas, ou pretensões de natureza sexual. É o ato de "constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função" (CP, art. 216-A).
Importunação Sexual	Todo ato de "praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro", (Lei 13718/18, Art. 215-A), por meio de ameaças e chantagens, cantadas invasivas, exibicionismo, voyeurismo, pornografia.
Crimes contra a dignidade sexual	Estupro, atentado violento ao pudor, estupro de vulnerável, tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, entre outros (Lei 12.015/2009).
Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia	Todo ato de "oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática-, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia" (Lei 13718/18, Art. 218-C).

Estupro	Todo ato de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso” (Lei 12.015/09, Art. 213);
Estupro de Vulnerável	"Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos" (Código de Processo Penal, Art. 217- A), independente de eventual anuência e histórico sexual da vítima. Também inclui o ato com "(...) alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência (Código de Processo Penal, Art. 217-A, inciso 10)".
Violência sexual mediante fraude	“Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude, uso de substâncias psicoativas ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima” (Lei 12.015/09, Art. 215). Um exemplo dessa violência é o golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela”.
Pornografia infantil	É a apresentação, a produção, a venda, o fornecimento, a divulgação e/ou a publicação de fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito (exposição de imagens) envolvendo crianças ou adolescentes, utilizando qualquer meio de comunicação (Lei 11.829/08).
Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual	É todo ato provocado contra pessoa adulta que envolve “induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone” (Lei 12.015/09, Art. 228). Envolve a intimidação ou outra forma de coerção.
Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável	É todo ato de “submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone” (Lei 12.015/09, Art. 218-A).
Importunação ofensiva ao pudor	“Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro” (Lei 13.718/18, Art. 215). Também está nessa categoria qualquer outro tipo de violência sexual não contemplado nas anteriores, como: *pornrevenge* (vingança pornográfica), estupro coletivo, estupro corretivo, lenocínio, etc.

- **Violência moral:** toda ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da pessoa. Define-se como conduta abusiva, exercida por meio de gestos, atitudes ou outras manifestações, repetidas, sistemáticas, que atentem contra a dignidade ou contra a integridade psíquica.

- **Violência patrimonial**: qualquer conduta que subtraia ou destrua bens, instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos da vítima.

- **Negligência/abandono:** omissão pela qual se deixou de prover as necessidades e os cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social da pessoa atendida/vítima. Ex.: privação de medicamentos; falta de cuidados necessários com a saúde; descuido com a higiene; ausência de proteção contra as inclemências do meio, como o frio e o calor; ausência de estímulo e de condições para a frequência à escola. O abandono é uma forma extrema de negligência.

Considera-se importante, além das categorias já apresentadas, destacar outros tipos de violações de direitos que configuram situações de violência, tais como:

- ➔ Cárcere privado
- ➔ Cyberbullying e Bullying
- ➔ Trabalho infantil/exploração econômica
- ➔ Tráfico de pessoas.

Para além das tipificações já mencionadas, é necessário que o/a profissional de saúde compreenda aspectos relacionados à **frequência** e à **temporalidade** (violência aguda e violência crônica) das situações de violência, pois as manifestações clínicas consequentes das violências podem ocorrer de maneira imediata (agudas), de médio ou de longo prazo (crônicas), envolvendo agravos físicos, mentais e/ou sociais.

- **Violência Aguda:** são os episódios isolados e/ou recentes (até 72h) de exposição a agressões. A violência aguda também pode ocorrer a partir de um episódio maior de uma sequência de violências com a ocorrência de danos físicos e/ou psicológicos importantes, como tentativas de feminicídio, espancamentos, queimaduras, etc. Nesse tipo de violência, lesões e ameaças à vida e à integridade física costumam ser mais explícitas e graves. Exemplos: sintomas de Transtorno de Estresse Agudo desenvolvidos, geralmente, nos primeiros 30 dias após a agressão; inflamações; contusões; hematomas em várias partes do corpo; lesões das mucosas oral, anal e/ou vaginal.
- **Violência Crônica:** são aquelas em que a violência é múltipla, repetida, ocorrendo por períodos prolongados. Pelo seu caráter sistemático e constante, identificar uma violência crônica pode ser mais difícil, ocasionando graves danos à saúde física e mental das pessoas envolvidas. Exemplo desse tipo de violência é a exposição crônica à violência doméstica e ao abuso sexual intrafamiliar. Alguns agravos de médio e longo prazo são: insônia, pesadelos, falta de concentração, irritabilidade, crise de pânico, náuseas, vômitos, cólicas, dores de estômago, perda de peso, dores de cabeça, falta de adesão aos cuidados em saúde, doenças autoimunes e dores musculares generalizadas, os quais podem surgir ou permanecer semanas, meses ou anos após a agressão.

Além dessas categorizações, há tipos específicos de violência que merecem atenção por sua relevância e impacto biopsicossocial entre os grupos acometidos:

- **Violência contra pessoas em situação de rua**: quando a violência é motivada por preconceito, desrespeito ou por qualquer tipo de discriminação à pessoa ou população em situação de rua (*aporofobia)*. Trata-se de um grupo populacional:

> (...) heterogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória" (BRASIL, 2009).

- **Violência contra Pessoas com Deficiência**: quando a violência é motivada por preconceito, desrespeito ou por qualquer tipo de discriminação à condição das pessoas com deficiência.
- **Filicídio**: assassinato do filho, pelo pai, pela mãe ou por ambos. É tratado na legislação brasileira como crime de homicídio ou infanticídio previsto no Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940).
- **Feminicídio**: crime contra a mulher tendo como razão simplesmente a sua condição de ser mulher (BRASIL, 2015).

Com vistas à melhor compreensão das tipificações de violência, faz-se necessário, ainda, compreender conceitos para a identificação das situações de violência e, principalmente, à qualificação de um plano de cuidados equitativo, eficaz e efetivo:

- Sexismo: suposto prestígio e poder masculinos sobre as mulheres. Reflete-se em um conjunto de condutas construídas, aprendidas, e reforçadas culturalmente.

- Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia (LGBTfobia): conjunto de fatores como medo, aversão, discriminação e o ódio em relação a pessoas homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e todas as orientações sexuais e identidades compreendidas na afirmação social, cultural e política da população LGBTQIAP+. É, portanto, a violência motivada e praticada em razão da orientação sexual presumida da vítima, podendo a mesma ser membro da população LGBTQIAP+ ou não.

- Racismo: divisão da sociedade em grupos definidos pela cor da pele, traços físicos e aspectos culturais, de forma a hierarquizá-la. A discriminação racial ou étnico-racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em igualdade de condições de direitos e liberdades fundamentais, em quaisquer campos da vida pública ou privada, conforme Lei n° 12.288/2010.

- Intolerância religiosa: conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas ou a quem não segue uma religião.

- Xenofobia: forma de discriminação social que consiste na aversão a pessoas de diferentes culturas, nacionalidades e naturalidades – incluindo pessoas do próprio país, provindas de diferentes regiões geográficas. Considerada como crime de ódio, a xenofobia é expressa através da humilhação, constrangimento, agressão física e moral àquela pessoa que não é natural do lugar da pessoa que comete a violência.

- Conflito geracional/etarismo: discrepâncias culturais, sociais ou econômicas entre duas gerações, que pode ser causada por conflitos entre gerações mais jovens e gerações mais idosas.

Posto isso, compreendidos os conceitos, tipificações e categorizações relacionados às violências, é necessário entender o impacto da violência na saúde pública.

4.2. O impacto da Violência na Saúde Pública

A violência representa um grave problema de saúde pública, um fenômeno social complexo e multicausal que envolve aspectos políticos, sociais, culturais, jurídicos, econômicos, históricos, dentre outros, atingindo todos os indivíduos em suas diferentes manifestações (físicas e emocionais). Dessa forma, o sistema de saúde ocupa um papel importante no cuidado às pessoas em situações de violência e, portanto, deve estar preparado e organizado para atender as demandas advindas dessa complexidade a curto, médio e longo prazo.

Frequentemente, o sistema de saúde é o primeiro ponto de contato das vítimas de violência com a rede de atenção e proteção. Por isso, o enfrentamento a este fenômeno, na perspectiva da saúde, constitui-se de um espaço privilegiado para a identificação, acolhimento, atendimento, notificação e seguimento em rede das pessoas em situação de violência, assim como a elaboração e execução de estratégias de enfrentamento das violências e de promoção da cultura de paz.

O setor saúde iniciou paulatinamente a análise do fenômeno da violência na década de 1960, sob a ótica das consequências e impactos na saúde. Entretanto, é nos anos de 1980 que a temática ganha o cenário da saúde pública, a partir da transição epidemiológica, e passa a ser considerada como uma questão de grande importância, com a escolha do tema para a celebração do Dia Mundial da Saúde. Consecutivamente, na década de 90, a violência passa a ter uma maior visibilidade.

Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (1994, apud MINAYO, 2006, pg. 1.261):

> A violência, pelo número de vítimas e pela magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública em muitos países (...). O setor saúde constitui a encruzilhada para onde convergem todos os corolários da violência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de urgência, atenção especializada, reabilitação física, psicológica e assistência social.

No ano de 2002, a OMS (KRUG et.al., 2002), em seu relatório mundial, destaca a Violência, no contexto da saúde, como pauta de ação. Este destaque traz a importância de considerar esse fenômeno com a devida relevância sanitária, para garantir o planejamento de ações de enfrentamento e de gestão. A inserção da temática foi acompanhada pela elaboração de estudos, normas e diretrizes que abordam a organização do setor saúde para a execução de ações de promoção, prevenção e assistência.

No Brasil, a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violências – PNRMAV, publicada em 2001, representou um marco no enfrentamento da violência na saúde, pois definiu as diretrizes de ação e orientou a organização do setor. Isto exigiu uma readequação da Rede de Saúde e o desenvolvimento de ações em eixos de promoção, prevenção, vigilância epidemiológica, assistência transversal em todos níveis de complexidade e ciclos de vida; além da realização de estudos, pesquisas e capacitações (BRASIL, 2002).

Não obstante a esses avanços, à criação de uma Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde, em 2001, e à implantação do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), em 2006, as informações referentes à morbidade por violência, agressão e maus tratos permanecem, de certa forma, escassas - principalmente quando se trata de municípios menores e regiões interioranas. Os dados dão ênfase às capitais e grandes cidades, com maior enfoque na mortalidade – o que é uma tendência mundial na produção estatística sobre o tema. Tais dados são úteis para a vigilância epidemiológica das causas externas, contudo são insuficientes para a formulação de políticas públicas focadas em outras violências e agravos, que também demandam dos serviços de saúde, bem como não suprem assertivamente a elaboração de políticas de saúde adequadas às características locorregionais.

Enquanto processo social e fenômeno formado e mantido por aspectos socioculturais, a violência exerce grande influência na área da Saúde e suas consequências implicam elevados gastos com estruturas pré-hospitalares, de emergência, assistência e reabilitação. Além disso, envolve investimentos no sistema de segurança pública e prisional, bem como no sistema público de saúde e socioassistencial para a atenção e assistência direta às vítimas por meio do pagamento de pensões, aposentadorias, licenças médicas, atendimento em saúde, dentre outros. Dessa forma, o custo econômico e social da violência letal e não letal é de 5,9% do PIB.

Diante da complexidade da violência, faz-se necessário que a atenção prestada pela Saúde às pessoas em situação de violência seja regida pelos seguintes elementos:

- Intervenção em linha de cuidado;

- Atenção com enfoque nas dimensões do cuidado integral: acolhimento, atendimento, notificação e seguimento na rede;

- Articulação com o sistema de proteção social;

- Trabalho em rede para a continuidade do cuidado, proteção, recuperação e restabelecimento do direito à cidadania;

- Ações de prevenção de agravos, promoção da saúde e da cultura de paz, sob a ótica da garantia de direitos e na perspectiva do fortalecimento de vínculos entre os serviços de saúde, a rede

intersetorial e a comunidade.

Assim, a implementação desta Linha de Cuidado possibilita a organização de uma rede para o cuidado integral e humanizado em saúde às pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica no DF, a partir da construção de fluxos definidos entre as unidades de referência assistenciais da saúde, em articulação com outros setores de políticas públicas e da sociedade civil, contribuindo para o seu enfrentamento, face à complexidade do fenômeno da violência.

4.3. Perfil Epidemiológico da Violência Sexual, Doméstica e Familiar no Brasil e no DF

Em 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), conduzida pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, revelou que 18,3% da população adulta brasileira (18 anos ou mais) sofreu algum tipo de violência nos 12 meses anteriores à entrevista. Esse dado representa aproximadamente 29,1 milhões de pessoas. A prevalência foi mais alta entre mulheres (19,4%) do que entre homens (17,0%), e mais acentuada entre jovens de 18 a 29 anos (27,0%) e pessoas autodeclaradas pretas (20,6%) e pardas (19,3%) (BRASIL, 2019).

A violência psicológica foi o tipo mais prevalente (17,4%), seguida pela violência física (4,1%) e sexual (0,8%). Entre as vítimas, 15,6% procuraram atendimento de saúde, com maior procura entre mulheres (16,9%) do que entre homens (13,2%) (BRASIL, 2029).

No contexto da violência sexual contra crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde divulgou um boletim epidemiológico em maio de 2023, que indicou que, entre 2015 e 2021, foram notificados 202.948 casos no Brasil. Desses, 83.571 ocorreram contra crianças e 119.377 contra adolescentes. O ano de 2021 registrou o maior número de notificações, com 35.196 casos. A maioria dos agressores era do sexo masculino, responsáveis por mais de 81% dos casos contra crianças e 86% contra adolescentes. As vítimas eram predominantemente do sexo feminino: 76,9% das notificações de crianças e 92,7% das notificações de adolescentes (BRASIL, 2023)

Esses dados evidenciam a magnitude da violência no Brasil e a necessidade urgente de políticas públicas eficazes para prevenção, proteção e apoio às vítimas. A atuação da Atenção Primária à Saúde é fundamental, pois representa a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) para o atendimento das vítimas, sendo crucial o reconhecimento dos sinais de violência e a identificação dos fatores de risco para prevenir novas agressões.

O 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi publicado em 2024 e revelou que, apesar de uma queda de 3,4% nas mortes violentas intencionais, o Brasil ainda tem um dos maiores índices de violência do mundo. A análise dos dados relacionados à ocorrência dos mais diversos tipos de violência, sob a ótica da vigilância em saúde, motivam elaboradores, gestores, executores de políticas públicas e provedores de cuidados à atenção sobre o tema.

No Brasil, os homens representam a maioria das vítimas de violência fatal, especialmente em casos de homicídios. De acordo com dados do Atlas da Violência (2017), os homens negros morrem quatro vezes mais do que os brancos em vias públicas por disparos de arma de fogo.

O Brasil é ainda um dos países com os maiores índices de homicídios não resolvidos. Os dados sobre a violência no Brasil são alarmantes. Apesar da diminuição dos índices de criminalidade no país em 2019, ainda temos altos índices de homicídios e crimes violentos. A seguir estão listados alguns índices sobre a violência no Brasil: O Brasil teve uma redução de 22% nas mortes violentas registradas em 2019 em relação a 2018. Em 2018, foram registrados 39.527 homicídios entre janeiro e setembro, enquanto 2019 registrou, no mesmo período, 30.864 homicídios. O Mapa da Violência organizado pelo Fórum de Segurança da ONU aponta que houve 59.080 homicídios, no Brasil, em 2015. O mesmo mapa aponta que 54,1% das vítimas de homicídio eram jovens de 15 a 24 anos de idade em 2015. Em 2015, enquanto a média de homicídios da população total era de 28,9 mortes para cada 100 mil habitantes, a taxa de homicídio da população jovem era de 60,9 mortes para cada 100 mil habitantes.

Violência contra as mulheres

O Brasil está entre os cinco países com maior índice de violência contra a mulher no mundo. Essa violência pode se manifestar de diversas formas, como Assédio sexual, Violência moral, Violência patrimonial, Transfobia, Violência física, Racismo.

A violência contra mulheres no Brasil segue sendo uma das faces mais cruéis da violação dos direitos humanos. Os dados epidemiológicos, colhidos por sistemas como o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), o DataSUS e pesquisas nacionais como o Atlas da Violência, revelam uma realidade alarmante e persistente, que atravessa classes sociais, faixas etárias e territórios.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de violência física a cada quatro minutos no país. Em 2023, mais de 245 mil casos de violência doméstica foram registrados — um número que, embora elevado, ainda representa uma subnotificação preocupante, uma vez que muitas mulheres não denunciam por medo, dependência econômica ou ausência de suporte institucional.

Dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2024, mostraram um crescimento muito significativo de violência contra mulheres. Nessa perspectiva, compreende-se o feminicídio como a parte final de um processo de agravamento da violência (Pasinato, 2016 *apud* FBSP, 2023). Em 2023 foi registrada a maior taxa de feminicídios na Região Centro-Oeste, com 2,0 casos para cada 100 mil mulheres, sendo que no Brasil a média é de 1,4 por 100 mil, e o estado da federação com maior crescimento foi o Distrito Federal, contabilizando 59,4% das mortes violentas femininas classificadas no tipo penal específico. O feminicídio é uma violência evitável se forem empregadas políticas públicas de prevenção, proteção e acolhimento das vítimas dos diversos tipos de violência contra as meninas e mulheres (FBSP, 2023).

O perfil sociodemográfico das mulheres vítimas de violência compreende uma maioria de mulheres pretas e pardas, sendo 61,1% nos casos de feminicídio e 68,9% nos demais assassinatos. A faixa etária prevalente é entre 14 e 18 anos para os feminicídios e entre 18 e 29 anos nos demais casos de morte violenta (FBSP, 2023). Diferente dos homens, portanto, cujo risco de ser vítima de morte violenta cai consideravelmente a partir dos 29 anos, para as mulheres a dinâmica dos feminicídios implica em um elevado risco por pelo menos mais 15 anos. Por último, nos casos de feminicídio, o local da violência é majoritariamente a residência da vítima (7 em cada 10); nos demais assassinatos, a via pública foi o lugar mais frequente, representando o local da morte de 36,5% dos casos, seguido da residência (34,9%) (FBSP, 2023).

Violência Sexual

O 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2023) mostrou que em 2022 os casos de estupro somaram 18.110 vítimas, com um crescimento de 7% em relação ao ano anterior; já os casos de estupro de vulnerável, com um total de 56.820 vítimas, tiveram incremento de 8,6% (36,9 casos em cada 100 mil habitantes) - totalizando 74.930 vítimas (FBSP, 2023).

Estes números correspondem aos casos que foram notificados às autoridades policiais e, portanto, representam apenas uma fração da violência sexual experimentada por mulheres e homens, meninas e meninos de todas as idades. A subnotificação está presente em levantamentos em todo o mundo. Estudos apontam que apenas 8,5% dos estupros no Brasil são reportados às polícias e 4,2% pelos sistemas de informação da saúde. Assim, segundo a estimativa produzida pelos autores, o patamar de casos de estupro no Brasil é da ordem de 822 mil casos anuais (FBSP, 2023).

Quanto ao perfil sociodemográfico, pessoas pretas e pardas, aparecem como as principais vítimas da violência sexual (56,8%), com crescimento da proporção em relação a 2021. No que diz respeito à faixa etária, as crianças e adolescentes continuaram sendo as maiores vítimas da violência sexual.

Sobre a autoria dos crimes, 82,7% dos abusadores, o estudo mostrou que eram conhecidos das vítimas, sendo que, entre as vítimas de 14 anos ou mais, em 24,4% dos casos a violência foi praticada por parceiro ou ex-parceiro íntimo, 37,9% por parentes ou familiares e 15% por outros conhecidos (FBSP, 2023). Em relação ao local em que ocorreu o crime, a residência aparece com mais frequência: em média, 68,3% dos casos somados de estupro e estupro de vulnerável ocorreram na residência da vítima. A via pública é apontada como local da ocorrência da violência sexual em 17,4% dos registros de estupro e em 6,8% dos estupros de vulnerável. Em média, 1 em cada 10 estupros/estupros de vulnerável no Brasil ocorreram em via pública (FBSP, 2023).

Violência contra crianças e adolescentes

Acidentes e violências, segundo o MS, representam o maior problema de saúde pública entre crianças e adolescentes em países em desenvolvimento, sendo este um dos grupos populacionais mais vulneráveis à ocorrência de abusos físicos, emocionais, sexuais e de negligência. É comum que a criança não tenha sequer capacidade de reconhecer o abuso sofrido, seja pela falta de conhecimento sobre o tema ou por proximidade com o agressor. Isto porque é possível que a criança tenha algum

sentimento de amor ou mesmo lealdade pelo autor do abuso, que pode ser praticado por pessoas próximas como pais, padrastos, avôs e outros familiares (Conte; Simon, 2018 *apud* FBSP, 2023). Além disso, o abusador tende a manipular a criança com ameaças ou subornos, promovendo o silêncio da vítima. Por fim, o sentimento de culpa ou mesmo vergonha costuma estar presente na criança, que acaba por não revelar nada aos familiares (FBSP, 2023).

Em 2023, o Brasil registrou uma média alarmante de 196 casos diários de violência física contra crianças e adolescentes, totalizando mais de 71 mil notificações ao longo do ano. Os dados, fornecidos pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, revelam que os adolescentes de 15 a 19 anos foram as principais vítimas, com 35.851 registros.

Em relação à violência sexual, entre 2015 e 2021, foram notificados 202.948 casos no Brasil, sendo 83.571 contra crianças e 119.377 contra adolescentes. O ano de 2021 registrou o maior número de notificações, com 35.196 casos. A maioria dos agressores era do sexo masculino, responsáveis por mais de 81% dos casos contra crianças de 0 a 9 anos e 86% contra adolescentes de 10 a 19 anos. As vítimas eram predominantemente do sexo feminino: 76,9% das notificações de crianças e 92,7% das notificações de adolescentes nessas faixas etárias ocorreram entre meninas.

Segundo o Ministério da Saúde (2023), a **violência sexual** contra crianças e adolescentes compreende uma estatística abrangente a todas as faixas etárias: 10,4% das vítimas de estupro eram bebês e crianças com idade entre 0 e 4 anos; 17,7% das vítimas tinham entre 5 e 9 anos e 33,2%, entre 10 e 13 anos. Ou seja, 61,4% tinham no máximo 13 anos. Além da faixa etária, é relevante salientar que há desigualdade racial entre as vítimas em todas as faixas etárias: vítimas negras (pretas e pardas) são a maior parte em praticamente todas as idades. Quanto às pessoas autoras de violências, 61,4% são parentes ou familiares e 21,6% são conhecidos sem relação de parentesco (FBSP, 2023).

Em sequência, a **negligência e abandono** são estão entre as modalidades mais comuns de violência contra crianças e adolescentes e se caracterizam pela omissão por parte dos responsáveis legais e da sociedade em proverem as necessidades de uma criança, incluindo questões financeiras, mas também emocionais (FBSP, 2023). Vale destacar que a desigualdade social e as questões decorrentes das carências socioeconômicas que estão fora do controle dos pais não necessariamente significam casos de negligência. É sobretudo a prática abusiva e a omissão consciente que importam na análise dos casos de negligência. Os subtipos mais frequentes são abandono material – que inclui o não pagamento de pensão alimentícia – e abandono de incapaz (FBSP, 2023).

Quanto aos **crimes de maus tratos**, em 2022 foram documentados 22.527 casos entre 0 a 17 anos (45,1 registros por 100 mil habitantes), um aumento de 13,8% em relação a 2021. A faixa de 5 a 9 anos permaneceu sendo a faixa etária com mais vítimas de maus-tratos, totalizando 7.697 registros, seguida pelas faixas de 0 a 4 anos e 10 a 13 anos (FBSP, 2023). Em relação ao sexo das vítimas, nas faixas etárias de 0 a 4 anos e 5 a 9 anos, a maior parte das vítimas é do sexo masculino. A partir dos dez anos, esse perfil se inverte e as vítimas do sexo feminino passam a ser maioria. Possivelmente, esse aumento se relaciona com o aumento de crimes sexuais com vítimas dessas faixas etárias (FBSP, 2023). O perfil racial também muda à medida do perfil etário: a desigualdade racial é quase inexistente nas faixas de 0 a 4 anos e 5 a 9 anos; na faixa de 14 a 17 anos, 54,9% das vítimas são pretas ou

pardas; por fim, considerando todas as faixas etárias, em 2022, 50,6% das vítimas são de raça/cor negra (FBSP, 2023).

A **violência física** também possui alto nível de reincidência, sendo caracterizada como uma experiência de longa duração na vida da vítima. Dificuldades escolares, ansiedade, reprodução da violência e sequelas provenientes das lesões são algumas das consequências já mapeadas pela literatura especializada e dão conta da gravidade desses atos, apesar de muitas vezes ainda serem concebidos por muitos como instrumentos educacionais válidos e legítimos (FBSP, 2023).

Todos os tipos de violência podem ter como ápice e trágico desfecho uma morte violenta – o que também abrange a violência urbana e suas interfaces. O número de **assassinatos** de crianças e adolescentes segue sendo um problema grave, somando quase 2.489 mortes no ano de 2022, mantendo um patamar de quase sete casos por dia (FBSP, 2023). Chama a atenção a proporção de feminicídios entre as vítimas de 0 a 11 anos, que compreende 11,4% dos casos. Dentre as vítimas de 12 a 17, por outro lado, destaca-se a quantidade de mortes decorrentes de intervenção policial: foram 358 vítimas em 2022, um aumento de 17% de um ano para o outro, razão pela qual, no ano em questão, as mortes por policiais foram responsáveis por 15,7% do total de crimes letais entre adolescentes. Dentre as vítimas de 0 a 11 anos, 45,9% são do sexo feminino e 54,1% do sexo masculino, enquanto dentre as vítimas de 12 a 17 anos, 89,7% das vítimas são do sexo masculino e apenas 10,3%, do sexo feminino (FBSP, 2023).

O perfil racial também sofre drástica alteração a depender da faixa etária. Enquanto 67,1% das vítimas de 0 a 11 anos eram pretas e pardas, esse percentual sobe para 85,1% na faixa etária de 12 a 17 anos. Entre os adolescentes, a distinção é absolutamente evidente e implica que 8 em cada 10 mortes violentas de adolescentes vitimem pessoas pretas e pardas no país (FBSP, 2023). Em termos de local da ocorrência do crime, entre as crianças, o percentual de fatos dentro das residências é de 65,4% e, na via pública, de 15,4%. Esses percentuais se invertem quando as vítimas possuem entre 12 e 17 anos, de modo que os fatos ocorridos nas vias públicas sobem para 59,4% do total e aqueles perpetrados dentro das residências caem para 15,8% (FBSP, 2023).

Da mesma forma como Estado e sociedade têm se unido em prol de uma luta contra a violência contra as mulheres – implicando no aumento de mecanismos de proteção e prevenção da violência contra as crianças e os adolescentes precisa ser eleita como fenômeno a ser combatido por todos. É necessário ampliar as estratégias de prevenção dessas violências como prevê o artigo 227 da Constituição: as crianças devem ser prioridade absoluta.

Dados do Distrito Federal

No âmbito da Secretaria de Saúde do DF, os dados epidemiológicos sobre violências interpessoais e autoprovocadas são monitorados e registrados pelo Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências (NEPAV) da SES DF, a partir das notificações do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan). Os dados do NEPAV são sistematizados sob o viés do tripé epidemiológico: tempo (quadrimestre), lugar (residência do usuário - para vinculação com o serviço de saúde de referência) e pessoa (organizado em ciclos de vida) (DISTRITO FEDERAL, 2024b). Tal diagnóstico

epidemiológico da violência favorece a estruturação da rede de saúde no acolhimento e atendimento às demandas das pessoas em situação de violência, além da construção de políticas públicas mais assertivas na atenção integral à saúde deste público.

De acordo com os dados do NEPAV, entre 2014 e 2023, foram registradas 62.127 notificações de violência. Destas, 12.169 foram contabilizadas apenas em 2023. A média é de 5.959 notificações ao ano e 397,2 ao mês, representando 13,1 notificações ao dia. Mais de 60% das notificações são oriundas da atenção secundária à saúde. A taxa de notificação demonstra a capilaridade da notificação no território, com aumento médio de 9,4% ao ano ao longo dos últimos 10 anos. Neste período, em geral, observou-se o aumento do número de tentativas de suicídio (29,6%) e redução da violência sexual (24,0%) (DISTRITO FEDERAL, 2024b).

Somente no último quadrimestre de 2023, foram notificados 3.938 casos de violência interpessoal e autoprovocada. Predominou a violência em indivíduos do ciclo de vida das pessoas adultas (49,1%), do sexo feminino (74,9%), de raça/cor negra (66,2%), com ensino médio completo (6,6%). As notificações de pessoas em situação de violência eram residentes da zona urbana (92,1%) no Distrito Federal (95,2%) (DISTRITO FEDERAL, 2024b).

As notificações se concentraram em indivíduos solteiros (39,1%) e casados (10,8%). Heterossexuais foram 37,2%; observou-se apenas 1,2% das fichas de notificação com declaração da identidade de gênero (DISTRITO FEDERAL, 2024b) - demonstrando importante defasagem no preenchimento do quesito pelos profissionais notificadores. Houve maior frequência em indivíduos com deficiências e/ou transtornos (39,4%) e, destes, com transtorno mental (23,9%). As regiões administrativas de maior incidência são Ceilândia (9,4%), Samambaia e Planaltina (ambos com 5,8%) (DISTRITO FEDERAL, 2024b).

A motivação da violência mais frequentemente informada foi o sexismo (10,5%). A residência da vítima é o local de maior ocorrência das situações de violência (73,1%). A recorrência foi presente em 39% dos casos - o que corresponde ao fator preditivo de vulnerabilidade para situações de violência. As tentativas de suicídio representaram 39,6%, seguidas da violência física (23,0%) e da violência sexual (12,1%) (DISTRITO FEDERAL, 2024b).

Quando se trata de violência sexual, precisa-se verificar os procedimentos previstos após as ocorrências, 20,8% recebeu profilaxia para as infecções sexualmente transmissíveis, 19,2% para o HIV e 13,9% para a Hepatite B. Realizou-se coleta de exames de sangue (20,2%), coleta de secreção vaginal (2,3%) e coleta de sêmen (0,8%), uso da contracepção de emergência (12,9%), sendo estas mulheres dos ciclos de vida de adolescentes, jovens e pessoas adultas.

É necessário salientar, ainda, as informações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Ministério da Saúde (MS), que estimam que entre 5% e 7% dos casos de violência sexual podem resultar em gestação, estimativa que aumenta para 15% quando se trata do início da idade reprodutiva, entre 10 e 14 anos. Nessa senda, tendo em vista as disposições do Código Penal Brasileiro (1940), pessoas em situação de gravidez decorrente de violência sexual têm direito à interrupção gestacional prevista em lei - o que torna imprescindível a análise epidemiológica e a avaliação da articulação da rede de saúde na promoção e garantia deste direito, levando em conta as repercussões biopsicossociais da gestação decorrente de violência sexual.

A série histórica realizada pelo NEPAV, que analisou as notificações de violência interpessoal e autoprovocada com afirmação de estupro como tipo de violência e aborto previsto em lei como procedimento realizado, demonstrou que no período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2022, registraram-se 438 notificações de violência sexual, estupro e aborto previsto em lei (0,7%, n=438/62.572) (DISTRITO FEDERAL, 2023).

A idade dos indivíduos variou de 9 a 58 anos, moda de 23 anos de idade (7,3%). Os episódios de violência sexual tipo estupro e informação positiva de procedimento de aborto permitido por lei foram mais frequentes em indivíduos de raça/cor parda, com 43,4%. A regional de saúde Sudoeste apresentou maior frequência para violência sexual tipo estupro e informação positiva de procedimento de aborto permitido por lei (13,5%) e menor percentual na regional de saúde Sul (1,6%). Samambaia foi a região administrativa com maior frequência de notificações de violência sexual tipo estupro e informação positiva de procedimento de aborto permitido por lei, com 4,3%, seguida pelo Plano Piloto, com 3,4%, e Ceilândia, com 3,4% (DISTRITO FEDERAL, 2023).

A recorrência de violência sexual tipo estupro e informação positiva de procedimento de aborto permitido por lei esteve frequente em 16,4% das notificações. O vínculo/grau de parentesco mais frequente registrado de violência sexual tipo estupro e informação positiva de procedimento de aborto permitido por lei, tratava-se de desconhecidos, com 61,1%, seguido por amigos e conhecidos, com 19,2% (DISTRITO FEDERAL, 2023).

É necessário relacionar os dados nacionais e as ponderações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública acerca da subnotificação, compreendendo que tanto a incidência de violência sexual não é adequadamente aferida, quanto o número de encaminhamentos aos serviços especializadosl são insuficientes, não alcançando a todas as pessoas que podem usufruir do direito, nem mesmo a nível de informação (DISTRITO FEDERAL, 2023).

A violência contra a mulher e o número de feminicídios é um foco importante de atenção, uma vez que a capital federal alcançou a taxa mais alta deste crime em todo o território nacional. Desde a tipificação do crime, em 2015, através da Lei do Feminicídio, ações que visam à qualidade da notificação e do enfrentamento desse tipo penal vem sendo implementadas.

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), em 2022, foram contabilizados 17 casos e em 2023, 34 feminicídios ocorreram no Distrito Federal, um aumento de 100%. E as tentativas de feminicídio também passaram de 37 em 2022, para 78 em 2023, um crescimento de 110% (DISTRITO FEDERAL, 2024a). Diante deste cenário, em 2021 foi instituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), denominada CPI do Feminicídio, dedicada à compreensão dos dados acerca do fenômeno de violência e à elaboração de estratégias intersetoriais no âmbito da administração pública para o enfrentamento do problema.

A CPI do Feminicídio analisou os Relatórios sobre Ocorrências Registradas como Feminicídio e Feminicídios consumados no DF, entre 2015 e 2021, registradas pela SSP DF, evidenciando a prevalência dos feminicídios em contexto de violência doméstica contra a mulher por autor conhecido da vítima - entre 2019 e 2020 (DISTRITO FEDERAL, 2021).

A CPI também apontou que, dos 50 feminicídios e 149, aproximadamente 80% das vítimas eram pardas ou negras, sendo 38% esposas ou companheiras do agressor, 31% ex-esposas ou ex-companheiras e 11% namoradas. Ademais, dados da Segurança Pública (DISTRITO FEDERAL, 2024a), apontam que das 34 mulheres assassinadas por feminicídio no DF em 2023, 85,3% eram mães. 67,6% dos crimes ocorreram dentro de casa e 26% ocorreram em ruas, praças ou estacionamentos. Como motivação para o crime, o ciúme (44%) foi o que mais apareceu no levantamento, seguido por término de relacionamento (29%). Também é relevante destacar que 67,6% das vítimas de feminicídio sofriam diversas formas de violência antes do crime, entretanto 61,8% não haviam registrado ocorrência policial contra o suspeito (DISTRITO FEDERAL, 2024a). Das que haviam registrado boletim de ocorrência, é alto o número de mulheres que estavam sob Medidas Protetivas de Urgência no momento em que o crime ocorreu, o que indica uma falha grave no enfrentamento da violência e na proteção dessas mulheres.

Ante ao exposto, esta Linha de Cuidado se propõe a uma abordagem das vulnerabilidades sociais, utilizando-se da epidemiologia crítica para nortear a organização da rede de saúde e da elaboração, gestão e execução da política pública de saúde com vistas ao cuidado integral às pessoas em situação de violência.

5. Público alvo

Esta LC destina-se a trabalhadores/as e gestores/as da Rede de Cuidados e Atenção da SES/DF para qualificação da atenção a pessoas em situação de violência sexual, doméstica e familiar.

6. Rede de Atenção à Saúde

De acordo com o MS, conceitua-se Redes de Atenção à Saúde (RAS) como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 2017). Rompendo com a lógica da fragmentação do cuidado, ou mesmo da hierarquização entre níveis de atenção, a lógica de redes pressupõe que os diferentes serviços de saúde estão vinculados por:

> uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – e com responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a população” (MENDES, 2011, p. 82).

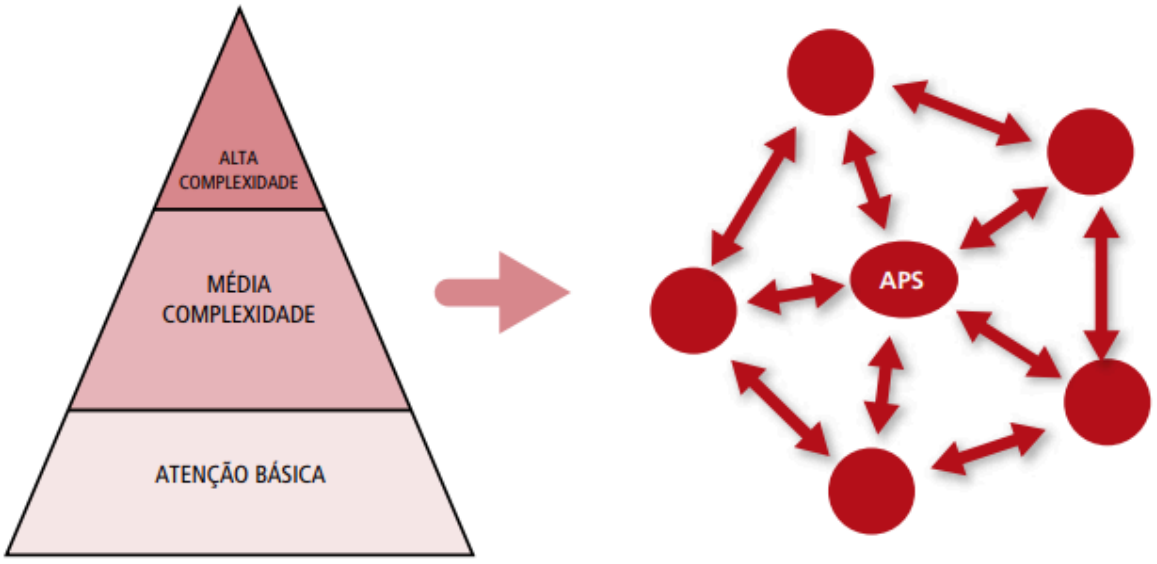


Figura 1. Diferença entre o sistema piramidal e hierárquico e as Redes de Atenção à Saúde, poliárquicas, tendo a APS como ordenadora do cuidado. (MENDES, 2011, p. 84) [Mendes, Eugênio Vilaça As redes de atenção à saúde. / Eugênio Vilaça Mendes. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 549 p.: il. ISBN: 978-85-7967-075-6]

Na perspectiva de horizontalidade da atenção à saúde, a linha de cuidado estabelece o itinerário da atenção à saúde em todos os seus níveis, respeitando especificidades de cada um destes, bem como o papel da APS como ordenadora deste processo. Seja no âmbito da gestão central da política de saúde, seja nos territórios das sete regiões de saúde do DF, a RAS é formada por pontos de atenção intrasetoriais que possuem o objetivo comum de prestar atenção integral às pessoas em situação de violência.

No âmbito da gestão, a SES conta com a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência (RAV), que tem por objetivo elaborar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações de enfrentamento e prevenção da violência e promoção da cultura da paz previstas na Política Nacional de Redução de Morbimortalidade de Acidentes e Violência. A partir da lógica de redes, a RAV possui representação dos três níveis de atenção, sendo uma de suas competências:

> Planejar, executar, coordenar e avaliar ações de atenção integral às pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica, na rede assistencial da SES, em consonância com a Linha de Cuidado e as diretrizes preconizadas;(PORTARIA 108 DE 20 DE MARÇO DE 2023).

Para além da perspectiva gestora e constituindo a RAV, as regiões de saúde contam com os Núcleos de Prevenção e Assistência a Situações de Violência (NUPAV) como componentes estratégicos da atenção às pessoas em situação de violência nos territórios. Estes Núcleos estão vinculados diretamente às Superintendências das regiões de saúde, e cabe a eles planejar, executar, coordenar e avaliar ações de promoção, prevenção e atendimento à população em situação de violência na Região.

No âmbito da assistência, o NUPAV coordena as ações dos Centros de Especialidades para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (CEPAV), bem como prestar apoio matricial em todos os níveis de atenção, articula e executa ações de Vigilância Epidemiológica na notificação e análise de informação sobre violência nas regiões de saúde.

O NUPAV exemplifica, portanto, a articulação de rede na atenção às violências no campo da saúde. Identifica-se neste serviço o entrelaçamento da rede intrasetorial, prevista institucionalmente e composta pelos pontos de atenção descritos no Quadro 1.

Quadro 1: Composição da Rede Atenção à Saúde (RAS)

Nível de Atenção	**Ponto de Atenção**
Atenção Primária à Saúde	Unidades Básicas de Saúde (UBS) Unidades Básicas de Saúde Prisional (UBSP) Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde - CERPIS
Atenção Secundária à Saúde	Centro de Especialidades para Atenção às pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (CEPAV) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em suas diversas modalidades (CAPSi, CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD e CAPS AD III) Policlínicas, Centros Especializados em Reabilitação (CER) Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) Centro Orientação Médico Psicopedagógico (Compp) Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Atenção ao Adolescente em Família (Adolescentro) Centro Especializado em Saúde da Mulher (CESMU) Ambulatório da Diversidade de Gênero - Ambulatório Trans Rede pré-hospitalar fixa: Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 horas (IGES) Programa de Interrupção Gestacional Prevista em Lei (PIGL/HMIB) Outros centros especializados da AASE

Nível de Atenção	Ponto de Atenção
Atenção Terciária à Saúde	Pré-hospitalar móvel: Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiro (CBM) Hospitais gerais Atenção domiciliar Hospitais de maior complexidade (Hospital da Criança, HBDF) URD (HMIB, HSVP, HAB)

Cabe ressaltar que os Serviços das Unidades Básicas da Saúde Prisional são estruturados como pontos da Rede de Atenção à Saúde – RAS do DF, em que a SES/DF, a Secretaria de Segurança Pública – SSP/DF e a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAPE/DF traçam diretrizes para elaboração de Projetos e Programas específicos de assistência à saúde das pessoas privadas de liberdade, conforme previsto na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional – PNAISP (BRASIL, 2014).

Os pontos de atenção dispostos no Quadro 1 devem promover cuidados à pessoa em situação de violência em todas as suas dimensões:

- Realizar o **acolhimento** e o **atendimento** de acordo com as normativas técnicas e legais mais atualizadas;

- Registrar a **notificação** do caso suspeito ou confirmado, mediante o preenchimento da Ficha de Notificação Compulsória (Anexo I), informar em prontuário e inserir os dados no Sinan;

- Articular, promover e orientar o **seguimento em Rede** Intra e Intersetorial, conforme demandas identificadas e critérios de inclusão em cada serviço;

- Promover a vinculação de todos os usuários à Atenção Primária à Saúde, de acordo com as diretrizes de regionalização e territorialização, a partir da longitudinalidade, do acolhimento e do encaminhamento responsável;

- Em casos de **violência sexual**:

  - Ocorridas até 72 horas, encaminhar a pessoa em situação de violência imediatamente ao Hospital de Referência ou Unidade Básica de Saúde habilitada à dispensação da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), conforme nota técnica vigente, e dispensação da contracepção de emergência. Ressalta-se que a prescrição da PEP pode ser feita em qualquer UBS, com posterior encaminhamento para a unidade dispensadora, se necessário, para início da PEP em até 72h (vide fluxograma);
  - Nos casos crônicos ou ocorridos há 72 horas ou mais, realizar encaminhamento responsável à UBS de referência para acompanhamento sorológico e rastreamento das demais ISTs, dada a inviabilidade da PEP;

- Em caso de gestação decorrente de violência sexual, em todos os pontos da rede de atenção à saúde, são dadas orientações acerca das alternativas legais mediante essa situação: manutenção da gestação para vinculação à família; manutenção da gestação para entrega legal à adoção; interrupção de gestação decorrente de estupro, de até 20 semanas, por meio do PIGL/HMIB (ver item 6.2);
- Atentar-se ao fato de que qualquer relação sexual ou ato libidinoso praticado contra crianças e adolescentes de até 14 anos incompletos é considerada, pelo Código Penal Brasileiro, estupro de vulnerável, passível de notificação compulsória, comunicação externa, estando a vítima apta a usufruir de todos os direitos e condutas pertinentes à situação de violência sexual mencionados no item acima;

- Promover o devido atendimento nos casos de lesões mais graves que exijam atendimento especializado de urgência e emergência, como: queimaduras de maior gravidade; traumas cranianos ou fraturas; suspeita de lesão de órgãos internos; trauma facial, traumatismo dentário, estado de choque emocional. Encaminhar para serviços especializados;

- Realizar comunicação externa da situação de violência para órgãos de proteção e responsabilização da Rede Intersetorial (para maiores informações vide item 10).

É importante, também, levar em consideração o ponto de atenção onde a pessoa em situação de violência se encontra, os dispositivos da rede oferecidos, a singularidade de cada usuário/a do SUS, bem como a lógica do compartilhamento do cuidado (MENDES, 2011). Além desses aspectos gerais, esta linha de cuidado tratará de cada dimensão do cuidado pertinente à atenção integral à pessoa em situação de violência.

6.1. Atenção Primária à Saúde – APS

A Atenção Primária à Saúde é a principal porta de entrada no SUS e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Sua atuação como coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços reforça a importância deste nível de atenção, o qual tem na Estratégia Saúde da Família (ESF) sua estratégia prioritária de execução, expansão e consolidação.

Pode-se mencionar que, no conjunto de ações sob sua responsabilidade, estão desde a promoção à recuperação da saúde, além da vigilância de doenças e agravos mais relevantes dos indivíduos, populações e territórios, conforme consta na Política Nacional de Atenção Básica e na portaria regulamentadora da APS no DF.

Outro ponto de destaque está explicitado em um de seus atributos: a longitudinalidade do cuidado, que pressupõe a construção de vínculo com o indivíduo, família e comunidade, e, de acordo com as diretrizes do SUS, a atuação a partir da regionalização e territorialização. É esta potencialidade do acompanhamento contínuo que faz da APS crucial na atenção à pessoa em situação de violência, pois possibilita a identificação de situações de risco e/ou de violência estabelecida oportunamente.

As Equipes de Saúde da Família (eSF), Equipes de Saúde Bucal (eSB), equipes multiprofissionais (e-Multi) e equipes de Consultório na Rua (eCR) possuem características privilegiadas pela inserção e interação territorial e pela abordagem comunitária em saúde, que permitem utilizar

ferramentas de seu processo de trabalho na identificação, notificação, condução e seguimento de casos suspeitos ou confirmados dos mais diversos tipos de violência. Visitas domiciliares, atendimentos individuais, atividades coletivas e matriciamentos são oportunidades de verificação de fatores de risco, sinais de alerta, casos suspeitos ou confirmados, bem como de educação popular e permanente em saúde para a abordagem integral às situações de violência.

No contexto das vulnerabilidades sociais, muito presentes em territórios cobertos pela APS, as equipes devem se atentar para sinais e contextos de violência crônica, dos mais diversos tipos e, assim, traçar ações intra e intersetoriais para seu enfrentamento.

Cabe, ainda, ressaltar a especificidade das eAPP (equipes de atenção primária prisional), pois estas possuem um processo de trabalho distinto das demais equipes de atenção primária. Neste sentido, é necessária a articulação com outras Secretarias e órgãos de controle para as ações de saúde. É imprescindível a notificação e monitoramento das violências ocorridas nas Unidades Prisionais para intervenções assertivas e promoção da cultura da paz.

A atenção integral à pessoa em situação de violência na APS não pode prescindir da longitudinalidade, do acolhimento e da humanização. É nesse contexto, portanto, que o tema da violência deve ser pautado em reuniões de colegiado das equipes, UBS e regiões de saúde para o diálogo entre os profissionais de diferentes áreas a partir de cada realidade territorial, a fim de implementar e qualificar os atendimentos e ações de promoção à saúde.

Atendimentos na Atenção Primária – APS

O atendimento à pessoa em situação de violência na APS deve partir do acolhimento humanizado, da escuta qualificada e do conhecimento atualizado dos serviços ofertados pelas redes intra e intersetorial do DF.

Atendimentos programados e atendimentos à demanda espontânea devem ser oportunidades para a identificação de sinais de violência, mesmo que a queixa inicial pela busca do serviço não tenha sido referente a esta temática. Aqui é relevante pontuar que o atendimento à demanda espontânea deve ser sempre encarado como uma possibilidade de acolher necessidades em saúde de uma pessoa, ainda que esta não seja do território de abrangência. Portanto, o atendimento à demanda espontânea deve ser assertivo, oportuno e resolutivo. Caso este atendimento se torne um cenário de identificação de uma situação de violência, as condutas clínicas imediatas e de médio a longo prazo (atendimento, vacinação, prescrições e orientações), bem como a notificação da violência e o encaminhamento responsável à unidade de referência devem ser prontamente realizadas.

ATENÇÃO: Pode ser comum que o usuário quando em situação de violência procure uma UBS de outro território em busca de cuidados e orientações, visto o sentimento de insegurança e vergonha. Por este motivo, os profissionais devem ser receptivos e as portas das UBS devem estar sempre abertas ao atendimento às demandas espontâneas.

Nos casos de identificação de fatores de risco ou sinais de alerta para suspeição de violência em contextos de visita domiciliar, recomenda-se ao profissional, após esta identificação, a discussão com sua eSF, apoiada pela e-Multi, a fim de subsidiar as condutas intra e intersetoriais, que precisam ser apoiadas pela gerência e pela supervisão da UBS, com vistas a institucionalizar o seguimento do caso e resguardar a segurança profissional e o vínculo entre equipe e usuário. Tal abordagem em equipe favorece a impessoalidade e se utiliza da não obrigatoriedade de identificação do profissional nas notificações, colaborando para assegurar a integridade do profissional.

O registro detalhado das situações identificadas deve constar no prontuário do paciente e é imprescindível para a continuidade do cuidado e o respaldo profissional, consistindo em uma ferramenta de prevenção à revitimização. Ressalta-se, portanto, que, ao efetuar o registro no prontuário, o profissional deve resguardar a devida cautela quanto à exposição da pessoa.

Conforme será abordado no item 7.3. desta linha de cuidado, o preenchimento da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada e inserção no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan) é de caráter compulsório, imediato e institucional, bem como é um **DEVER** do profissional de saúde notificar todos os casos suspeitos ou confirmados de violência identificados no âmbito da APS.

Para identificar a suspeição ou constatação de uma situação de violência, há sinais e sintomas que podem direcionar a abordagem profissional e a identificação dos casos (D'OLIVEIRA, A.F.P.L et al, 2019). No sentido de promover conhecimento e auxiliar os profissionais quanto à identificação e suspeita, os Quadros 1, 2, 3 e 4 listam queixas que podem estar relacionadas à violência contra mulheres, crianças, adultos e pessoas idosas, respectivamente:

Quadro 1: Sinais e sintomas sugestivos de possível violência em mulheres

1 - Saúde mental
Estresse, ansiedade, depressão, ideação suicida
Comportamentos auto prejudiciais: abuso de álcool e drogas
Insônia, transtorno de estresse pós- traumático, síndrome do pânico
Problemas emocionais e comportamentais das crianças
2 - Saúde sexual e reprodutiva
Lesões repetidas ou mal explicadas
ISTs de repetição e HIV
Gestações não desejadas
Dor pélvica, dor durante o ato sexual e demais problemas sexuais
Infecções urinárias de repetição
Atraso no início ou não realização do pré-natal
3 - Queixas gerais

Dores crônicas: gastrointestinais, cefaleias
Consultas repetidas sem diagnóstico claro
Parceiro intrusivo nas consultas
Falta constante à própria consulta e das crianças

Fonte: Protocolo de Atendimento à Mulheres em Situação de Violência para APS. Elaborado pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e University of Bristol, 2019.

QUADRO 2: Sinais e sintomas sugestivos de possível violência em crianças e adolescentes

ALTERAÇÕES/SINAIS DA VIOLÊNCIA	CRIANÇA			ADOLESCENTE 10 A 19 ANOS
	0 a 11 MESES	1 a 4 ANOS	5 a 9 ANOS	
Choro sem motivo aparente				
Irritabilidade frequente, sem causa aparente				
Olhar indiferente e apatia				
Tristeza constante				
Demonstração de desconforto no colo				
Reações negativas exageradas a estímulos comuns ou imposição de limites.				
Atraso no desenvolvimento, perdas ou regressão de etapas atingidas				
Dificuldades na amamentação, podendo chegar à recusa alimentar, e vômitos persistentes				
Distúrbios de alimentação				
Enurese e encoprese				
Atraso e dificuldades no desenvolvimento da fala				
Distúrbio do sono				
Dificuldades de socialização e tendência ao isolamento				
Aumento da incidência de doenças, injustificáveis por causas orgânicas, especialmente as de fundo alérgico				
Afecções de pele frequentes, sem causa aparente				

Distúrbios de aprendizagem, levando ao fracasso na escola				
Comportamento extremo de agressividade ou destrutividade				
Ansiedade ou medo ligado a determinadas pessoas, objetos ou situações				
Pesadelos frequentes, terror noturno				
Tiques ou manias				
Comportamentos obsessivos ou atitudes compulsivas				
Baixa autoestima e autoconfiança				
Automutilação, escarificações, desejo de morte e tentativa de suicídio				
Problemas de atenção ou dificuldade de concentração				
Sintomas de hiperatividade				
Comportamento de risco, levando a traumas frequentes ou acidentes				
Uso de álcool e outras drogas				
Infecções sexualmente transmissíveis				
Infecção urinária de repetição				
Hiperemia ou secreção uretral ou vaginal				
Quedas e lesões inexplicáveis				
Lesões físicas (manchas roxas, fraturas, queimaduras, feridas), às vezes em vários estadiamentos				

Observação: os espaços pintados indicam a presença do sinal/sintoma sugestivo de violência no respectivo ciclo de vida. **Fonte:** Guia de Vigilância em Saúde. - 6. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2023.

Quadro 3: Sinais e sintomas sugestivos de possível violência em adultos (20 a 59 anos)

Afastamento, isolamento, tristeza, abatimento profundo.
Automutilação choro sem causa aparente.
Comportamento muito agressivo ou apático, autodestrutivo, submisso, tímido.

Dificuldade de concentração no trabalho.
Distúrbios do sono.
Queixas crônicas inespecíficas, sem nenhuma causa física óbvia.
Doenças não tratadas, infecções sexualmente transmissíveis.
Desnutrição.
Gravidez indesejada.
Demora em iniciar o pré-natal.

Fonte: Guia de Vigilância em Saúde. - 6. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2023.

Quadro 4: Sinais e sintomas sugestivos de possível violência em pessoas idosas (≥60 anos)

INDICADORES RELATIVOS ÀS PESSOAS IDOSAS				INDICADORES RELATIVOS ÀS PESSOAS QUE CUIDAM DAS PESSOAS IDOSAS
FÍSICOS	**COMPORTAMENTAIS E EMOCIONAIS**	**SEXUAIS**	**FINANCEIROS**	
Queixas de ter sido fisicamente agredido	Mudanças no padrão da alimentação ou problemas do sono	Queixas de ter sido sexualmente agredido	Retiradas de dinheiro incomuns ou atípicas da pessoa idosa	Pessoa parece cansada ou estressada
Quedas e lesões inexplicáveis	Medo, confusão ou apatia	Roupas de baixo rasgadas, com nódoas ou manchadas de sangue	Retiradas de dinheiro que não estão de acordo com os meios da pessoa idosa	Parece excessivamente preocupada ou despreocupada
Queimaduras e hematomas em lugares incomuns ou de tipo incomum	Passividade, retraimento ou depressão crescente	Mudanças de comportamento inexplicáveis, tais como agressão, retraimento ou automutilação	Mudança de testamento ou de títulos de propriedade para beneficiar “novos amigos ou parentes”	Censura a pessoa idosa por certos atos, como a incontinência

<table>
<tr><td>Cortes, marcas de dedos ou outras evidências de dominação física</td><td>Desamparo, desesperança ou ansiedade</td><td>Queixas frequentes de dores abdominais; sangramentos vaginal ou anal inexplicáveis</td><td>Bens que faltam</td><td>Trata a pessoa idosa como criança ou de modo desumano</td></tr>
<tr><td>Medicações excessivamente repetidas ou subutilização de medicações</td><td>Declarações contraditórias ou outras ambivalências que não resultam de confusão mental</td><td>Infecções genitais recorrentes ou ferimentos em volta dos seios ou da região genital</td><td>A pessoa idosa “não consegue encontrar” joias ou pertences pessoais</td><td>Tem história de abuso de substâncias psicoativas ou de abusar de outras pessoas</td></tr>
<tr><td>Desnutrição ou desidratação sem causa relacionada a doença</td><td>Relutância para falar abertamente</td><td rowspan="4">Comportamento sexual que não combina com os relacionamentos comuns da pessoa idosa e/ou com a personalidade anterior</td><td>Atividade suspeita em conta de cartão de crédito</td><td>Não quer que a pessoa idosa seja entrevistada sozinha</td></tr>
<tr><td>Evidência de cuidados inadequados ou padrões precários de higiene</td><td>Fuga do contato físico, visual ou verbal com familiar ou cuidador(a)</td><td>Falta de conforto quando a pessoa idosa poderia arcar com ele</td><td>Responde de modo defensivo quando questionada; pode ser hostil ou evasiva</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Procura por assistência de saúde com profissionais ou serviços de saúde variados</td><td>A pessoa idosa é isolada pelas outras</td><td>Problemas de saúde não tratados</td><td rowspan="2">Cuida da pessoa idosa por um uso abusivo de longo período</td></tr>
<tr><td>Uso abusivo de álcool e/ou outras drogas</td><td>Nível de assistência incompatível com a renda e os bens da pessoa idosa</td></tr>
</table>

Fonte: Guia de Vigilância em Saúde. - 6. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2023.

Prevenção de Agravos e Promoção da Saúde

Considerando que a prevenção de agravos e a promoção da saúde são pilares da atuação da APS, destaca-se algumas ferramentas importantes na abordagem às situações de violência.

As atividades coletivas, por exemplo, são grandes potencialidades na abordagem comunitária da saúde, podendo ser utilizadas pela APS na identificação de riscos, sinais de alerta e, sobretudo, na

prevenção das situações de violência. Os grupos que reúnem segmentos populacionais específicos para educação em saúde podem abordar temas como comunicação não violênta (CNV), uso abusivo de álcool e outras drogas, reincidência de situações de violência e outras temáticas que influenciam diretamente nos contextos de violência.

Nessa senda, um tipo de atividade coletiva comumente desenvolvida nas UBS são os grupos de Planejamento Reprodutivo. No âmbito da promoção da saúde, a educação sexual e o planejamento reprodutivo são potenciais para a identificação, notificação, assistência e seguimento dos casos de violência, sobretudo de violência sexual. Dessa forma, além da conscientização sobre os tipos de violência, pode também ser um espaço para oferta de contracepção segura e para a educação popular em saúde acerca da saúde reprodutiva.

Outra grande ferramenta de prevenção de violências e promoção da saúde e da cultura de paz é o Programa Saúde na Escola (PSE). Utilizando-se da inserção territorial e da atuação intersetorial, o PSE atua tanto como um mecanismo de educação em saúde, abordando temas relacionados à prevenção de violências, do bullying, educação sexual, planejamento reprodutivo, redução de danos no uso de álcool e outras drogas; quanto como uma via de comunicação entre serviços de saúde e educação para identificação de casos de possíveis violências.

Todas as formas de prevenção de agravos e promoção da saúde cabem na recomendação da atuação multiprofissional na APS, reunindo eSF, eSB, e-Multi e eCR e eAPP na condução de iniciativas com foco territorial, familiar e comunitário, que auxiliem no diagnóstico situacional do território de abrangência da UBS, na produção de dados epidemiológicos e no uso de tais dados para subsidiar iniciativas, a partir do conhecimento profundo da realidade comunitária e da aplicação da expertise profissional na prevenção das violências e na promoção da cultura de paz.

6.2. Atenção Especializada em Saúde

A Atenção Especializada em Saúde (AES) consiste em um conjunto de ações, práticas, conhecimentos e técnicas assistenciais demarcado por processos de maior densidade tecnológica, expressando-se nas consultas especializadas e processos de apoio diagnóstico e terapêutico. Trata-se de um sistema de cuidados integrais cujo objetivo é a garantia de retaguarda técnica e responsabilização pelos usuários, fundamentando o diagnóstico e o tratamento, em vínculo com a APS, cuja oferta é hierarquizada e regionalizada, com boa relação custo-benefício e qualidade de atendimento (PAIM et. al, 2011; GIOVANELLA et.al, 2008). De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), os serviços especializados podem ser encontrados em ambulatórios e hospitais, envolvendo atendimentos direcionados.

No Distrito Federal, as legislações que dispõem acerca da estrutura organizativa da SES DF, bem como suas ferramentas de divulgação no formato de organogramas, compreendem os seguintes pontos no âmbito da atenção especializada: Centro de Especialidades para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (CEPAV); Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);

Centro de Orientação Médica e Psicopedagógica (Compp); Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Atenção ao Adolescente em Família (Adolescentro); Policlínicas; Centro Especializado em Saúde da Mulher (CESMU); Ambulatório Trans Centros Especializados em Reabilitação (CER); Centros de Especialidades Odontológicas (CEO); Centros Especializados em Doenças Crônicas não Transmissíveis; Casas de Parto e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

A SES DF possui uma especificidade em sua organização interna, que são as Unidades de Referência Distrital (URD). No tocante às pessoas em situação de violência, interessa particularmente o Hospital Materno Infantil de Brasília Dr. Antônio Lisboa (HMIB), onde está localizada a Unidade de Proteção e Assistência a Situações de Violência (UPAV), composta pelo Programa Violeta e pelo Programa de Interrupção Gestacional Prevista em Lei (PIGL), que são serviços ambulatoriais especializados no atendimento a pessoas em situação de violência e a pessoas que estejam gestantes em decorrência de violência sexual, respectivamente.

Os serviços de atenção especializada podem ser porta de entrada na rede de saúde para pessoas em situação de violência ou ser acionados para prestar atendimento às demandas específicas, conforme o tipo de assistência especializada ofertada. Todos os pontos de atenção deste subcomponente devem estar preparados para realizar todas as dimensões de cuidado listadas no item 7 desta Linha de Cuidado.

Centro de Especialidades para a Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (CEPAV) e Programa Violeta:

O DF possui uma das maiores coberturas do país para o atendimento especializado às pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica no âmbito da saúde pública, sendo 17 unidades de atenção especializada (CEPAV) ligadas aos respectivos Núcleos de Prevenção e Assistência a Situações de Violência (NUPAV) das regiões de saúde, e o Programa Violeta e PIGL ligados à Unidade de Assistência a situações de violência (UPAV) conforme cometado na página 37**.** Todos esses serviços são identificados com nomes alusivos a flores - Rede Flores -, visando à concepção de atenção humanizada às pessoas em situação de violência. Os CEPAV estão adequados às diretrizes da regionalização, ofertando serviços em ambulatórios especializados, distribuídos nas sete regiões de saúde do DF, localizados nos Hospitais Regionais ou em Policlínica. Já o Programa Violeta e o PIGL, por serem localizados no HMIB, que é uma Unidade de Referência Distrital Materno Infantil, atende todo o DF e a RIDE.

Nessa rede, os CEPAV e o Programa Violeta são serviços especializados de referência para a atenção às pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica em todos os ciclos de vida com abordagem biopsicossocial e interprofissional, oferecendo acompanhamento de saúde a estas pessoas e suas famílias, sob a ótica da integralidade, para contribuir com o tratamento de agravos relacionados às situações de violência sexual, familiar ou doméstica, crônicas ou agudas, bem como para contribuir com o rompimento do ciclo de violência.

O acesso aos CEPAV e ao Programa Violeta se dá por meio de procura direta ao serviço (demanda espontânea) ou por encaminhamento da rede intra e intersetorial, como: Conselhos Tutelares; Centro Integrado 18 de Maio; Delegacias Especializadas; outras Secretarias do DF, Núcleo de Testagem e Aconselhamento - NTA; outros CEPAV; Atenção Primária; entre outros, e, também, por busca ativa de casos por meio de dados identificados em Ficha de Notificação preenchidas por outros profissionais de saúde da região, sendo estes ambulatórios especializados não regulados pela APS (serviços de porta aberta). Por se tratar de serviços não regulados, a prioridade do atendimento e estabelecimento de plano terapêutico singular se dará a partir da avaliação de risco de agravos na saúde e de reincidência de violências.

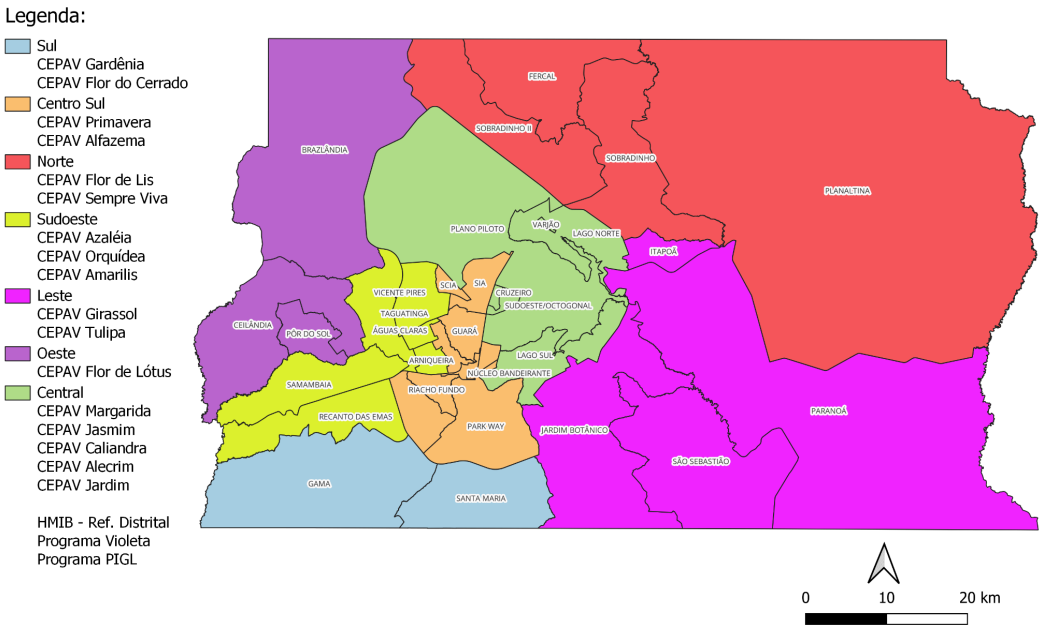
As ações desenvolvidas pelos CEPAV e Programa Violeta abrangem: acolhimento; identificação das histórias de violência (diagnóstico das violências); avaliação de risco de reincidência de violências e risco de feminicídio; avaliação dos impactos da violência na saúde; elaboração do plano terapêutico singular; e encaminhamentos para rede intra e intersetorial, conforme demandas identificadas em cada caso. Também fazem parte do escopo de atuação, as ações de enfrentamento e prevenção das situações de violência, com promoção da saúde e disseminação da cultura de paz. Para isto, executam-se iniciativas de educação permanente para profissionais dos diferentes níveis de atenção e outros parceiros da Rede de Proteção, Responsabilização e Enfrentamento; bem como o Sistema de Garantia de Direitos.

Nos casos de violência sexual, os CEPAV e o Programa Violeta realizam avaliação inicial sobre o caso: se a violência sexual ocorreu dentro das últimas 72 horas, a pessoa é encaminhada ao pronto atendimento mais próximo ou à UBS habilitada para avaliação clínica e início da profilaxia pós-exposição (PEP). Após esses atendimentos, a pessoa é orientada a retornar ao CEPAV ou Programa Violeta para acompanhamento integral, a fim de contribuir para o tratamento de agravos relacionados às situações de violência vividas, sejam crônicas ou agudas, bem como contribuir para o rompimento do ciclo de violência. Seja em caso de violência aguda, seja em situação de violência crônica. Em casos de gestação decorrente da violência sexual, orienta-se sobre sobre às alternativas legais frente à gestação decorrente de violência sexual - manutenção da gestação para vinculação familiar; entrega legal à adoção; interrupção gestacional prevista em lei - e seu devido encaminhamento ao PIGL.

O Programa Violeta oferece atendimento ambulatorial por meio de demanda espontânea, encaminhamento da rede intra e intersetorial ou busca ativa de casos por meio de dados identificados em Ficha de Notificação preenchida por outras equipes do HMIB. A equipe do Programa Violeta também oferece apoio matricial para as equipes multiprofissionais das emergências e da internação do HMIB em casos notificados de suspeita de violência sofrida por pacientes internados. Essa ação ocorre de duas formas: (a) suporte técnico pedagógico através de discussão de casos com equipes das enfermarias e pronto socorro adulto e infantil para elucidar dúvidas e fazer planejamento conjunto das ações que serão desenvolvidas pelas equipes da internação e emergências; (b) suporte clínico especializado por meio do acolhimento beira leito, feito por algum integrante da equipe do Programa Violeta em casos de suspeita de violências contra crianças; casos de maus tratos físicos cometidos por cuidadores ou pais cujos filhos estão sob sua responsabilidade durante internação; casos de violência

doméstica contra mulher, em que a vítima ainda tenha vínculo com ofensor ou tenha relatos de violências recentes, ou não reconheça as violências. Ou ainda, casos avaliados como de alto risco relacionados à reincidência de violências. Às pessoas atendidas pelo Programa Violeta é facultado o seguimento do cuidado no próprio Programa ou no CEPAV de referência da região onde reside, com objetivo de facilitar o deslocamento e contribuir para melhor adesão ao serviço.

Quadro 3 – Organização dos Centro de Especialidades para a Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica - CEPAV nas Regiões de Saúde



Destacam-se três pontos de atenção que, apesar da regionalização, possuem coberturas de atendimentos a todo o DF. São eles:

- CEPAV Jasmim: referência para atendimento de crianças e seus familiares em situação de violência sexual, física, negligência e maus-tratos; adolescentes ofensores sexuais e seus familiares.
- CEPAV Alecrim: referência para atendimento de pessoas adultas autoras de violência sexual contra crianças e adolescentes da mesma família ou conhecidas. Salienta-se que não se enquadram como público deste serviço pessoas que cometeram violência sexual associada a homicídio, tentativa de homicídio e tortura. O acesso a este CEPAV se dá por meio de encaminhamento judicial.
- CEPAV Jardim: referência de suporte psiquiátrico a pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica em acompanhamento pelos demais CEPAV da Rede, conforme fluxo interno.

Programa de Interrupção Gestacional Prevista em Lei (PIGL)

No Distrito Federal, o serviço de aborto previsto em lei é ofertado pelo PIGL que está subordinado à Unidade de Assistência a Situações de Violência (UPAV), localizado no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB). Foi criado pela Resolução nº 1, de 1996, do Conselho de Saúde do Distrito Federal (CSDF), que aprovou a criação do Serviço Multiprofissional de Assistência Integral à mulher, para realização de aborto, nos casos previstos em lei. Em complemento, foi publiicada a Portaria de 9 de fevereiro de 1998 que "disciplina o atendimento para a realização de abortamento, na rede pública, nos casos de exclusão de antijuridicidade", previstos no Artigo 128 do Código Penal Brasileiro, nos seguintes casos: "se não há meio de salvar a vida da gestante e, se a gravidez resultar de estupro".

O serviço possui caráter ambulatorial e atende no regime de porta aberta - ou seja, não é necessária a regulação ou o agendamento do atendimento. O acesso ao atendimento não se condiciona à decisão judicial ou boletim de ocorrência, porém os procedimentos são de notificação compulsória no SINAN. Nas situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, a equipe deve realizar a comunicação externa da situação de violência ao Conselho Tutelar e/ou Delegacia de Polícia, sem prejuízo da continuidade do atendimento no âmbito da saúde. A equipe realiza ainda orientações à mulher sobre a importância do Boletim de Ocorrência para acionar mecanismos de proteção, como por exemplo a Casa Abrigo, medidas protetivas e também para a responsabilização do agressor. A comunicação externa de violência contra a mulher pode ocorrer mediante consentimento da mulher e depende da assinatura de um termo de autorização para que o/a profissional da saúde proceda à comunicação (Nota Técnica nº 01/2020, de 01/09/2020 - 1º OF-NDH). É realizado também o preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco - FONAR.

No PIGL, a pessoa sobrevivente de violência sexual que tenha ficado gestante em decorrência deste crime passará por acolhimento realizado por equipe multiprofissional, composta por assistente social, enfermeira, médica e psicóloga. O procedimento de interrupção gestacional é realizado mediante avaliação de critérios clínicos e legais, conforme Norma Técnicas do Ministério da Saúde (2012) sobre prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual e Nota Técnica do Ministério da Saúde (2005) sobre atenção humanizada ao abortamento. Na norma vigente, não há indicação para interrupção da gravidez após 22 semanas de idade gestacional. No documento, o Ministério da Saúde recomenda que a mulher deve ser informada da impossibilidade de atender a solicitação do abortamento e encaminhada ao acompanhamento pré-natal especializado e/ou pré-natal psicológico, facilitando-se o acesso aos procedimentos de adoção, se assim o desejar (BRASIL, 2012).

Após consulta de acolhimento é realizada avaliação ecográfica que consiste na compatibilização cronológica entre os fatos relatados, ou seja, verifica-se se a idade gestacional encontrada no exame é compatível com a data da violência enquanto provável data da concepção, de acordo com os parâmetros preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022).

Conforme preconizado pela Portaria 1.508/05, do Ministério da Saúde, para a realização do procedimento é obrigatório que a pessoa sob cuidados assine os seguintes documentos: Termo de

Relato Circunstanciado, no qual a pessoa sob cuidados relata por escrito o evento de violência sexual; Termo de Responsabilidade, no qual a pessoa assume responsabilidade pelo relato prestado à equipe, afirmando que poderá cumprir pena criminal por falsidade ideológica em caso de apresentação de informações falsas que possam ser descobertas por investigação da segurança pública; Termo de Autorização para Interrupção Gestacional, no qual a pessoa consente com o procedimento após ser informada sobre técnicas, riscos, eventos adversos e cuidados pós abortamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Embora não seja preconizado pelo Ministério da Saúde, por orientação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal (DPT/PCDF), como uma cautela adicional, a paciente ainda deve preencher o Termo de Autorização para Coleta do Material Biológico, o qual define o destino do material resultante do abortamento, de acordo com os princípios bioéticos, as normativas legais e os protocolos de análise da PCDF.

Após o procedimento de interrupção, a pessoa segue em acompanhamento pela equipe do PIGL por 30 dias, sendo atendida em abordagem biopsicossocial, além do suporte no tocante à educação sexual e ao planejamento reprodutivo. Em seguida, é contra referenciada à APS e encaminhada ao CEPAV, de acordo com a referência territorial.

Evidencia-se que, no PIGL e em toda a rede de saúde, além da alternativa de interrupção gestacional, também são orientadas as alternativas de manutenção da gestação para vinculação, ou manutenção da gestação para entrega legal à adoção. No caso de vinculação, a pessoa é orientada à realização do pré-natal na UBS de referência. Já no caso de entrega legal à adoção, são realizadas as orientações conforme as Recomendações Técnicas sobre Entrega Legal e Humanizada de Bebê para Adoção no âmbito da SES DF (VIJ-TJDFT; DPDF; MPDFT, 2022) e conforme orientação das cartilhas: Cartilha de Entrega Voluntária em Adoção - orientações para gestantes e Cartilha de Entrega Voluntária em Adoção - orientações para profissionais.

Diante das alternativas apresentadas, a equipe multiprofissional do PIGL atua com respeito à autonomia da mulher agindo para o atendimento resolutivo em tempo oportuno, sob a ótica da integralidade em saúde.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS):

Os CAPS são serviços especializados de saúde mental, voltados ao atendimento de pessoas em sofrimento mental grave – já que os casos leves devem ser conduzidos pela APS -, incluindo aquele decorrente do uso de álcool e outras drogas, tanto nas situações de crise, quanto nos processos de reabilitação psicossocial. Alguns exemplos das demandas atendidas pelos CAPS, que, inclusive, podem ser decorrentes de situações de violência, são: dificuldade de manter o autocuidado em decorrência de algum transtorno mental, tentativa recente de suicídio, ideações suicidas recorrentes, automutilação, presença de alucinações e delírios, uso abusivo de substâncias psicoativas, dentre outros. Diante de situações que suscitem dúvidas sobre o serviço prestado pelos CAPS, é válido consultar os Critérios para encaminhamento de adultos aos serviços de saúde mental da Atenção Secundária.

O serviço é ofertado em caráter aberto e comunitário, sem necessidade de agendamento prévio. Também são realizados atendimentos por encaminhamento da rede intra ou intersetorial. Para ser atendida no CAPS, a pessoa deve apresentar documento oficial de identificação com foto; cartão do SUS e comprovante de residência (recomendado, não obrigatório). Para pessoas em situação de rua, tais documentos não devem ser exigidos.

A assistência é prestada por equipe multiprofissional, sob a ótica interdisciplinar da atuação de psiquiatras, clínicos, pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, equipe de enfermagem, farmacêuticos – a depender da modalidade do CAPS e dos recursos humanos disponíveis na SES DF. As atividades podem ser coletivas ou individuais, definidas para o usuário após o acolhimento e avaliação inicial, cujo cuidado é desenvolvido por meio de Projeto Terapêutico Singular (PTS) que envolve equipe, usuário, família e comunidade.

Para as pessoas em situação de violência e/ou dela sobreviventes, os CAPS podem ser serviços de apoio essenciais no acompanhamento, assistência, reabilitação das consequências das situações de violências. Vale lembrar que, embora alguns serviços não exijam encaminhamento para acolher o usuário, nos casos de situação de violência é sempre válido o registro detalhado pela equipe que primeiro recebeu a pessoa, a fim de prevenir a revitimização e subsidiar o serviço de referência quanto ao acolhimento e seguimento – bem como ações conjuntas na rede intra e intersetorial.

O DF conta, atualmente, com 18 CAPS de todas as modalidades, distribuídos pelas regiões de saúde do DF.

Centro de Orientação Médica e Psicopedagógica (COMPP)

O COMPP é um serviço especializado de saúde mental, voltado ao atendimento de crianças até 12 anos incompletos, com sofrimento mental moderado – os casos leves devem ser conduzidos pela APS e os graves, pelos CAPS Infantis (CAPSi).

O serviço é ofertado por meio de encaminhamento pela APS ou, em situações excepcionais, por outros pontos da atenção especializada e pela atenção terciária, através do Sistema de Regulação e de acordo com as orientações da Nota Técnica para Encaminhamento de Crianças e Adolescentes para os Serviços de Saúde Mental Infanto Juvenil da Atenção Secundária (DISTRITO FEDERAL, 2018). Para ser atendida no COMPP, a pessoa deve apresentar documento oficial de identificação com foto; cartão do SUS e comprovante de residência (recomendado, não obrigatório). Para pessoas em situação de rua, tais documentos não devem ser exigidos.

A assistência é prestada por equipe multiprofissional, sob a ótica interdisciplinar da atuação de enfermeiro, assistente social, neuropediatra, pediatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, técnico em eletroencefalograma, fisioterapeuta e os servidores do administrativo. Após a inserção do usuário no Sistema de Regulação, deve-se aguardar a convocação para o primeiro atendimento na unidade. O Sistema de Regulação faz contato por telefone e é de extrema importância que as famílias mantenham seus dados atualizados no CadSus - o que deve ser feito na UBS. Os usuários acompanhados no COMPP deverão continuar o acompanhamento também na UBS de referência.

Para as crianças em situação de violência e/ou dela sobreviventes, que desenvolvem transtornos mentais moderados como consequência, o COMPP pode ser um serviço de apoio essencial no acompanhamento, assistência e reabilitação.

Adolescentro

O Adolescentro é um serviço de caráter ambulatorial, referência para o atendimento de adolescentes (12 a 17 anos) com transtornos mentais moderados ou em uso de substâncias psicoativas – já que casos leves devem ser conduzidos pela APS e os casos graves, pelos CAPS e outros pontos de atenção em saúde mental da rede. Alguns exemplos das demandas atendidas pelo Adolescentro são: ansiedade e depressão, déficit intelectual, transtornos alimentares, transtornos do espectro autista, demandas de saúde relacionadas à diversidade de gênero e casos de violência sexual.

O serviço é ofertado a partir do encaminhamento, via Sistema de Regulação, realizado pela UBS de referência, de acordo com as orientações da Nota Técnica para Encaminhamento de Crianças e Adolescentes para os Serviços de Saúde Mental Infanto Juvenil da Atenção Secundária (DISTRITO FEDERAL, 2018). Na primeira visita, a pessoa deve apresentar documento oficial de identificação com foto; cartão do SUS e comprovante de residência (recomendado, não obrigatório). Para pessoas em situação de rua, tais documentos não devem ser exigidos.

A assistência é prestada por equipe multiprofissional, sob a ótica interdisciplinar da atuação de psicólogos, psiquiatras, pediatras, hebiatras, fisioterapeutas, nutricionistas, equipe de enfermagem, ginecologistas, urologistas, neurologistas, equipe de odontologia, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. O serviço dispõe de grupos terapêuticos para pacientes e familiares e as atividades podem ser individuais ou coletivas, a fim de que compartilhem experiências. Os grupos podem oferecer práticas integrativas e complementares em saúde, como yoga, reiki, homeopatia, grupos de respiração, grupos de artes, horta comunitária. Por fim, a unidade também dispõe de farmácia.

Para as pessoas em situação de violência e/ou dela sobreviventes e suas famílias, o Adolescentro pode ser um serviço de apoio essencial no acompanhamento, assistência e reabilitação, sobretudo nos casos de violência sexual, para os quais o serviço conta com grupo de atendimento específico (CEPAV Caliandra).

Policlínicas

As Policlínicas do DF oferecem atendimento ambulatorial especializado e atuam como suporte à APS e a outros pontos da atenção especializada. São diversas categorias profissionais e especialidades médicas disponíveis nos ambulatórios, respectivamente como enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, serviço social; cardiologia, dermatologia, endocrinologia, geriatria, oftalmologia, psiquiatria, pneumologia, reumatologia, otorrinolaringologia, ortopedia, dentre outras.

O serviço é ofertado a partir de encaminhamento, via Sistema de Regulação, realizado pela Atenção Primária à Saúde (APS) ou por outros pontos da atenção especializada, como CAPS, COMPP e Adolescentro. No primeiro atendimento, é necessário apresentar documento oficial de identificação

com foto, cartão do SUS e o encaminhamento. Para pessoas em situação de rua, tais documentos não devem ser exigidos.

Para as pessoas em situação de violência e/ou dela sobreviventes, as Policlínicas podem ser serviços de apoio essenciais, sobretudo na assistência e reabilitação dos agravos em saúde decorrentes de situações de violência. É válido mencionar que nos serviços especializados de atenção ao pré-natal, especialmente, que se localizam nas Policlínicas, toda a equipe precisa conhecer e estar apta a orientar sobre as alternativas legais frente à gestação decorrente de violência sexual, quais sejam: manutenção da gestação para vinculação familiar; entrega legal à adoção; interrupção gestacional prevista em lei (até 22 semanas).

Os casos de gestação na adolescência são conduzidos em pré-natal compartilhado entre APS e atenção especializada. Mediante sinais e sintomas de gestação decorrente de violência sexual, realiza-se o diagnóstico oportuno da gestação através do Teste Imunológico de Gravidez (TIG) ou Exame quantitativo do Beta-HCG e informa-se sobre às alternativas legais frente à gestação decorrente de violência sexual - manutenção da gestação para vinculação familiar; entrega legal à adoção; interrupção gestacional prevista em lei - e seu devido encaminhamento ao PIGL. É importante lembrar que de acordo com o Código Penal Brasileiro (1940), considera-se violência sexual presumida, o ato libidinoso e/ou de conjunção carnal mantido com pessoas em idade inferior a 14 anos e devem ser notificados.

Centro Especializado em Saúde da Mulher (CESMU)

O CESMU é um serviço ambulatorial que implementa uma linha de cuidado em Atenção à Saúde da Mulher, incluindo especialidades médicas e multiprofissionais. O público alvo são mulheres adultas (> 18 anos), seguindo critérios da Nota Técnica de Encaminhamento vigente, que consta no site da SES-DF por meio do link: Notas Técnicas - Secretaria de Saúde do Distrito Federal - aba “Centros Especializados”.

Os principais atendimentos prestados pelo CESMU são: atendimento por equipe multiprofissional com elaboração de Projeto Terapêutico Singular, Plano de Parto; acesso aos medicamentos necessários para saúde da mulher; encaminhamentos responsáveis; acompanhamento puerperal especializado; ginecologia especializada; oncoginecologia; mastologia; exames diagnósticos de imagem; práticas integrativas de saúde; atendimento psicológico; atendimento aberto às vítimas de violência por assistente social e psicólogo; dermatologia; endocrinologia; nutrição; farmácia.

O serviço é ofertado por encaminhamento realizado pelas UBS ou outros pontos de atenção especializada, através do Sistema de Regulação, onde se deve selecionar a opção “Consulta multiprofissional em saúde da mulher”. Para o atendimento, é necessário apresentar documento oficial de identificação e o encaminhamento.

Para as pessoas em situação de violência e/ou dela sobreviventes, este é um serviço complementar no acompanhamento, assistência, apoio diagnóstico e terapêutico e reabilitação dos agravos e consequências das situações de violência.

Ambulatório Trans

Inaugurado em agosto de 2017, em funcionamento na estrutura física do Centro Especializado em Doenças Infecciosas-Cedin (antigo Hospital Dia), o Ambulatório de Diversidade de Gênero/Ambulatório Trans oferece o acompanhamento e o cuidado no processo transexualizador no nível da atenção especializado e ambulatorial às pessoas maiores de 18 anos que se reconhecem como travestis, transexuais, transgêneros, não-binários(es), agenders e outras possibilidades de identidades de gênero, que não estão em conformidade com o gênero socialmente atribuído a partir do sexo designado ao nascimento.

A equipe do Ambulatório Trans é composta por psicólogo, assistente social, endocrinologista, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, urologista, ginecologista e enfermagem. O serviço de atendimento à pessoa trans começa na Atenção Primária e inclui acolhimento, humanização e sensibilização. Além disso, o ambulatório trabalha a sensibilização e o respeito às diferenças e a dignidade humana, em todos os níveis de atenção. A maioria dos casos atendidos no ambulatório é de pacientes com quadros de depressão, ansiedade, transtornos bipolares e em alguns poucos casos de esquizofrenia.

O acesso é realizado a partir de agendamento presencial, de segunda à sexta-feira, nos horários de 07:00h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h. Para o atendimento, é necessário apresentar documento oficial de identificação e o encaminhamento. O serviço é prestado a partir de acolhimento para identificação da demanda; grupo de Entrada do Ambulatório (equipe multiprofissional); encaminhamento a demandas personalizadas; construção compartilhada do Projeto Terapêutico Singular (PTS).

Tendo em vista que a população LGBT+, sobretudo transexuais e travestis, podem ser alvo frequente dos mais diversos tipos de violência, o Ambulatório Trans é um dispositivo imprescindível para o acolhimento, atendimento e seguimento do itinerário de saúde de seu público-alvo, bem como um apoio matricial indispensável na educação permanente de profissionais da rede intra e intersetorial - com vistas à qualificação do atendimento para a humanização, integralidade e equidade.

6.3. Atendimento pré-hospitalar e Atenção Terciária

A atenção terciária ou de alta complexidade abrange os cuidados em saúde que exigem alta densidade tecnológica e compreendem alto custo em saúde, concentrados nos hospitais de médio e grande porte, com um perfil assistencial especializado e cujo papel na rede de serviços deve contemplar a integração com os demais níveis de atenção. Esse nível de atenção tem como principal característica o atendimento às situações mais graves, agudas e urgentes; além de tratamentos cirúrgicos e atendimentos ultraespecializados (GIOVANELLA et.al, 2008; PAIM et.al, 2011).

Para fins de atendimento às pessoas em situação de violência sexual, doméstica e familiar, aqui serão mencionados os Pronto Atendimentos Gerais, os Pronto Atendimentos Gineco-Obstétricos e Pediátricos, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Atendimento pré-hospitalar móvel (APH móvel) - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

O Atendimento pré-hospitalar móvel é um componente central da Rede de Atenção às Urgências e Emergências e, por isso, também é um componente transversal que pode ser utilizado pelas demais redes de atenção à saúde. O atendimento às situações de urgência e emergência é realizado 24h, em residências, locais de trabalho e via pública, quando acionado pelos telefones 192 e 193.

Para as pessoas em situação de violência, com ênfase em situações agudas, o APH móvel é pilar do atendimento, podendo reduzir agravos imediatos decorrentes das situações de violência, realizar orientações pertinentes e promover o encaminhamento eficaz aos demais pontos da rede de atenção – prevenindo a peregrinação, a revitimização e o atendimento ineficaz. A instituição do serviço unificado de atendimento pré-hospitalar em urgências e emergências entre a SES e o CMBDF foi estabelecida pela Portaria Nº 40/ 2018. Por isso, é indispensável que as equipes de saúde do SAMU e CBMDF estejam aptas à notificação das situações de violência.

Para mais, é válida a informação de que o prontuário resultante do atendimento prestado pelo SAMU pode ser acessado pelo usuário em até 5 dias úteis, o que pode ser orientado pelas equipes de saúde dos demais pontos de atenção, visando ao subsídio qualificado do seguimento de saúde a partir de informações do primeiro atendimento. Para acessar, basta se cadastrar na plataforma do Governo Federal e preencher, posteriormente, o formulário do GDF. Também é possível o acesso através do QR Code abaixo:



Atendimento pré-hospitalar fixo (APH fixa): Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

As UPAs são unidades intermediárias entre atenção especializada e terciária, voltadas aos atendimentos emergenciais, ofertando serviços em regime de porta aberta ou a partir de encaminhamento responsável das UBS de demandas que não podem ser solucionadas na APS ou que necessitam de apoio diagnóstico e/ou terapêutico disponibilizado nessas unidades. Para mais, devem ofertar serviço de internação de até 24h para casos que assim demandarem e, havendo necessidade de maior estadia, o paciente deve ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

Nas situações de violências, as UPAs são serviços de apoio essenciais, uma vez que podem funcionar como porta de entrada do sistema de saúde para pessoas em condições agudas de violências. A busca pelo atendimento de emergência pode decorrer de situações urgentes provocadas por lesões agudas em pessoas adultas ou crianças, por exemplo, ou necessidade de assistência a situações de violência sexual com protocolo de profilaxias pós-exposição (PEP).

Neste serviço, as equipes de saúde devem estar aptas à identificação de uma situação de violência (observando fatores de risco ou sinais de alerta); ao apoio diagnóstico; à assistência às consequências agudas; à notificação e ao encaminhamento a unidades hospitalares, se necessário, bem como às UBS, em contrarreferência para seguimento de saúde nos âmbitos necessários. Nos casos de violência sexual, as pessoas sobreviventes devem receber a PEP em até 72h, bem como a contracepção de emergência.

Serviço Hospitalar de Emergência (SHE):

Pronto Atendimento Geral:

As unidades de pronto atendimento são portas de entrada de emergência a pessoas em situação de violência, sobretudo em se tratando das consequências agudas de violências físicas e sexuais. É mister que as equipes de saúde conheçam a rede de atenção à pessoa em situação de violência e estejam aptas a executar todas as dimensões do cuidado, desde o acolhimento, notificação, passando pelo atendimento às condições agudas com investigação de danos físicos transitórios ou permanentes, contenção de problemas de saúde, oferta de exames complementares, até o encaminhamento às redes intra e intersetorial.

Pronto Atendimento Gineco-Obstétrico:

As unidades de pronto atendimento gineco-obstétrico são portas de entrada de emergência a pessoas em situação de violência que estejam passando por violências de diversas naturezas. Aqui vale especificar a violência sexual, quando é prerrogativa indispensável desses serviços as contracepções de emergência, incluindo o DIU de Cobre; a administração das profilaxias pós exposição para ISTs; e a orientação acerca da possibilidade de interrupção gestacional em eventual gravidez decorrente da violência. Ressalta-se que a indicação de DIU de cobre como contracepção de emergência pode ser limitada por lesões perineais graves, entretanto a possibilidade de seu uso deve ser oferecida mediante decisão compartilhada entre o profissional e a pessoa atendida, respeitando as contra indicações do método. Vale ressaltar, ainda, que o tempo de inserção de DIU de cobre como contraceptivo de emergência, de acordo com os protocolos, pode ser concomitante à profilaxia pós exposição às IST, favorecendo a segurança do método

A população LGBTQIAP+ apresenta vulnerabilidade maior à violência sexual, motivada pela discriminação social relacionada às orientações sexuais e/ou identidades de gênero. Ademais, são pessoas que podem enfrentar preconceitos e negligências de maneira sistemática ao longo da vida. Sabendo disso e visando à equidade e à integralidade do cuidado, todo profissional deve se manter

atualizado quanto aos termos adequados para se referir às pessoas LGBTQIAP+. Esta incorporação de conhecimento deve fazer parte das competências de todo profissional de saúde. Na dúvida, pergunte à pessoa atendida como prefere ser chamada e com qual profissional se sente mais à vontade (ginecologista, urologista, proctologista). Em caso de situações clínicas que ultrapassem as competências do profissional que acolhe, a pessoa deve ser encaminhada de maneira respeitosa e cuidadosa a outro especialista sem deixar de ser acolhida.

A notificação e o seguimento de rede são indispensáveis, assim como a investigação de fatores de risco de feminicídio e outros agravos transitórios e permanentes nas dimensões biopsicossociais.

Pronto Atendimento Pediátrico:

As unidades de pronto atendimento pediátrico são portas de entrada de emergência para crianças e adolescentes em situação de violência de diversas naturezas, sendo imprescindível a atenção integral das equipes de saúde para sinais de alerta e fatores de risco (VIDE pg). Situações de saúde mental, acometimentos físicos agudos, sobretudo lesões típicas de violência física e maus tratos, sinais de negligência e o próprio relato da criança condicionam o olhar e as ações da equipe para intervenções protetivas e assistenciais.

Mediante sinais e sintomas de gestação decorrente de violência sexual, realiza-se o diagnóstico oportuno da gestação através do Teste Imunológico de Gravidez (TIG) ou Exame quantitativo do Beta-HCG e informa-se sobre às alternativas legais frente à gestação decorrente de violência sexual - manutenção da gestação para vinculação familiar; entrega legal à adoção; interrupção gestacional prevista em lei no PIGL/HMIB - e seus devidos encaminhamentos. De acordo com o Código Penal Brasileiro (1940), considera-se violência sexual presumida, o ato libidinoso e/ou de conjunção carnal mantido com pessoas em idade inferior a 14 anos.

A atuação multiprofissional, a comunicação ao Conselho Tutelar e a notificação compulsória são pilares da atenção e proteção às crianças e adolescentes em situação de violência.

Serviços de Internação

Os serviços de internação (atenção domiciliar, leitos de internação e Unidades de Terapia Intensiva) são retaguarda do Serviço Hospitalar de Emergência (SHE). As equipes devem estar atentas para quadros ou situações suspeitas de violência. Considera-se que qualquer cuidado em saúde é uma oportunidade de identificação de situações de violência.

A notificação e o seguimento de rede são indispensáveis assim como a investigação de fatores de risco para violência e outros agravos transitórios e permanentes nas dimensões biopsicossociais.

Atenção Domiciliar

A atenção domiciliar é a modalidade de atenção à saúde que complementa e substitui a internação hospitalar. É oferecida na moradia de seus usuários/as e caracterizada por um conjunto de

ações de prevenção, promoção, reabilitação, tratamento e promoção de cuidados paliativos em ambiente domiciliar, com garantia da continuidade do cuidado e integrada à Rede de Atenção à Saúde.

No Distrito Federal, o Serviço de Atenção Domiciliar do Distrito Federal (SAD/DF) é organizado a partir do Programa de Internação Domiciliar (PID), Programa de Oxigenoterapia Domiciliar (POD) e Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (SAD-AC), com base territorial nas regiões de saúde do DF, sendo referência em atenção domiciliar para uma população definida e se relacionando com os demais serviços de saúde, por Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, nos hospitais regionais, com subordinação às Superintendências Regionais de Saúde, de modo que o cuidado ao paciente seja de responsabilidade de todos os pontos da RAS para garantir a integralidade do cuidado e a continuidade da assistência.

A singularidade da atenção domiciliar coloca as Equipes de Atenção Domiciliar dentro do contexto familiar, sendo necessário identificar de forma cautelosa a realidade social à qual a família está inserida.

Dessa forma, as equipes devem estar aptas a identificar, não apenas a violência contra o usuário cadastrado no programa, mas também contra os demais atores da sua rede de cuidado.

Ainda assim, é necessário que o profissional da Atenção Domiciliar cuide da família, respeitando a complexidade das relações familiares, valorizando as características peculiares do convívio no domicílio, preservando os laços afetivos e construindo ambientes mais saudáveis para o usuário em tratamento.

Entende-se que a atuação do profissional da atenção domiciliar no contexto de violência contra o usuário, ou qualquer outro ator desta rede de apoio, deve ser realizada de forma compartilhada com os demais aparelhos da RAS sem quebrar o vínculo de acesso ao seu domicílio.

Qualquer outro ponto de atenção que não esteja detalhado nesta LC deve estar sensível aos sinais de alerta para situações de violência aqui detalhados, bem como seus profissionais precisam conhecer a rede de atenção às pessoas em situação de violência - a fim de estarem capacitados às orientações e compartilhamento de conhecimentos com a população, equipes de saúde e trabalhadores de pontos de atenção de outras políticas públicas.

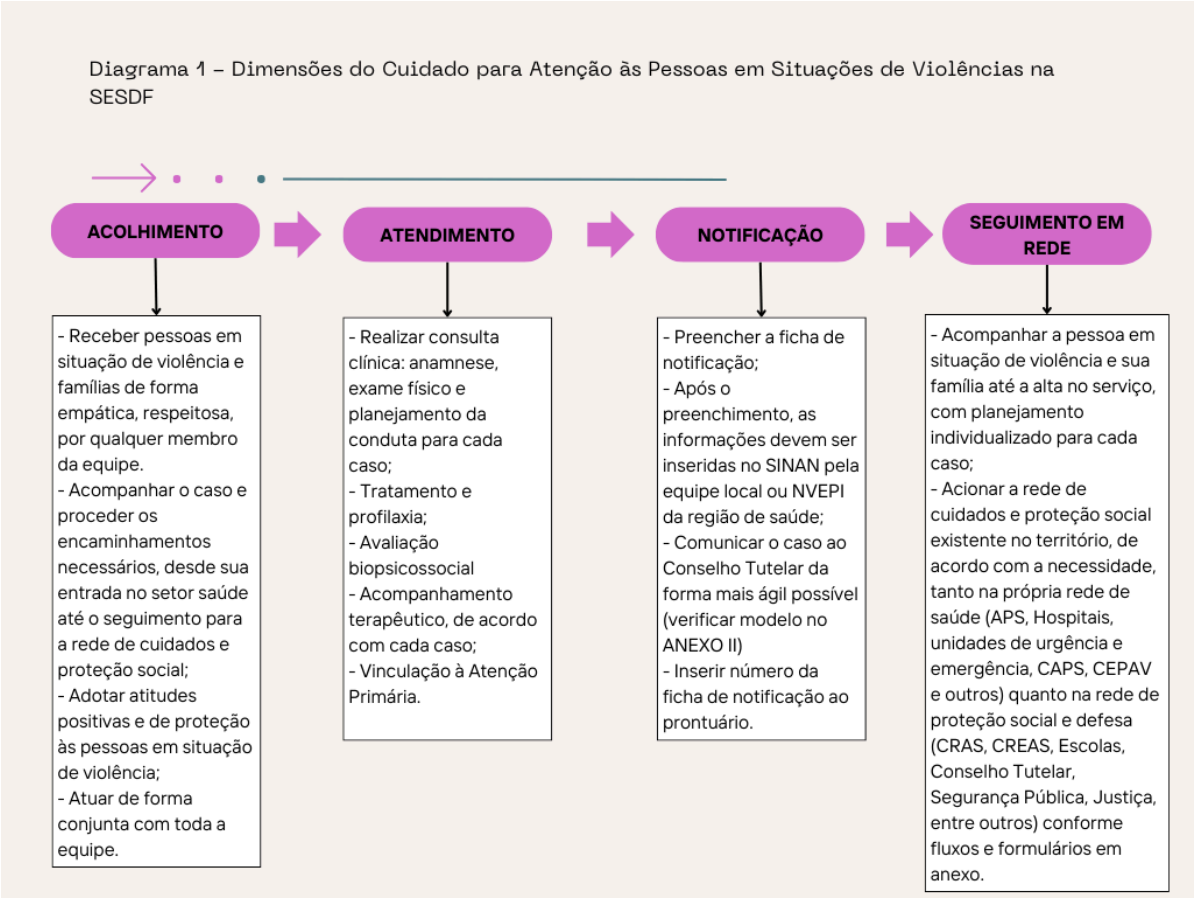
7. Dimensões do Cuidado

A implantação da LC deve seguir os seguintes pressupostos: integração e corresponsabilização entre profissional de saúde e pontos de atenção; pactuações regionalizadas conforme demandas e ordenamento de cuidado local, educação continuada de profissionais de saúde.

Os profissionais de saúde nos diferentes níveis de atenção devem acolher as demandas das pessoas em situação de violência, prestar o atendimento em saúde, preencher a Ficha de Notificação Compulsória de Violência Interpessoal/Autoprovocada (Anexo I) e promover o seguimento em rede de cuidado e de proteção social conforme formulários em anexo.

O Diagrama 1[1] ilustra o passo a passo da linha de cuidado para atenção integral à saúde de pessoas em situação de violência que compreende as dimensões de cuidado preconizadas na Secretaria de Saúde do DF:

Diagrama 1 – Dimensões do Cuidado para Atenção às Pessoas em Situações de Violências na SESDF



7.1. Acolhimento às Pessoas em situação de Violência no âmbito da SES/DF

O acolhimento não é um espaço físico somente, mas necessita de uma ambiência que deve ser entendida como um espaço social e de relação interpessoal que proporciona atenção acolhedora, resolutiva e humana (BRASIL, 2006). Neste sentido, o acolhimento implica em uma atitude, um posicionamento ético que não pressupõe hora nem local para acontecer, requer uma ação contínua em todos os momentos do processo de produção de saúde. Além disso, não especifica o profissional responsável por fazê-lo, mas requer habilidades para manter um espaço de diálogo acolhedor, que possibilite a troca de saberes e a expressão de sentimentos, sem julgamento, sem críticas ou discriminação (BRASIL, 2006; BRASIL, 2014).

Pessoas em situação de violência podem apresentar experiências de medo, ansiedade, vergonha, culpa, desesperança, entre outras. Dessa forma, o acolhimento requer uma escuta qualificada, competente e efetiva que possibilite maior capacidade de identificação dos casos de

[1]Fonte:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_criancas_familias_violencias.pdf (com adaptações)

violência e igualmente o estabelecimento de uma relação de confiança com vistas ao vínculo entre o serviço, profissional e usuário (BRASIL, 2014).

O acolhimento às pessoas em situação de violência precisa ser realizado em ambiente privativo, a fim de evitar a exposição da pessoa sobrevivente; assim como exige do profissional postura empática, livre de julgamentos morais e pessoais, caracterizando-se por conduta ética e técnica. Além disso, no ato do acolhimento é importante coletar o máximo de informações acerca da pessoa e da situação de violência, preocupando-se especialmente com o registro cuidadoso e detalhado, com vistas ao correto preenchimento da ficha de notificação e para o compartilhamento de informações entre profissionais envolvidos no cuidado, de acordo com a prerrogativa do sigilo profissional, a fim de evitar a revitimização motivada pela repetição do relato da violência. A atenção multiprofissional promove uma visão mais ampla da violência, reconhecendo suas múltiplas causas e consequências. Isso é essencial para a elaboração de estratégias de prevenção e intervenção que sejam verdadeiramente eficazes. A troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais enriquece o atendimento, garantindo que esses indivíduos recebam um suporte mais completo e integrado.

Alerta-se todos os profissionais envolvidos no cuidado, partindo do acolhimento respeitoso, sobre a necessidade de evitar a despersonalização da vítima de violência - conduta que a reduz a pessoa à situação de violência, exemplo: “a paciente do estupro”; “a mulher que apanhou do marido”; “a criança abusada pelo tio”. Tal zelo ético, alinhado ao princípio da humanização do cuidado, é necessário para a formulação de um plano terapêutico qualitativamente técnico, humanizado, empático e resolutivo, que promova a adesão da pessoa em situação de violência aos cuidados necessários e ao seguimento pela rede de saúde e pela rede intersetorial.

Para mais, o compartilhamento do cuidado não pode prescindir, também, da postura ética que evita a exposição desnecessária da pessoa em situação de violência a funcionários do serviço que não estejam implicados diretamente em seu cuidado; outros pacientes; acompanhantes e qualquer indivíduo que não possa contribuir substancialmente no cuidado e proteção da pessoa. Os encaminhamentos necessários e o compartilhamento de casos dependem de um acolhimento bem feito, que abarque a coleta de dados, a empatia, a promoção da da saúde e da proteção.

7.2. Atendimento às pessoas em situação de violência no âmbito da SES/DF

O atendimento às Pessoas em Situação de Violência no âmbito da SES/DF requer uma visão integral da saúde, contemplando todos os ciclos de vida. Este atendimento compreende atuação multiprofissional, de acordo com os níveis de atenção à saúde. Profissionais de diferentes áreas, como psicologia, serviço social, medicina, e enfermagem, entre outras, trabalham em conjunto para criar um ambiente seguro e acolhedor. Essa colaboração permite que as necessidades específicas de cada indivíduo sejam atendidas de maneira integrada e eficaz.

Recomenda-se que, nos atendimentos às pessoas em situações de violência, os profissionais realizem um diagnóstico situacional identificando:

- Situação familiar;

- Existência de rede de apoio;

- Proximidade do autor da violência com a pessoa sobrevivente;

- Tipo de violência suspeita ou confirmada que motivou a busca pelo atendimento;

- Outras situações de violências vividas ou potenciais;

- Situações de vulnerabilidade da vítima, tais como riscos pessoais e sociais (ex: situação de rua; convivência com transtorno mental; entre outros);

- Impactos da violência para saúde física e/ou mental, conforme conhecimento técnico, área de atuação e categoria profissional;

- Risco de reincidência (novas violências) e de agravamento (risco de violência grave ou letal). Deve ser utilizado o Formulário Nacional de Avaliação do Risco de Violência para casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, instituído pela **DECRETO Nº 46.906, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 que** Regulamenta a Lei nº 6.912, de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre o emprego do Formulário Nacional de Avaliação de Risco como instrumento de coleta de informações para o enfrentamento e a prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher e do feminicídio. Este Decreto cria o Sistema Distrital de Avaliação de Risco, no Distrito Federal. De acordo com o Art. 3º que o "Formulário Nacional de Avaliação de Risco" é de uso obrigatório, quando cabível, por todos os servidores públicos do Distrito Federal das áreas de segurança pública, assistência social, saúde e demais envolvidos no atendimento à mulher em situação de violência.

Outros procedimentos que devem ser feitos durante os atendimentos são:

- Preenchimento da Ficha de notificação de violência;

- Oferta de cuidados necessários (assistência às situações agudas ou agravos crônicos provocados pela violência - queixas físicas, crises de saúde mental, exames necessários, medicações pertinentes, etc)

- Registros completos e detalhados em prontuário[2]: anamnese, exame físico, procedimentos realizados, orientações prestadas, preenchimento da ficha de notificação (se possível, incluir número da ficha), comunicações externas e encaminhamentos realizados à rede intersetorial e de proteção social;

[2] De acordo com a Portaria 40/1992 - SAS/MS, o Prontuário é um conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, destinado ao registro dos cuidados médicos e dos demais profissionais, prestados ao paciente em um estabelecimento de saúde. Trata-se de registro obrigatório em prontuário único, das atividades desenvolvidas pelas diversas categorias profissionais – médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, farmacêutico, pessoal auxiliar.

- Orientações sobre a importância do registro de ocorrência policial, com a cautela para que não se confunda a relevância com a obrigatoriedade, visando não afastar a pessoa em situação de violência do serviço de saúde;

- Encaminhamento responsável e oportuno para outro ponto ou nível de atenção à saúde e/ou outras especialidades de atenção, conforme necessidades identificadas;

- Encaminhamento para rede intersetorial de enfrentamento às violências, conforme necessidades identificadas.

Cabe ressaltar que as ações descritas devem ser feitas por qualquer profissional que atende e acolhe uma pessoa em situação de violência.

Atendimento às pessoas em situação de violência sexual no âmbito da SES/DF

Para o atendimento à situação de violência sexual, deve-se atentar ao Fluxograma de atenção à pessoa em situação de Violência Sexual, do Protocolo de Atenção às Queixas Ginecológicas da SES DF. Para acesso ao protocolo clínico da profilaxia pós exposição (PEP), acessar Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs) — Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde.

Em casos de violência sexual aguda, em qualquer serviço da rede de saúde, é imprescindível que a vítima seja encaminhada ao serviço de Urgência e Emergência de um dos hospitais da rede pública mais próximo, ou UBS habilitada para realização de esquema profilático. Os esquemas de Profilaxias Pós-Exposição de Risco à Infecções pelo HIV, IST e Hepatites Virais e contracepção de emergência devem ser administrados a vítimas de violência sexual em sua fase aguda, ou seja, em até 72 horas após a violência sexual.

Nos casos de violência sexual crônica, na impossibilidade de realização de esquema de Profilaxia, é imprescindível que sejam realizados os exames de rastreamento e as orientações acerca do seguimento - tais como sorologias e testes rápidos, com suas respectivas janelas imunológicas e prazos para repetição dos exames. Havendo diagnóstico de IST, o serviço deve prezar pela resolutividade, encaminhamento aos serviços pertinentes.

Mediante sinais e sintomas de gestação decorrente de violência sexual, realiza-se o diagnóstico oportuno da gestação através do Teste Imunológico de Gravidez (TIG) ou Exame quantitativo do Beta-HCG e informa-se sobre às alternativas legais frente à gestação decorrente de violência sexual - manutenção da gestação para vinculação familiar; entrega legal à adoção; interrupção gestacional prevista em lei - e seus devidos encaminhamentos ao PIGL.

Considerando o sofrimento mental provavelmente decorrente das situações de violência, os serviços de saúde mental e os CEPAV disponíveis na rede também devem compor o rol de encaminhamentos realizados no atendimento à pessoa em situação de violência sexual.

Atendimento às pessoas em situação de violências físicas e outras violências no âmbito da SES/DF

O atendimento a vítimas de violência física e outras violências deve ser pautado pelos princípios da ética, do acolhimento humanizado e da proteção integral, conforme orientações do Ministério da Saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os serviços de urgência e emergência são pontos estratégicos para a identificação e encaminhamento adequado desses casos, sendo essencial que os profissionais estejam preparados para agir com sensibilidade, técnica e responsabilidade.

Durante o atendimento, é fundamental que a equipe de saúde esteja atenta a sinais físicos (como lesões, fraturas, queimaduras ou feridas incompatíveis com o relato) e comportamentais (como retraimento, medo, desconfiança ou agitação). Diante de qualquer suspeita, o acolhimento deve ocorrer em espaço privativo e seguro, com escuta atenta, empática e sem julgamentos. É essencial que todas as informações relevantes — tanto observações clínicas quanto relatos da vítima — sejam registradas de forma detalhada no prontuário, resguardando o sigilo profissional e respeitando os limites da pessoa atendida.

Nos serviços de urgência e emergência, a prioridade é a estabilização clínica e o tratamento das lesões. A equipe deve manter um olhar atento para possíveis sinais de violência e registrar todos os achados com rigor técnico, bem como proceder a notificação compulsória e seguimento em rede conforme fluxos em Anexo. Em todas as situações, os profissionais de saúde devem atuar com empatia e respeito aos direitos da vítima, compreendendo que a omissão diante de uma suspeita de violência pode representar negligência profissional. É dever do serviço de saúde não apenas prestar o atendimento imediato, mas também integrar-se com a rede de proteção e desenvolver ações educativas de prevenção e enfrentamento à violência em suas comunidades.

7.3. Notificação das situações suspeitas ou confirmadas de violência no âmbito da SES/DF

Notificar significa registrar a ocorrência de agravos ou doenças de interesse para a saúde pública em formulários próprios da Vigilância Epidemiológica. A notificação de violência é um desses registros e integra as dimensões desta Linha de Cuidado, como um instrumento que subsidia a formulação de políticas públicas e a organização dos serviços que atenderão as pessoas em situação de violência. Essa ação não substitui as ações de acolhimento e atendimento da pessoa em situação de violência, não devendo se sobrepor a outras ações também de natureza imediata (24hs), tais como a profilaxia pós exposição (PEP).

Em 2009, as violências passaram a compor o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Esse sistema permite processar os dados por meio de bases alimentadas pela Ficha de Notificação individual e apresenta acesso para o lançamento de todas as doenças e agravos

constituintes na Lista Nacional de Notificação, incluindo a violência interpessoal/autoprovocada por conter todos os danos relevantes por sua magnitude, disseminação e vulnerabilidade (Girianelli et al., 2018).

O preenchimento da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/ Autoprovocada é de caráter compulsório, imediato[3] e institucional, ou seja, é dever do profissional de saúde notificar todos os casos **suspeitos ou confirmados** de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada (tentativa de suicídio), tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal, tortura e violências LGBTfóbicas contra pessoas de todas as idades. Para a maioria dos agravos, não se deve aguardar a confirmação do caso para se efetuar a notificação, pois isso pode significar perda da oportunidade de intervir eficazmente.

No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objeto de notificação às violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBTIQIAP+, conforme a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017 e a Portaria GM/MS Nº 217/2023 que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. Essa lista inclui danos à integridade física ou mental decorrentes de violência interpessoal como agravos que devem ser notificados[4].

A notificação **é compulsória para todas as categorias profissionais de saúde,** que atuam em serviços públicos ou privados. Tal obrigatoriedade é referendada por determinados Códigos de Ética Profissionais e prevista pela Nota Técnica Nº 62/2022-CGDANT/DAENT/SVS/MS (BRASIL, 2022). A notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas contribui para responder dispositivos legais de garantia de direitos e políticas nacionais de saúde. Além disso, é importante destacar a responsabilidade compartilhada entre os diferentes setores de saúde, pois a colaboração entre os profissionais e a efetividade da notificação são cruciais para o enfrentamento das situações de violência e a proteção das pessoas envolvidas.

Visando à transposição de barreiras na notificação compulsória das violências, **o DF é o único ente federativo que possui ficha de notificação de violência interpessoal/autoprovocada sem a obrigatoriedade de identificação do profissional que a preencheu**. Dados epidemiológicos corroboram com esta boa prática implementada, uma vez que demonstram o aumento no número das notificações a partir de 2015, ano em que foi instituída a nova ficha. Para esta ficha, modelo DF 07/2015, foi confeccionado um instrutivo de preenchimento. No âmbito da SES-DF, todas as Unidades

[3] Notificação imediata, ou seja, nas primeiras 24 horas, refere-se a todos os casos de violência sexual e tentativa de suicídio. Lesões autoprovocadas ou autoinflingidas não são objeto de notificação imediata, contudo devem ser notificadas como as demais violências em até 7 dias do conhecimento do fato, conforme Portaria MS/GM 204 de 2016.

[4] A notificação compulsória obrigatória foi introduzida no sistema de saúde pela Lei 6.259/1975, que estabeleceu normas para registro de doenças que podem implicar em medidas de isolamento ou quarentena ou de “agravo inusitado à saúde”. Em 2001, através da Portaria MS/GM 737, a violência interpessoal foi incluída na lista de notificação compulsória.

de Saúde, em todos níveis de atenção, são responsáveis pela inserção dos dados no Sinan - Sistema de Informação de Agravos de Notificação, sob supervisão das respectivas Vigilâncias Epidemiológicas.

A notificação de casos de violência em todos os ciclos de vida independe de consentimento da vítima ou responsável e não constitui quebra de sigilo profissional. As informações devem ser compartilhadas de forma sigilosa no âmbito do sistema sanitário para fins de produção estatística e elaboração de políticas públicas. É um importante instrumento de proteção e seu objetivo não é denúncia ou produção de provas. Vale ressaltar que nos casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças (0 a 12 anos incompletos) e adolescentes (12 a 18 anos incompletos), estes precisam ser comunicados aos Conselhos Tutelares[5] dos territórios, bem como os casos de grave risco à comunidade ou a mulher conforme critérios do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FONAR) em anexo.

Apesar das disposições legislativas e da importância das ações de notificação, comunicação e seguimento no âmbito da Vigilância Epidemiológica, a subnotificação das situações de violência ainda é um grande problema. A estratégia definida para o enfrentamento da subnotificação de violências no Distrito Federal é a implantação da **notificação compulsória negativa (NCN)**, prevista na Portaria Ministerial nº 204 de 2016 (BRASIL, 2016) e na Portaria Distrital nº 508 de 2023 (DISTRITO FEDERAL, 2023), como estratégia de vigilância epidemiológica. A NCN é “a comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória” (DISTRITO FEDERAL, 2023).

Deverá ser realizada a notificação negativa para o agravo de violência, seja esta sexual, tentativa de suicídio, doméstica e outras violências pelas unidades de saúde públicas e privadas do Distrito Federal quando não houver tido caso de notificação na semana epidemiológica antecedente. A ferramenta escolhida para efetivar a notificação negativa, é o sistema Vigilância DF, com o preenchimento da ficha de notificação negativa, na qual deverá selecionar o campo violência, informando o nome da unidade notificadora, a semana epidemiológica e, confirmando a informação de notificação negativa.

Além da notificação negativa, há, ainda, os **casos de notificação imediata**:

Serão objetos de notificação imediata, em até 24 horas, pelas Unidades de Saúde, e comunicadas à Vigilância Epidemiológica de referência os casos de Violência Sexual e Tentativa de Suicídio, de acordo com a Portaria GM/MS nº 217, de 1 de Março de 2023, que dispõe a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública.

A importância da notificação imediata é o favorecimento do tempo oportuno para que o indivíduo em situação de violência receba assistência adequada e continuada, pois subsidia medidas de

[5] Art. 13 - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

prevenção, identificação de fatores de risco e proteção, bem como sua inserção na Rede de Atenção Integral e vinculação aos serviços de atendimento (BRASIL, 2021).

Nos casos de **Violência Sexual**, estas devem ser comunicadas com a finalidade de que as medidas de contracepção de emergência, profilaxias (HIV e outras ISTs; hepatite B e vacinação contra o HPV) sejam realizadas oportunamente, além de encaminhamento vinculação aos serviços de saúde especializados no atendimento às pessoas em situação de violência e mecanismos de proteção.

Nos casos de **Tentativa de suicídio**, espera-se que a notificação favoreça o cuidado, o encaminhamento e a vinculação do usuário aos serviços de atenção psicossocial e à rede de atenção e proteção social.

Casos de notificação imediata (até 24 horas)	
Violência sexual	a fim de que as medidas de contracepção de emergência, profilaxias (HIV e outras ISTs; hepatite B; vacinação contra HPV) e a coleta de material biológico para responsabilização do agressor sejam realizadas oportunamente. (BRASIL, 2021)
Tentativa de suicídio	para que a notificação seja disparadora do cuidado, visando ao encaminhamento e à vinculação da vítima de forma imediata aos serviços de atenção psicossocial e à rede de atenção e proteção social. (BRASIL, 2021)

A notificação dos casos de violência gera dados cuja análise resulta em informações que, além de identificar na população o perfil epidemiológico tanto das pessoas sobreviventes quanto de autores do agravo em determinado período, subsidia as políticas públicas de prevenção e assistência à questão de saúde, organizando o serviço e fortalecendo as redes intra e intersetorial. Importante ressaltar que ainda é necessário acompanhar e monitorar a execução das notificações junto às instituições de saúde e profissionais, para que o serviço se mantenha impulsionado a desenvolver as ações voltadas para o enfrentamento da violência e promover atividades de prevenção, promoção da saúde e da cultura de paz, agregando instituições, serviços, profissionais e sociedade civil.

7.4. Seguimento em rede e cuidado compartilhado

O seguimento na Rede de Atenção à Saúde (RAS) consiste na continuidade do acompanhamento da pessoa em situação de violência com enfoque no cuidado individualizado e na proteção integral. A decisão dos locais onde poderá se dar o seguimento depende do levantamento de necessidades, critérios de elegibilidade para inclusão no serviço e planejamento individualizado para cada caso. Caso a pessoa não apresente sintomas de estresse pós traumático e/ou manifestações de sofrimento psíquico relacionado ao evento de violência e/ou esteja em risco de sofrer novas violências,

poderá por exemplo, ser acompanhada pela atenção primária ou CAPS, a depender da sua condição de saúde física e mental.

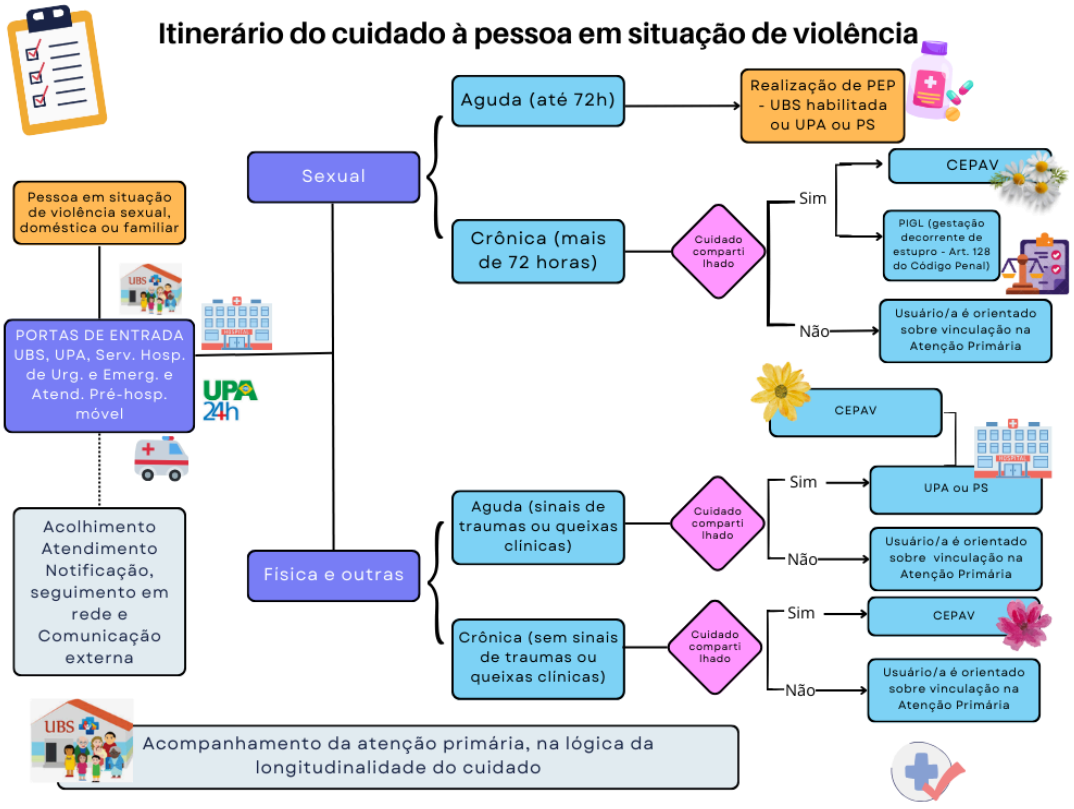
A garantia do seguimento na RAS requer que as práticas nos diferentes níveis de atenção e gestão estejam alinhadas com os protocolos e fluxos, com a pactuação de protocolos específicos para atendimento a pessoas em situação de violência, com o estabelecimento de rotinas de interconsultas, de número de retornos, de realização e avaliação de exames complementares e de reuniões de equipe para avaliação da evolução e prognóstico clínico e social de cada caso.

Visando à ação contínua, cooperativa e interdependente, mantendo uma organização poliárquica, de missão única e com objetivos comuns, a RAS pode dialogar com outros serviços do sistema de proteção social e garantia de direitos, no âmbito da rede intersetorial.

Itinerário e Compartilhamento de Cuidado em Saúde

O itinerário do cuidado começa com o acolhimento, que deve ser realizado pelo primeiro profissional que tiver contato com a pessoa em situação de violência. Os pacientes que serão assistidos pela Atenção Primária e os que deverão ser encaminhados para seguimento nos serviços especializados ou outros componentes da atenção secundária ou terciária precisam ser definidos a partir do diagnóstico situacional em uma lógica de compartilhamento de cuidados. Todo esse manejo deve ser realizado a partir da condição de saúde e da situação de violência.

Veja a seguir o fluxo de atenção a pessoas em situação de violência e compartilhamento de cuidado:



Quadro 2 - Modelo de compartilhamento do cuidado

Condição de saúde	**Local de seguimento e/ou Compartilhamento de cuidado**	**Forma de acesso**	**Competência**
Atenção Primária			
-Pacientes estáveis quanto aos agravos na saúde física e mental relacionados à violência. -Pacientes vítimas de violência sexual aguda (até 72h incompletas). - Pessoas em situação de violência crônica. - Pacientes em situação de violência com outros agravos e/ou demandas específicas. - Paciente encaminhados pela rede intersetorial.	Unidade Básica de Saúde	Demanda espontânea; Demanda programada (Consultas agendadas, visitas domiciliares) Encaminhamento da rede intra e intersetorial.	● Acolhimento; ● Notificação; ●Comunicação externa, se pertinente ● Atendimento; ●Testagem e aconselhamento; ●PEP; ●Vacinação (Hep B e HPV) ●Oferta de práticas integrativas em saúde ● Compartilhamento do caso com a equipe e-Multi ● Encaminhamentos intra e intersetoriais pertinentes
Atenção Ambulatorial Especializada			
-Pacientes com sintomas de estresse pós-traumático e/ou manifestações de sofrimento psíquico	Centro Especializado de Atenção a Pessoas em Situação de	Demanda espontânea; Encaminhamento da rede intra e intersetorial.	● Acolhimento ● Notificação ● Atendimento ● Garantir oferta ou orientação e

diretamente relacionado ao evento de violência. -Pacientes com risco iminente de novas violências.	Violência Sexual, Doméstica e Familiar (CEPAV)		acompanhamento de cuidados profiláticos nas violências sexuais ● Segmento na Rede de Cuidado e de Proteção Social.
- Pacientes em situação de violência com sinais e sintomas de sofrimento mental moderado.	Centro Especializado em Saúde Mental (Acima de 18 anos) [6] Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica(COMPP) (até 11 anos, 11 meses e 29 dias) e Adolescentro (de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias)[7]	Encaminhamento pela APS, via Sistema de Regulação, ou por fluxo específico de cada serviço, especificado na seção Atenção Ambulatorial e Especializada	● Acolhimento ● Notificação ● Atendimento ● Segmento na Rede de Cuidado e de Proteção Social
- Pacientes com quadros de transtornos mentais graves e persistentes. - Pacientes vítimas de violência com sinais e sintomas de sofrimento mental, vinculados à dificuldades graves relacionadas à manutenção do	Centros de Atenção Psicossocial[8]: CAPS I, II e III CAPS AD e CAPS AD III CAPSi	Demanda espontânea; Encaminhamento da rede intra e intersetorial.	● Acolhimento ● Notificação ● Atendimento ● Garantir oferta e acompanhamento de cuidados profiláticos nas violências sexuais ● Segmento na Rede de Cuidado e de Proteção Social

[6] Portaria Nº 72/2024 - Institui os Centros Especializados em Saúde Mental , publicada no DODF Nº 41, de 29 de fevereiro de 2024, p.07.

[7] Nota Técnica DISSAM 1/2018 - Critérios para encaminhamento de Crianças e Adolescentes para os Serviços de Saúde Mental InfantoJuvenil da Atenção Secundária.

[8] Para identificar o CAPS de referência, é importante observar sua modalidade, abrangência territorial e faixa etária.

autocuidado, das atividades laborais e formação e manutenção de rede de apoio social, associadas a transtornos mentais. - Pacientes com tentativa de autoextermínio ou automutilação grave recentes (inferior a 30 dias). - Pacientes em risco de violência autoprovocada.			
Pacientes em situação de violência com outros agravos e/ou demandas específicas.	Outros serviços especializados da atenção secundária: Policlínicas, Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro Especializado em Saúde das Mulheres (CESMU), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (CEDOH), Centro de Atenção ao Diabetes e hipertensão Adulto (CADH), Centro	Encaminhamento via regulação, com exceção do Ambulatório Trans cuja forma de acesso é por demanda espontânea ou encaminhamento da rede	● Acolhimento ● Atendimento ● Notificação ● Segmento na Rede de Cuidado e de Proteção Social

	Especializado em Doenças Infectocontagiosas (CEDIN) e Ambulatório Trans		
Atenção Terciária			
-Pacientes em situação de violência física aguda. -Pacientes vítimas de violência sexual aguda (até 72h ncompletas) (vide NT PEP em vigor).	Serviços de urgência e emergência hospitalar e pré-hospitalar	Demanda Espontânea, com triagem e classificação de risco	● Acolhimento ● Atendimento ● Notificação ● Diagnóstico, tratamento de agravos físicos decorrentes da violência como lesões ou fraturas ●Cuidados profiláticos nas violências sexuais ●Atendimento psicossocial ● Segmento na Rede de Cuidado e de Proteção Social
Pessoas que necessitam de atendimento de urgência psiquiátrica: risco iminente de suicídio, risco de auto ou heteroagressividade, reação aguda a estresse (até 30 dias após a situação de violência), e outras situações elencadas nas notas técnicas da DISSAM em vigor.	- Crianças: HMIB - Adolescentes de 14 a 18 anos e adultos: IHBDF - Adultos: HSVP - Hospitais regionais devem ter leitos psiquiátricos disponíveis.	Demanda Espontânea, com triagem e classificação de risco.	● Acolhimento ● Atendimento ● Notificação ● Atendimento psicossocial ● Segmento na Rede de Cuidado e de Proteção Social

Considerando a APS como principal porta de entrada do sistema de saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, ressalta-se a importância da contrarreferência à APS pelos demais pontos de atenção da RAS, seja Atenção Ambulatorial Especializada ou Atenção Hospitalar, visando ao seguimento em saúde de maneira aproximada, dada a referência territorial. No caso das pessoas autoras de violências privadas de liberdade, destaca-se que esta contrarreferência deve ser realizada às UBS prisionais.

A contrarreferência pode ser feita com a orientação ao paciente e à rede de apoio acerca da necessidade de buscar a UBS de referência, munindo a pessoa sobrevivente da situação de violência de relatório de saúde acerca do atendimento prestado: condutas clínicas, exames e encaminhamentos realizados, medicamentos administrados, sinais de alerta clínicos e psicossociais, número da ficha de notificação e condutas sugeridas pelos setores especializados. Este relatório também pode ser enviado às unidades de referência via SEI, o que se recomenda fazer por meio de processo em caráter sigiloso, prezando pela ética, privacidade e sigilo profissional.

8. Sistemas de Apoio

Os sistemas de apoio são componentes que estruturam as redes de atenção à saúde na perspectiva de promoção de equidade e continuidade do cuidado à saúde destes usuários. O cuidado em saúde das pessoas em situação de violência com os seguintes sistemas de apoio:

- **Sistema de Regulação:** sob gestão do Complexo Regulador, os critérios de encaminhamento para serviços regulados estão previstos nas Notas Técnicas de acesso à Atenção Ambulatorial Secundária e Especializada. As referidas notas estão disponíveis em: http://www.saude.df.gov.br/notas-tecnicas/

- **Sistema de Assistência Farmacêutica:** consiste na programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos. Sobre a assistência farmacêutica para acesso à profilaxia pós-exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), devem ser observados os critérios da Nota Técnica N.º 12/2022 - SES/SAIS/COASIS/DASIS que trata da organização da rede de saúde do Distrito Federal (DF) para a profilaxia pós-exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

- **Sistema Eletrônico de Informação (SEI)**: espaço eletrônico de correspondência entre serviços intra e intersetoriais, que dispõe de ferramenta sigilosa para a redação e envio dos processos, podendo ser utilizado para o compartilhamento de casos e registro de atendimentos de maneira segura, ética e de acordo com o sigilo profissional.

9. Vigilância em Saúde

A Vigilância em Saúde é um conjunto de ações continuadas que favorecem a coleta, análise e o repasse de informações, qualificando dados para que a confiabilidade dos registros possa fornecer subsídios para ações de prevenção e controle de agravos. Nacionalmente, a Vigilância em Saúde, no âmbito da violência, é organizada por meio do Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes (Viva) (BRASIL, 2006), utilizado para coletar dados, analisar as tendências e gerar informações sobre violência para amparar políticas públicas em saúde voltadas a esses agravos. O Viva possui dois componentes (BRASIL, 2016):

- Viva Inquérito (Vigilância Sentinela): é a realização de pesquisa por amostragem, a partir de informações sobre violências e acidentes coletadas em serviços de urgência e emergência, a cada três anos.
- Viva contínuo se refere a vigilância da violência interpessoal/autoprovocada.

Realizar a Vigilância em saúde inclui os seguintes objetivos:

- Identificar, incluir e acompanhar a pessoa que sofreu violência na Rede de atenção e proteção;
- Qualificar, analisar e divulgar as informações coletadas por meio dos Bancos de Informação (Sinan);
- Identificar incompletudes dos campos e acionar unidades notificadoras;
- Monitorar, apoiar e avaliar em conjunto o trabalho realizado em redes;
- Realizar capacitações sobre a ficha de notificação, discutindo a sua importância e qualificando profissionais para o correto preenchimento e lançamento dos dados nos sistemas de informação;
- Contribuir para a construção de fluxos de atenção.

9.1. A Vigilância em Saúde na SES/DF

No Distrito Federal, o Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências - NEPAV é a unidade orgânica de execução, responsável pela gestão da pauta da violência na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O NEPAV executa a Vigilância em Saúde através das seguintes ações:

- Monitoramento do banco de notificação de mortalidade de violência e dos indicadores;
- Qualificação do banco de dados da notificação de violência (completude, qualidade da informação);
- Análise de situação de saúde;

- Elaboração de informes e de boletins epidemiológicos, incluindo recomendações de ações para a gestão e/ou atenção à saúde, disponibilizados no site da SES/DF;
- Qualificação dos profissionais de saúde através do treinamento para preenchimento da ficha de notificação;
- Capacitação em análise de situação e coordenação técnica aos profissionais dos CEPAV;
- Articulação das redes intra e intersetoriais;
- Respostas das demandas de Lei de Acesso à Informação, tanto no âmbito da política pública de saúde quanto na produção de conhecimento acerca da pauta da violência por meio da atuação acadêmica.

Ante ao exposto, verifica-se que a Vigilância em Saúde é um componente essencial da Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência. A relevância dos dados coletados, das informações produzidas e do conhecimento fundamentado pela atuação da Vigilância em Saúde no cenário das situações de violência exige, portanto, capacitações para profissionais de saúde a fim de promover o reconhecimento desse âmbito de atuação e a qualificação das ações profissionais em tal segmento. Isto viabiliza a continuidade das atividades e efetivação do objetivo de se conseguir consistência nas informações coletadas.

10. Rede Intersetorial

A Rede Intersetorial é constituída por equipamentos, serviços e pontos de atenção externos ao âmbito da saúde, com os quais a RAS se articula para viabilizar o seguimento em rede, visando à integralidade do atendimento às pessoas em situação de violência. O trabalho em Rede justifica-se pela “incompletude institucional e profissional, o que implica que nenhuma instituição ou profissional consegue, sozinho/a, apresentar soluções para as situações de violência postas no cotidiano de sua atuação, dada a sua complexidade” (MATOS, 2020, p. 161). O setor saúde possui prerrogativas que fazem de seu papel fundamental na identificação e atenção às situações de violência. Por isso, muitas vezes é o ponto articulador de serviços intersetoriais, visando à integralidade, à proteção social, responsabilização e à garantia de direitos.

Essa rede envolve a atuação conjunta e articulada do poder público e da sociedade civil. Sendo assim, o SUS deve dialogar, estabelecer fluxos referenciados e informações contínuas com os demais equipamentos disponíveis na rede intersetorial e sociedade civil, a fim de planejar conjuntamente as ações para melhor atender as pessoas em situação de violência.

O cuidado em rede intersetorial permite a troca de informações, a articulação institucional e até mesmo a formulação de políticas públicas para a implementação de projetos comuns, além de ações de promoção, prevenção, vigilância das violências, e ensino e pesquisa, que contribuem para a integralidade da atenção, defesa, proteção e garantia de direitos e disseminação da cultura de paz e da não violência.

A Lei nº 13.431/2017 prevê, ainda, que o poder público desenvolva políticas integradas e coordenadas nos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde, que visem garantir os direitos humanos da criança e do adolescente no âmbito das relações domésticas, familiares e sociais, voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de violência, respeitadas as especificidades da vítima ou testemunha e de suas famílias, quando da escuta especializada e o depoimento especial, mediante a implantação de centros integrados de atendimento, de modo a evitar a revitimização relacionada ao fluxo das denúncias de violência, especialmente a sexual.

Em relação aos mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tem-se como principal avanço no regramento a promulgação da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Além desse marco legal, foram instituídos os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres e o documento que orienta a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que adota a implementação de políticas amplas e articuladas, que possam dar conta da complexidade do fenômeno em todas as suas expressões. O enfrentamento requer a ação conjunta dos diversos setores envolvidos (saúde, segurança pública, justiça, educação, assistência social, entre outros), por meio da constituição de uma rede de atendimento. O Plano Distrital de Políticas para Mulheres no DF traz uma perspectiva da transversalidade de gênero na gestão das políticas públicas, buscando articulação intersetorial das ações.

O processo de implementação das ações de atenção em saúde deve buscar a identificação de pessoas expostas à violência, fornecer atendimento imediato e mitigar os danos, se necessário ofertar cirurgia reparadora, garantindo apoio e encaminhamento aos outros setores, incluindo atendimentos psicossociais, dentre outros direitos previstos na Lei nº 8.080/1990, alterado pela Lei 13.427/2017, além de orientação sobre outros serviços da rede como as Delegacias Especializadas e Centros de Referência.

É importante destacar que o Código de Processo Penal, alterado pela Lei n° 13.721/2018 estabelece que será dada prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher. Do mesmo modo, em todos os casos de suspeita ou confirmação violência, cabe ao responsável da rede de proteção social garantir a urgência e a celeridade necessárias aos atendimentos e à produção probatória, preservada a confidencialidade. Daí a importância de se viabilizar a responsabilização prevista em lei a partir da notificação compulsória de violência.

Destaca-se que no DF, além da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (DEAM), Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), foi criada a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (DECRIN), bem como, instituídos marcos legais de reconhecimento a identidade de gênero de travestis, transexuais e transgêneros, o que exige da rede de proteção maior interface e ações articuladas para a defesa e garantia de direitos das pessoas em condições vulneráveis por motivações homofóbicas, transfóbicas, xenófobas, etáriast e/ou sexistas.

Veja a seguir um resumo dos componentes da Rede Intersetorial.

Quadro 4 - Composição da Rede Intersetorial

Sociedade Civil	
Indivíduos próximos às pessoas em situação de violência, tais como família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, voluntários da comunidade etc., considerando a família extensa e/ou ampliada.	
Associações da comunidade, organizações sociais, articulações representativas (Redes e Fóruns), bem como demais setores da sociedade civil organizada que atuam para a proteção das pessoas em situação de violência.	
Poder Público	
Eixos	**Serviços, equipamentos e instituições**
Defesa de Direitos: Devem garantir o acesso à justiça, recursos às instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal.	Conselho Tutelar, Defensoria Pública e Núcleos Especializados, Delegacias Especializadas, ProVid/PMDF; Instituto Médico Legal, Ministério Público e Varas Judiciais, CDPCT- Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, canais de denpuncia como Disque 100, 180 e 197.
Promoção de Direitos: Desenvolvem políticas de promoção e proteção dos direitos em caráter transversal e intersetorial. É composto pelas instituições executoras de políticas sociais.	Sistema Único de Assistência Social: CRAS e CREAS, Serviços de Acolhimento, Unidade de Proteção Social 24h Segurança Pública: PROVID Política Setorial da Mulher: Casa da Mulher Brasileira, CEAM, Casa Abrigo, Programa Direito Delas Atenção aos autores de violência doméstica e familiar: Espaço Acolher - destinado ao atendimento de autores de violência; Sistema Prisional, Escritório Social da FUNAP/SEJUS e demais políticas setoriais.
Controle de Efetivação de Direitos:	Conselhos de direitos: Criança e do Adolescente; Mulheres, Pessoas idosas, pessoas

Realiza o controle das ações de promoção e defesa dos direitos.	com deficiência, bem como demais conselhos setoriais (saúde, educação, etc.).

Diversas iniciativas são adotadas pela rede intersetorial nos territórios como fomento de pesquisas, oficinas para estudos de caso, capacitações e reuniões técnicas, debates, estratégias e ações conjuntas para o atendimento e o acompanhamento dos casos de situações de violência. Assim, a rede intersetorial é um espaço potente para que se previna a reincidência e se evite a revitimização, já que os órgãos envolvidos irão atuar de forma articulada ao encaminhamento responsável sem a necessidade de repetição do relato pela vítima, além de reduzir a sobreposição de ações e a duplicidade de informações.

10.1. Comunicação Externa de situações de violência

Na perspectiva da atuação intersetorial, existem normativas e determinações legais que exigem a comunicação externa, pelo setor saúde, aos órgãos de proteção social e garantia de direitos, como Conselhos Tutelares, Delegacias de Polícia, Ministério Público e outros órgãos de proteção e responsabilização - o que deve ser feito sob legitimidade de atuação em rede, livre de qualquer teor especulativo, expositivo, revitimizador ou punitivo.

A Comunicação Externa tem o objetivo de contribuir para a proteção da pessoa que sofreu a violência e para a responsabilização do autor da violência. O consentimento da vítima para sua realização depende do tipo de violência e da legislação a este aplicada, sem prescindir dos dispositivos éticos de cada profissão, bem como da prerrogativa do sigilo profissional e da avaliação de risco. Salienta-se, sobretudo, este último aspecto, para assegurar a integridade da pessoa em situação de violência, para quem, a depender do caso, determinado tipo de intervenção intersetorial pode significar mais risco em vez de proteção.

Nota-se que todos os crimes contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis terão a ação movida pelo Ministério Público mesmo quando a vítima for maior de 18 anos. Esta ação não depende do desejo ou consentimento da vítima, por se tratar de Ação Civil Pública Incondicionada. Paralelamente, em relação às ações de proteção social e de prevenção das violências no âmbito das políticas públicas, tem-se diversas iniciativas de articulação conforme os ciclos de vida, bem como, ações afirmativas de segmentos vulneráveis da população.

O quadro a seguir detalha as especificidades da comunicação externa:

Pessoa em situação de violência	Dispositivo legal	Órgão a ser comunicado	Especificações
	- CF/1988, art. 227, caput; - **Lei Nº 8.069, art. 13** (Estatuto da Criança e do Adooescente - ECA)	- Conselho Tutelar e/ou Polícia Civil (Delegacias Especializadas no Atendimento de	- Obrigatória para todos os tipos de violência - Independentemente de autorização prévia.

Crianças e Adolescentes		Crianças/Adolescentes - DCPCA ou Comum, onde não existe a especializada).	- Documento deve informar dados pessoais sobre vítima, suposto autor e síntese da suspeita de violência.
Pessoas Idosas	- CF/1988, art. 230, caput; - Estatuto do Idoso, art. 19 (ref)	- Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa (CDI) e/ou Central Judicial do Idoso (que é composta por Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público).	- Obrigatória para todos os tipos de violência - Independentemente de autorização prévia. - Documento deve informar dados pessoais sobre vítima, suposto autor e síntese da suspeita de violência.
Pessoas com deficiência	- Lei nº 13.146/15, Art. 26	- Ministério Público e/ou Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CODDEDE) e/ou DECRIN.	- Obrigatória para todos os tipos de violência - Independentemente de autorização prévia. - Documento deve informar dados pessoais sobre vítima, suposto autor e síntese da suspeita de violência.
Mulheres	- Art. 3o. da Lei nº 10.778/2003 - Lei 13.931 de 10 de dezembro de 2019 - Portaria consolidada nº 4 MS - Nota Técnica Conjunta nº 01 NG/NDH/PROSUS/PROREG/MPDFT e NUDEM/DPDF de 2020 - Nota Técnica Conjunta n. 01/2022-NG/MPDFT - PORTARIA GM/MS nº 78, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 - Portaria GM/MS nº 1077 de 2021 (revogou arts. 14D 14E e 14F da e anexo IV PORTARIA GM/MS nº 78)	Delegacia Especializada no atendimento à Mulher (DEAM) ou delegacia comum onde não houver.	- Excepcional com consentimento da vítima em qualquer tipo de violência. - Documento deve informar dados pessoais sobre vítima, suposto autor e síntese da suspeita de violência. - Excepcional sem consentimento da vítima para casos em que houver risco à vítima ou à comunidade. - Documento deve informar dados pessoais sobre vítima, suposto autor e síntese da suspeita de violência.

			- Sem identificação da vítima em qualquer tipo de violência, exceto em casos de risco à vítima ou à comunidade. - Documento deve informar dados sobre cor, idade, violência sofrida, região de notificação.
Indígenas	-Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas - PNASPI (Portaria MS Nº 254, de 31 de janeiro de 2002)	- Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/MS) e Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI (MJ).	- Obrigatória para todos os tipos de violência. - Independentemente de autorização prévia. - Documento deve informar dados pessoais sobre vítima, suposto autor e síntese da suspeita de violência.

O anexo II desta Linha de Cuidado apresenta modelo de formulário para comunicação externa em casos de suspeita de violência para crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoas idosas e pessoas indígenas. O anexo III apresenta modelo de formulário para comunicação externa em casos de violência contra mulher. **Tais formulários deverão ser enviadas aos órgãos da rede de proteção e responsabilização via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) de modo restrito ou sigiloso.**

Nos casos de violência contra mulher, o Art. 3º da Lei 10.778/2003 esclarece que:

> Art. 3º A notificação compulsória dos casos de violência de que trata esta Lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido.
>
> Parágrafo único. A **identificação da vítima de violência** referida nesta Lei, fora do âmbito dos serviços de saúde, **somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional,** em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável.

Nessas situações, a mulher ou, em casos excepcionais, seu responsável/rede de apoio devem ser informados sobre a comunicação da situação de violência ao órgão competente, com devido registro em prontuário. Para embasamento desta avaliação sobre riscos, nos casos de violência doméstica, o Decreto N.º 46.926, de 26 de fevereiro de 2025, regulamentou a Lei 6.912/2021, de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre o emprego do Formulário Nacional de Avaliação de Risco como instrumento de coleta de informações para o enfrentamento e a prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher e do feminicídio e cria o Sistema Distrital de Avaliação de Risco no Distrito Federal. A partir desta legislação, deve-se utilizar o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FONAR) no âmbito do DF (Anexo IV).

Em relação à Lei 13.931, de 10 de dezembro de 2019, que prevê que os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher deverão ser obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no prazo de 24 horas, para as providências cabíveis e para fins estatísticos. A **Portaria GM/MS Nº 78, de 18 de janeiro de 2021** traz orientações sobre esse processo, conforme descrito em seu Art 14-B:

> "Art. 14-B. Caberá a unidade de saúde comunicar à autoridade policial os casos de violência interpessoal contra a mulher no prazo de 24 horas, contados da data da constatação da violência.
>
> § 1º Nos casos em que não for possível a comunicação de que trata o caput, caberá à autoridade sanitária estadual proceder à comunicação à autoridade policial no prazo de 24 horas após a consolidação semanal da base estadual do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (VIVA SINAN).
>
> § 2º A unidade de saúde que proceder à comunicação à autoridade policial dos casos de violência interpessoal contra a mulher deverá encaminhar à autoridade sanitária local a ficha de comunicação". (NR)

A Portaria GM/MS nº 78/2021 ainda informa no Art. 14-C que caberá à autoridade sanitária a pactuação, junto ao órgão de segurança, em relação à qual autoridade policial será referência para recebimento das comunicações de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados. Essas comunicações externas deverão ser encaminhadas aos órgãos competentes via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) de modo restrito ou sigiloso.

11. Educação em Saúde

A atenção à saúde de pessoas em situação de violência requer um processo educativo constante de aprendizado pelo trabalho, que possibilite a projeção de ideias, concepções e práticas que produzam mudanças para o rompimento com o ciclo da violência. De acordo com o MS (2012) Educação Permanente em Saúde (EPS) se refere às

> ações educativas embasadas na problematização do processo de trabalho em saúde e que tenham como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, a reorganização da gestão setorial e a ampliação dos laços da formação com o exercício do controle social em saúde (BRASIL, 2012).

Nessa direção, a implementação da EPS reconhece que o trabalho no SUS comprometido com o coletivo é campo propício para a construção do conhecimento a partir do cotidiano dos profissionais, pois são estes os principais detentores da tomada de decisão sobre acolher, promover escuta ativa e empática, cuidar e responder a população assistida. Este processo de aprendizagem tem, ainda, uma perspectiva de educação da sociedade na medida em que realiza ações educativas que têm como objetivo promover a educação em saúde, mediante inclusão social e promoção da autonomia das populações na participação em saúde.

11.1. Educação Permanente dos Profissionais de Saúde da RAS

A Educação Permanente em Saúde é fundamental para a compreensão da violência, sua relação com a saúde física e mental dos indivíduos e a forma como toda a sociedade é afetada por ela. Todo profissional de saúde deve estar preparado para lidar com situações de violência e, para tanto, é necessário conhecer o papel dos principais agentes da rede de proteção e responsabilização; saber como encaminhar denúncias, quais os caminhos legais que precisam ser acionados e qual cuidado à saúde a ser ofertado.

Nesse sentido, uma das estratégias de EPS é o acompanhamento e apoio técnico aos profissionais que atendem as pessoas em situação de violência. Este processo oportuniza ao trabalhador participar da discussão, da tomada de decisão e do aperfeiçoamento das estratégias de intervenção. A EPS envolve gestores e profissionais da assistência, para que se apropriem dos principais conceitos e, mais do que isso, revejam seus valores e posturas, incorporando no dia a dia os princípios da cultura de paz.

Sob a ótica da vigilância epidemiológica, o grande desafio é alcançar os profissionais que desenvolvem suas ações nas diversas unidades de saúde, de forma regionalizada, visando uma padronização e qualificação da notificação compulsória. Este processo deve dar conta da complexidade da dinâmica social, do avanço tecnológico, bem como da diversidade das práticas existentes na saúde coletiva e da gama de profissionais envolvidos. Na organização institucional da política pública de saúde do DF, essas estratégias e iniciativas estão sob a responsabilidade do Gestor da Atenção às Pessoas em Situação de Violência, em âmbito regional, em parceria com os respectivos CEPAV e com o Nepav.

Para a implementação desta Linha de Cuidado, é importante um diálogo contínuo com as unidades de saúde, com foco na EPS dos profissionais por meio de metodologias diversas, interativas e significativas de compartilhamento do conhecimento, bem como de pesquisas nos serviços sobre a temática do cuidado às pessoas em situação de violência e da cultura de paz. Algumas diretrizes apontadas para o processo de EPS são:

- Contribuir para a implementação da proposta da Linha de Cuidado e a regionalização da atenção integral, incluindo os aspectos da vigilância epidemiológica;

- Ressignificar e aprimorar os conhecimentos e práticas escolarizadas, incorporando perspectivas interdisciplinares com vistas à compreensão das questões de gênero, raça e classe que atravessam a determinação social da saúde;

- Debater, a partir dos casos concretos do cotidiano do serviço, com apoio matricial, os estigmas relacionados às situações de violência, com vistas à EPS focada na ruptura do estigma e qualificação técnica para prestação da assistência adequada às pessoas em situação de violência;

- Expor aos profissionais as redes intra e intersetorial de atenção às pessoas em situação de violência, discutindo critérios de elegibilidade para o atendimento, com vistas ao exercício ativo da identificação de casos pertinentes ao encaminhamento e articulação com cada ponto das redes de atenção;

- Atualizar, do ponto de vista conceitual e organizacional, as questões relacionadas à vigilância epidemiológica, apresentando os instrumentos do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da violência;

- Aprimorar o conhecimento dos profissionais da assistência acerca do correto preenchimento, lançamento e fluxo das notificações de violências interpessoais e autoprovocadas, sob a ótica da atuação em rede e da ruptura da perspectiva burocrática da notificação compulsória;

- Debater, a partir de casos concretos do cotidiano do serviço, com apoio matricial, a importância das ações de vigilância em saúde, com ênfase na vigilância epidemiológica, a fim de sensibilizar profissionais sobre o papel da vigilância epidemiológica na elaboração, gestão e execução da política pública de saúde;

- Instrumentalizar os profissionais a partir da capacitação para o uso de ferramentas de gestão, como diagnóstico situacional e o planejamento integrado das ações territoriais, utilizando o referencial epidemiológico para análise da situação em saúde e o planejamento das ações;

- Planejar ações contínuas de educação permanente em saúde sobre atenção às pessoas em situação de violência, a fim de garantir a implantação da Linha de Cuidado, contemplando todas as dimensões do cuidado;

- Combater todos os tipos de violência, articulando a Linha de Cuidado de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência e a Política Nacional de Humanização.

11.2. Educação da Sociedade: Promoção da saúde, da cultura de paz e prevenção de violências

O enfrentamento ao fenômeno da violência na perspectiva da saúde passa não só pelo atendimento, notificação e encaminhamentos dos casos, mas também pela elaboração e execução de estratégias de prevenção, priorizando a qualidade de vida e a promoção da saúde e da cultura de paz.

Sendo assim, é possível que profissionais de saúde atuem tanto no nível individual, quanto no nível coletivo, promovendo reflexões que transformem o comportamento, a vida familiar e as relações sociais e comunitárias para fortalecimento de vínculos e da resiliência. Além de atuarem na identificação de situações no âmbito individual, familiar e comunitário que podem gerar maior vulnerabilidade às práticas violentas.

Essas ações podem acontecer no cotidiano dos profissionais de saúde que estão em contato com indivíduos, famílias e comunidades durante os atendimentos, pois a intervenção do profissional pode favorecer a saúde física e emocional em nível individual e coletivo, visando à prevenção da violência sexual, familiar e doméstica.

Todavia, a violência é um fenômeno multifatorial, que não se restringe exclusivamente à saúde, mas também a diversas áreas de políticas públicas como a segurança pública, educação, assistência social, dentre outras. Portanto, é também responsabilidade da Rede intersetorial esforços conjuntos para a realização de campanhas e atividades de mobilização, que orientem a população sobre os serviços de apoio, formas de acesso, estratégias de proteção e prevenção.

Atitudes preventivas dos profissionais de saúde para promoção da saúde e da cultura de paz:

- criar espaços e grupos para que as famílias/responsáveis possam compartilhar experiências, ouvir relatos e receber orientações discutindo estratégias de enfrentamento às situações de violência;
- realizar educação sexual, com linguagem apropriada às faixas etárias, abordando formas de prevenção a possíveis violências, informando sobre situações de risco e toques corporais adequados e inadequados;
- promover iniciativas de educação popular em saúde, de modo a sensibilizar pessoas, famílias e comunidades sobre o exercício saudável da sexualidade, prevenção de violências sexuais, sobre métodos de planejamento familiar, que incluem métodos contraceptivos, como pílulas anticoncepcionais, DIU, preservativos, e métodos cirúrgicos.
- apoiar as famílias no desenvolvimento de estratégias para identificar e lidar com situações que podem gerar maior vulnerabilidade às práticas violentas;
- buscar apoio de outros profissionais, quando julgar pertinente, e articular as ações desenvolvidas no serviço com as redes intrasetorial e intersetorial;
- participar, junto com a rede social do território, de ações de mobilização em datas alusivas à prevenção e enfrentamento das violências.

11.3. Indicadores para o Monitoramento e a Avaliação da Vigilância na Temática da Violência

Os indicadores em saúde são recursos utilizados para o monitoramento de ações e do planejamento em saúde. Na SES/DF, a Subsecretaria de Planejamento em Saúde - SUPLANS é a responsável pelo planejamento e monitoramento, incluindo os indicadores de todas as áreas técnicas. O indicador em vigor que encontra-se no Plano Distrital de Saúde (PDS) está descrito a seguir:

Objetivo	Organizar a rede de atenção às pessoas em situação de violência, promovendo atenção integral									
Meta	**Indicador**	**Índice de Referência**	**Unidade de Medida**	**Polaridade**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Instrumento**	**Responsável**
Aumentar a taxa de notificação de violências para 12,5% ao ano, no Distrito Federal, até 2027	Taxa de notificação de violência do DF	341,15	Taxa (por 100.00 hab.)	Maior Melhor	432	486	546	615	PDS	SES SVS DIVEP GVDANTPS NEPAV SAIS ARAS

O alcance de metas e o estabelecimento de indicadores no processo de planejamento, monitoramento e avaliação em saúde não pode ser uma gradação métrica e tecnicista, mas sim o reflexo da ação coletiva de equipes de saúde assistenciais, gestoras e da comunidade, com vistas ao planejamento integrado e dinâmico de ações concretas de saúde. Por isso, espera-se que a

sistematização desta Linha de Cuidado por meio deste documento subsidie profissionais da RAS à atenção ética e humanizada às pessoas em situação de violência; ao aprimoramento das práticas profissionais; à qualificação das políticas públicas e, sobretudo, à promoção da saúde e da cultura de paz.

Neste sentido, o grupo condutor da Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência (RAV) se dispõe aos profissionais de todos os níveis de atenção à saúde no DF para colaborar com o serviço, com as iniciativas de educação permanente e educação popular em saúde e com o aprimoramento das práticas profissionais, a fim de que o DF seja referência no cuidado às pessoas em situação de violência.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A publicação da *Linha de Cuidado para Atenção em Saúde às Pessoas em Situação de Violência* Sexual, Doméstica e Familiar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal representa um marco fundamental no fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento às violências. Este documento reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde com a integralidade do cuidado, a proteção da vida e a promoção da dignidade humana, orientando profissionais e gestores para uma atuação ética, qualificada e sensível às múltiplas formas de violência que afetam indivíduos e comunidades.

As quatro dimensões do cuidado desta LC — **acolhimento, notificação das violências, atendimento e seguimento em rede** — são pilares indissociáveis que estruturam uma resposta efetiva e humanizada. O acolhimento é o ponto de partida, onde o respeito, a escuta qualificada e a empatia criam um ambiente seguro para que a vítima se sinta amparada e compreendida. A notificação, além de obrigação legal, é um instrumento estratégico para a vigilância, o planejamento e a formulação de políticas públicas, contribuindo para a visibilidade e o enfrentamento da violência como problema de saúde pública.

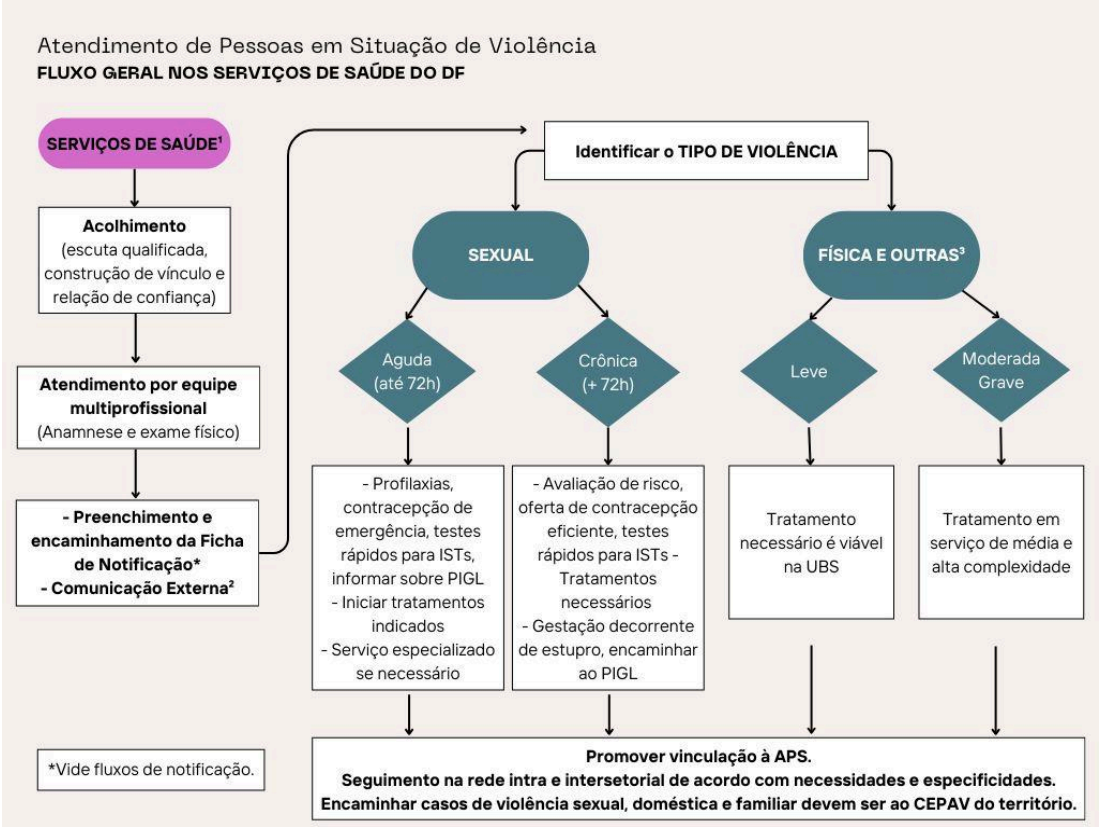
O atendimento deve ser realizado de forma integral e interdisciplinar, considerando as especificidades de cada caso, respeitando as particularidades de gênero, idade, condição de saúde e vulnerabilidades sociais. Já o seguimento em rede é essencial para a continuidade do cuidado, articulando os diferentes níveis de atenção e os diversos setores envolvidos, como assistência social, educação, segurança pública e sistema de justiça.

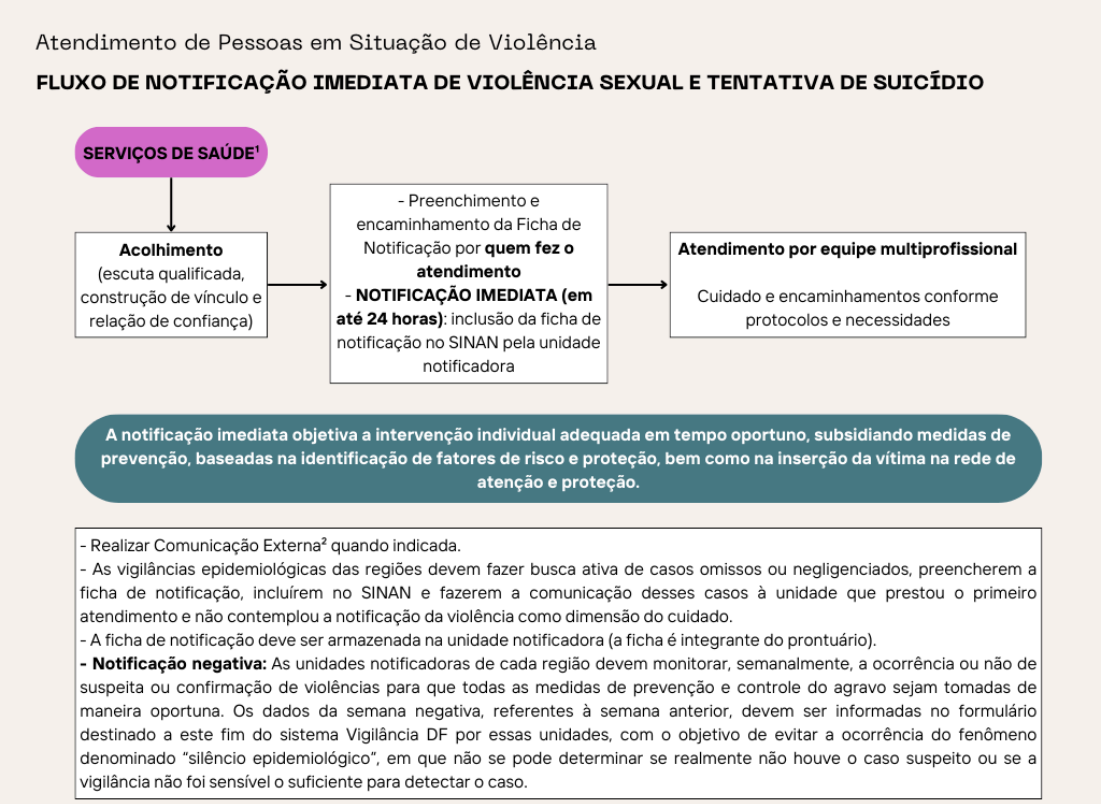
Reconhecendo a complexidade e a transversalidade do tema da violência, é imprescindível fortalecer as ações interinstitucionais. A efetividade da linha de cuidado depende da cooperação entre as diferentes políticas públicas, da construção de fluxos compartilhados e da corresponsabilidade entre os atores envolvidos. Somente com uma atuação integrada e comprometida será possível romper os ciclos de violência, promover a reparação dos danos e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, segura e acolhedora para todas as pessoas.

Assim, esta linha de cuidado se propõe não apenas como um instrumento técnico, mas como um compromisso ético e político com a vida e com os direitos humanos.

A presente publicação é fruto de um trabalho coletivo revisitado pelo Grupo Condutor Distrital da Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência. A revisão desta Linha de Cuidado é um compromisso da RAV e sua implementação um compromisso dos profissionais de saúde por uma saúde pública que contribua com a atenção, cuidado e enfrentamento de todas as formas de violência.

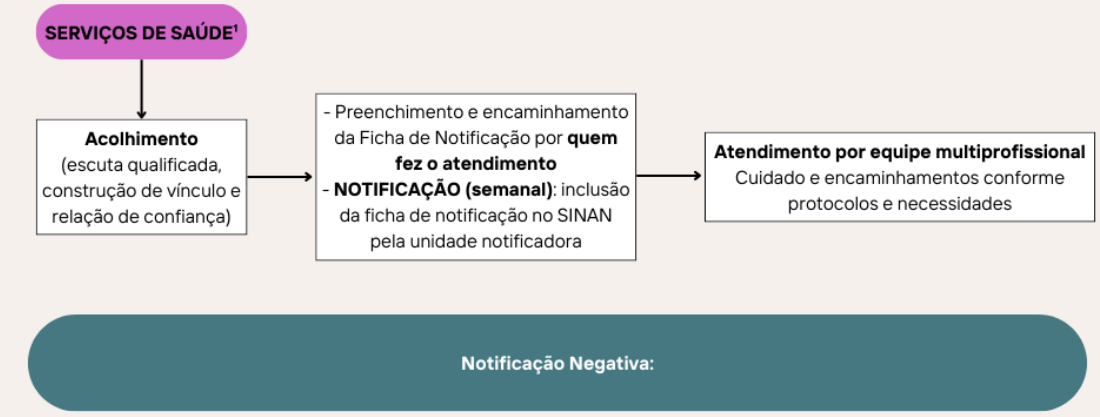
13. FLUXOGRAMAS ASSISTENCIAIS





Atendimento de Pessoas em Situação de Violência

FLUXO DE NOTIFICAÇÃO DE OUTROS TIPOS DE VIOLÊNCIA



Notificação Negativa:

- Realizar Comunicação Externa[2] quando indicada.
- As vigilâncias epidemiológicas das regiões devem fazer busca ativa de casos omissos ou negligenciados, preencherem a ficha de notificação, incluírem no SINAN e fazerem a comunicação desses casos à unidade que prestou o primeiro atendimento e não contemplou a notificação da violência como dimensão do cuidado.
- A ficha de notificação deve ser armazenada na unidade notificadora (a ficha é integrante do prontuário).
- Notificação negativa: As unidades notificadoras de cada região devem monitorar, semanalmente, a ocorrência ou não de suspeita ou confirmação de violências para que todas as medidas de prevenção e controle do agravo sejam tomadas de maneira oportuna. Os dados da semana negativa, referentes à semana anterior, devem ser informadas no formulário destinado a este fim do sistema Vigilância DF por essas unidades, com o objetivo de evitar a ocorrência do fenômeno denominado "silêncio epidemiológico", em que não se pode determinar se realmente não houve o caso suspeito ou se a vigilância não foi sensível o suficiente para detectar o caso.

1. Serviços de Saúde: notificam os casos suspeitos ou confirmados de violências e encaminham as pessoas para a rede de atenção e proteção, de acordo com necessidades de cada caso e com o tipo e natureza/forma de violência.

2. Comunicação Externa é obrigatória nas seguintes situações:

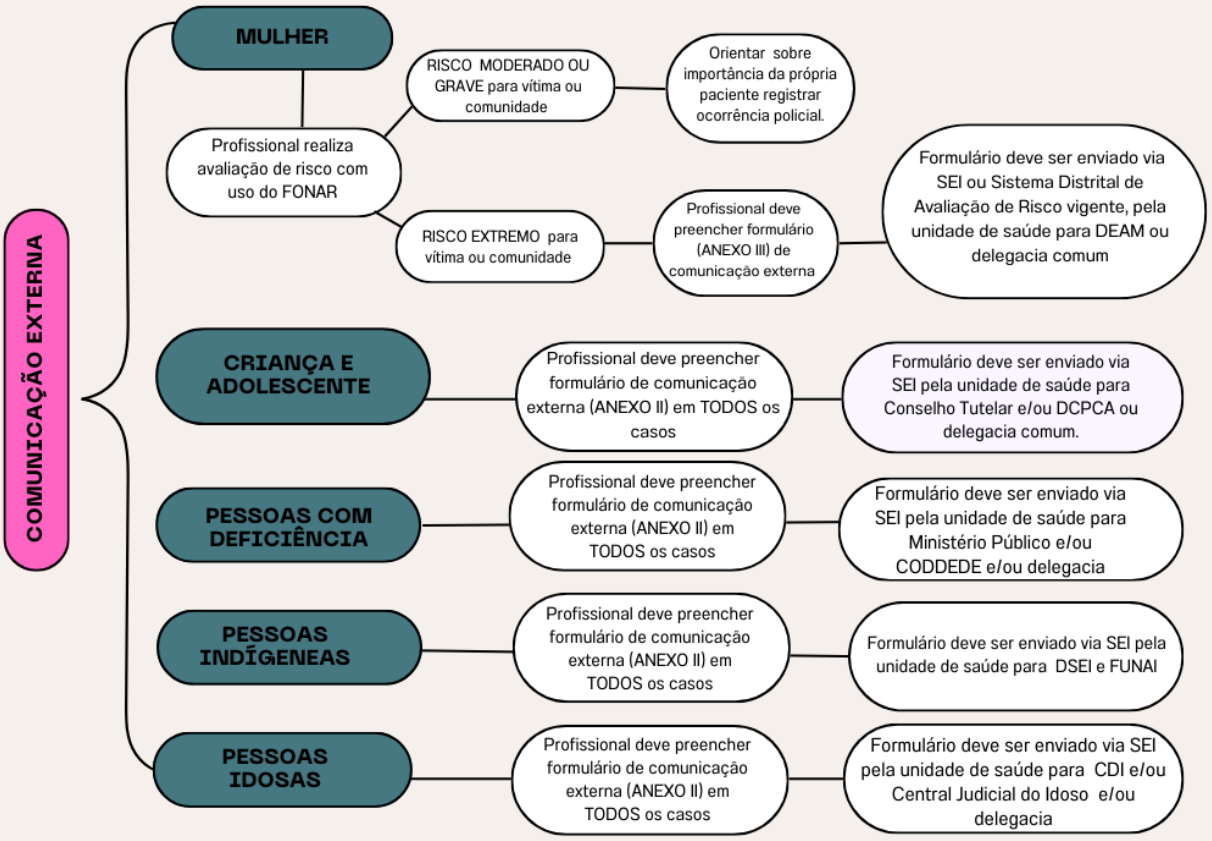
- Violência contra **crianças e adolescentes**: comunicar ao Conselho Tutelar, de acordo com a Lei n.º 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 13 de julho de 1990.
- Violência contra **pessoas idosas**: comunicar aos órgãos de defesa de direitos (Ministério Público ou Conselho do Idoso) ou para os órgãos de responsabilização (delegacias gerais ou especializadas), em conformidade com a Lei n.º 10.741 (Estatuto do Idoso), de 1º de outubro de 2003, e a Lei n.º 12.461, de 26 de julho de 2011.
- Violência contra **pessoas com deficiência**: comunicar aos órgãos de proteção e defesa de direitos, conforme disposto no artigo 26 da Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, uma vez que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência determina, no referido artigo, a comunicação de violências contra pessoas com deficiência à "autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência".
- Violência contra **indígenas** : FUNAI / DSEI, em conformidade com Portaria MS Nº 254, de 31 de janeiro de 2002.
- Violência contra **mulheres**: comunicar à autoridade policial, conforme Lei n.º 10.778, de 24 de novembro de 2003, alterada pela Lei n.º 13.931, de 10 de dezembro de 2019, e Portaria GM/MS n.º 78, de 18 de janeiro de 2021.
    - A comunicação dos casos de violência contra a mulher à autoridade policial deverá ser feita:
        - de forma sintética e consolidada, sem dados que identifiquem a vítima e o profissional de saúde notificador (Anexo 4 do Anexo V da Portaria GM/MS n.º 78, de 18 de janeiro de 2021); ou
        - excepcionalmente com identificação da vítima de violência, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade sanitária° e com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável.

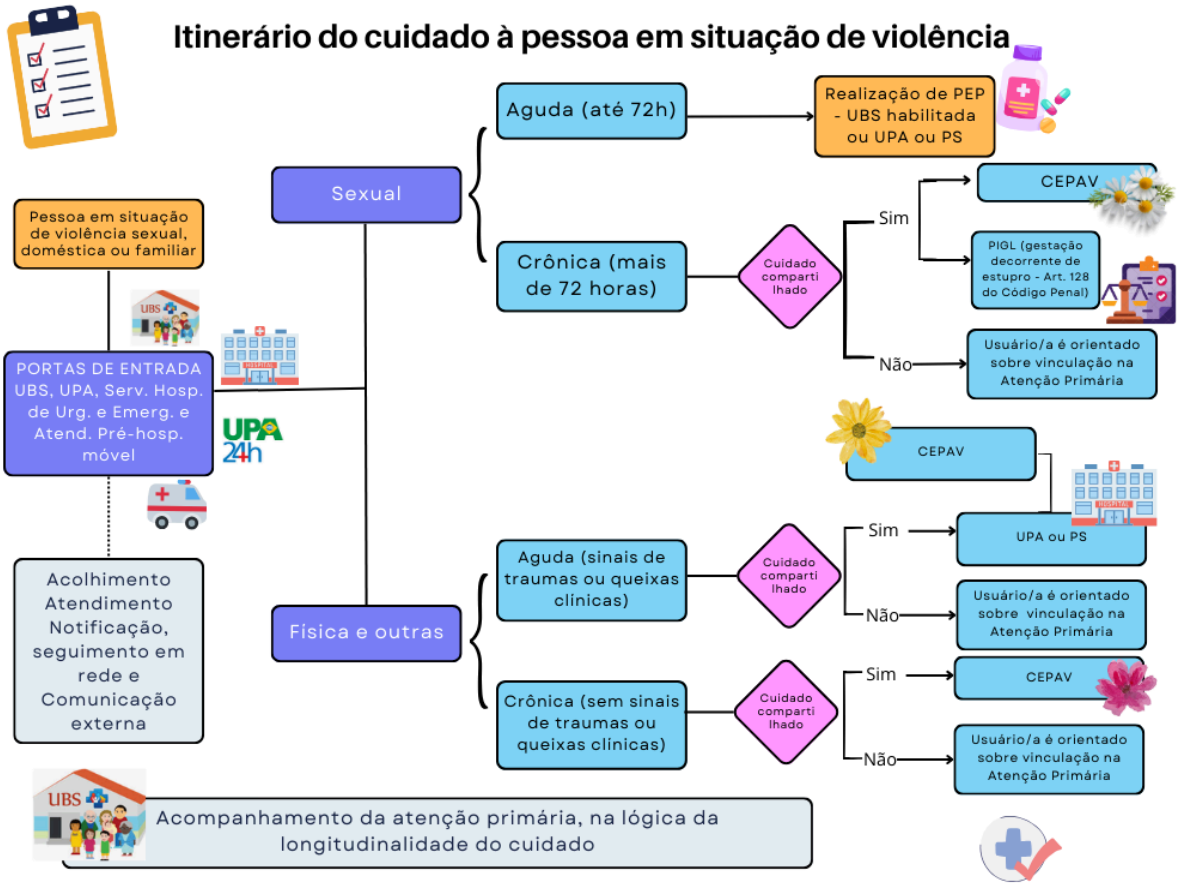
°Vide formulário de avaliação de risco.

3. Outros tipos de violência: violência psicológica/moral; tortura; tráfico de seres humanos; violência financeira/econômica; negligência/abandono; trabalho escravo; trabalho infantil; intervenção legal; violências lgbtfóbicas.

ATENDIMENTO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

FLUXOGRAMA DA COMUNICAÇÃO EXTERNA





14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KRUG, E. G. et al. *World report on violence and health*. Geneva: World Health Organization, 2002.

BRASIL. Portaria nº 900, de 21 de agosto de 2018. Instituir Colegiado Gestor Técnico da Atenção Integral à Violência. Brasília, DF, set 2018. Disponível em: <http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2018/09_Setembro/DODF%20180%2020-09-2018/DODF%20180%2020-09-2018%20INTEGRA.pdf>.

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Viva: instrutivo notificação de violência interpessoal e autoprovocada [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. *Viva: instrutivo notificação de violência interpessoal e autoprovocada* [recurso eletrônico]. 2 ed, Brasília, 2016.

BRASIL. Código Penal (1940). Código Penal Brasileiro. Rio de Janeiro, RJ, dez 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- lei/del2848compilado.htm>.

BRASIL. Lei n.º13.718, de 24 de setembro de 2018. Tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro. Brasília, DF, set 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13718.htm>.

BRASIL. Lei n°12.015, de 7 de agosto de 2009. Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954, que trata de corrupção de menores. Brasília, ago 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2009/lei/l12015.htm>.

BRASIL. Lei n° 11.829 de 25 de novembro de 2008. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet. Brasília, nov 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2008/lei/l11829.htm>.

BRASIL. Lei n° 12.288 de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. Brasília, jul 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2010/Lei/L12288.htm>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência sexual: perguntas e respostas para profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Pragmáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico n. 8, Notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2015 a 2021. Ed. MS 2023.

MINAYO, M. C. de S.. A inclusão da violência na agenda da saúde: trajetória histórica. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro , v. 11, p. 1259-1267, 2006.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE. *Violência intrafamiliar: orientações para prática em serviço.* Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2002.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf. Acesso em: 23 nov. 2023.

INSTITUTO DE PESQUISA APLICADA - IPEA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Atlas da violência 2019.* Brasília: Rio de Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019.

D´Oliveira, A.F.P.L Atenção Primária à Saúde. Protocolo de atendimento a mulheres em situação de violência. Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e University of Bristol, Junho de 2019.

Giovanella, Lígia (org.) Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2. ed. rev. e amp. / organizado por Lígia Giovanella, Sarah Escorel, Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato et al. –Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012. 1100 p. il., tab., graf. ISBN: 978-85-7541-417-0

PAIM, Jairnilson Silva et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. 2011.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. VIVA: vigilância de violências e acidentes, 2008 e 2009/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Análise de Situação de Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 138p.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. **Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres**, 2011. Brasília: Presidência da República, 2011. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/copy_of_acervo/outras-referencias/copy2_of_entenda-a-violencia/pdfs/politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres

BRASIL. Portaria nº 773, de 19 de julho de 2018. Estabelece diretriz e normas para a organização da Atenção Ambulatorial Secundária. Brasilia, DF, ago 2018. Disponível em: <http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/82c3196081194fa3b7cd6862311bca ca/Portaria_773_19_07_2018.html>.

BRASIL. Lei n. 6.259 de 30 de outubro de 1975. Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências. Brasília, set 1975. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6259.htm>.

BRASIL. Portaria n° 204 de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. Brasília, fev 2016. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016. html>.

BRASIL. Ministério da Saúde. GUIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, 2021. Disponível em: file:///C:/Users/14346028/Downloads/Guia%20de%20Vigil%C3%A2ncia%20em%20Sa%C3%BAde_5ed_21nov21_isbn5.pdf.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF. Disponível em: < https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html >

MATOS, C. R. A. de. A política pública de enfrentamento à violência contra a mulher e o trabalho em rede. In: OLIVEIRA A. S. et al. Contribuições para a formação de profissionais da segurança pública no enfrentamento da violência contra a mulher. Brasília: PMDF, TJDFT. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.931, de 10 de dezembro de 2019. Altera a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, para dispor sobre a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. Brasília, DF, dez 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019- 2022/2019/lei/L13931.htm>.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; GUERRIERO, Iara Coelho Zito. Reflexividade como éthos da pesquisa qualitativa. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, n. 4, p. 1103-1112, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/DgfNdVrZzZbN7rKTSQ8v4qR/#. Acesso em: 11 out 2021.

SOUSA, Maria Fátima de (Coord.) Práticas de enfermagem no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS): estudo nacional de métodos mistos. Relatório final. Núcleo de Estudos em Saúde Pública (NESP), Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM), Universidade de Brasília (UnB), Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Brasília: Editora ECoS, 2022.

BRASIL. Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências. Brasília, dez 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2009/Decreto/D7053.htm>.

BRASIL. Lei n° 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Brasilia, DF, mar 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2016/lei/l13257.htm>.

BRASIL. Decreto 39.087 de 29 de maio de 2018. Institui a Política Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Distrito Federal e dá outras providências. Brasília, DF mai 2018. Disponível em: <http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/790ed667434a4ad4a0b972d6fcd4773b/Decreto_39087_29_05_2018.html>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação em Saúde, 2009. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33856/396770/Pol%C3%ADtica+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+Permanente+em+Sa%C3%BAde/c92db117-e170-45e7-9984-8a7cdb111faa>.

DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 42.542, de 28 de setembro de 2021. Institui a Política Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes do Distrito Federal. Brasília, DF. Diário Oficial do Distrito Federal, 2021.

BRASIL. Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, DF. Diário Oficial da União, 2017.

DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 42.590, de 07 de outubro de 2021. Aprova o II Plano Distrital de Políticas Públicas para as Mulheres, institui o Comitê de Monitoramento providências. Brasília, DF. Diário Oficial do Distrito Federal, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 78, de 18 de janeiro de 2021. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as diretrizes para a comunicação externa dos casos de violência contra a mulher às autoridades policiais, no âmbito da Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. Brasília, DF. Diário Oficial da União, 2021.

BRASIL. Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. Brasília, DF. Diário Oficial da União, 2003.

BRASIL. Lei nº 14.149, de 05 de maio de 2021. Institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a ser aplicado à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Brasília, DF. Diário Oficial da União, 2021.

GIRIANELLI, V. R. et al.. Qualidade das notificações de violências interpessoal e autoprovocada no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 2009-2016. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 26, n. 3, p. 318–326, jul. 2018.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria nº 508, de 26 de dezembro de 2023. Atualiza a Lista de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública para fins de vigilância epidemiológica no Distrito Federal, nos termos do anexo, e dá outras providências. Brasília, DF. Diário Oficial do Distrito Federal, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.356, de 23 de junho de 2006. Institui incentivo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para a Vigilância de Acidentes e Violências em Serviços Sentinela, com recursos da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Brasília, DF. Diário Oficial da União, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 217, de 01 de março de 2023. Altera o Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017, para substituir o agravo "Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes" por "Acidente de Trabalho" na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças,

agravos e eventos em de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Brasília, DF. Diário Oficial da União, 2023.

Ayres, J.R.C.M. et al. O conceito de vulnerabilidade e as práticas de saúde: novas perspectivas e desafios. In: CzeresNia, D.; Freitas, C.M. (Orgs.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. p.116-39.

Paulilo , M.A.S.; Bello , M.G.D. Jovens no contexto contemporâneo: vulnerabilidade, risco e violência. Ser. Soc. Rev., v.4, n.2, 2002. Disponível em: <http://www.ssrevista.uel.br/>. Acesso em: 22 jan. 2010.

Peres, M.F.T. Homicídios, risco e vulnerabilidade: para uma discussão da dinâmica da vitimização por homicídios. In: Cruz, M.V.G.; Batitucci , E.C. (Orgs.). Homicídios no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2007. p.125-39.

RUOTTI, C.; MASSA, V.C.; PERES, M.F.T. Vulnerability and violence: a new conception of risk for the study of youth homicides. Interface - Comunic., Saude, Educ., v.15, n.37, p.377-89, abr./jun. 2011.

Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Brasília: Ministério da Saúde. BRASIL. Portaria n° 2436/GM/MS, 21 de setembro de 2017 (ANEXO XXII).

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde : volume 3 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde e Ambiente. – 6. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2023.

Organogramas (menu gestor DIORG) - Infosaúde. Disponível em: <https://info.saude.df.gov.br/organogramas/>. Acesso em: 17 dez. 2023.

DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 39.527, de 14 de dezembro de 2018. Altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que especifica e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: < https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/33c250cbc43444fb8fe716d7425be3e1/Decreto_39527_14_12_2018.html >

DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 44.748, de 19 de julho de 2023. Dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: < https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/a6f98e1bcb404d09af8dc45b88585979/Decreto_44748_19_07_2023.html >

DISTRITO FEDERAL. Decreto nº 44.789, de 01 de agosto de 2023. Dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: < https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/75cad63d131f4fb8bda0cef059727d20/Decreto_44789_01_08_2023.html >

Ofício nº 2361/2023 DATDOF/CGAEST/GM/MS, de 28 de agosto de 2023. Assunto: atualização de informações - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 989. Disponível em https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=6437138

NOTA TÉCNICA CONJUNTA No 37/2023-SAPS/SAES/MS. Trata-se de posicionamento do Ministério da Saúde em relação à norma técnica denominada “Atenção técnica para prevenção, avaliação e conduta nos casos de abortamento”, publicada pelo Ministério da Saúde do Brasil em 2022, objeto da ADPF 989.

NEPOMUCENO, G. A experiência do adolescentro no Distrito Federal. Em: Boas práticas e desafios na atenção à saúde com grupos vivendo em situação de vulnerabilidade [s.l.] Editora Aben, 2023. Disponível em: <https://publicacoes.abennacional.org.br/wp-content/uploads/2023/03/C06-Gustavo-Nepomuceno.pdf > Acesso em: 17 dez. 2023.

Girianelli, V. R.; Ferreira, A. P.; Teles, N.; Erthal, R. M. d. C.; Vianna, M. B. & Oliveira, M. H. B. d. (2018). Qualidade das notificações de violências interpessoal e autoprovocada no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 2009-2016. *Cad. Saúde Colet., 26 (3)*, 318-326.

Impactos da Violência na Saúde. / Organizado por Kathie Njaine... (et al.) – 4.ed. atualizada – Rio de Janeiro, RJ: Coordenação de Desenvolvimento Educacional e Educação à Distância da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ENSP, Fiocruz, 2020. 448p.

BRASIL.MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes: norma técnica*. 3. ed. rev. e atual., Brasília, 2012.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política *Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências: Portaria MS/GM nº 737 de 16 de maio de 2001*, publicada no Diário Oficial da União em 18 de maio de 2001, p. 96 seção. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ANÁLISE EM SAÚDE E VIGILÂNCIA DE DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS. *Viva Inquérito 2017: Vigilância de Violências e Acidentes em Serviços Sentinelas de Urgência e Emergência – Capitais e Municípios.* Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

SINAN;SES-DF 2020. SINAN online: banco de dados. Disponível em: < >

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Viva: Vigilância de Violências e Acidentes: 2013 e 2014 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Página. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.

BRASIL. Decreto n° 38.982, de 10 de abril de 2018. Altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências. Brasília, DF, abr 2018. Disponível em: <http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Decreto-n.%C2%BA-38.982-2018-Altera-a-estrutura-adminsitrativa-da-SES-DF.pdf>.

BRASIL. Decreto nº 37.057, de 14 de janeiro de 2016. Dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que especifica e dá outras providências. Brasília, jan 2016. Disponível em: <http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ef9ffafc95b0448db85e0010846badf8/exec_dec_37057_2016_rep.html>

BRASIL. Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, set 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>.

BRASIL. Lei n° 13.104 de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto- Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Brasília, mar 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2015/lei/L13104.htm>.

BRASIL. Lei n° 13.431, de 4 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, DF, abr 2017. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13431.htm>

BRASIL. Lei n° 13.721 de 2 de outubro de 2018. Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para estabelecer que será dada prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Brasília, out 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13721.htm>.

BRASIL. Lei n°13.427, de 30 de março de 2017. Altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências". Brasília, DF, mar 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2017/Lei/L13427.htm>.

BRASIL. Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. Brasília, DF. 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.770.htm>.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Brasília, ago 2006. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 2006/2006/lei/l11340.htm >.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, jun 2015. Disponível em :<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2015/lei/l13146.htm>.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, jul 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>.

BRASIL. Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011. Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde. Brasília, jan 2011. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.h tml>.

BRASIL. Portaria nº 942, de 18 de novembro de 2019. Institui o Centro de Especialidades para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência sexual, Familiar e Doméstica - CEPAV. Brasilia, DF, Nov 2019. Disponível em: <http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/548420ae0a9d46a1bfd41da1c4ebdf6f/ses_prt_942_2019.html>.

BRASIL, 2019 / Prevalência de exposição à violência entre adultos - Brasil, 2019 Mascarenhas, Márcio Dênis Medeiros; Melo, Ariel de Sousa; Rodrigues, Malvina Thais Pacheco; Bahia, Camila Alves; Lima, Cheila Marina; Corassa, Rafael Bello; Andrade, Fabiana Martins Dias de; Malta, Deborah Carvalho.

COSTA, L. F.; ALMEIDA, T. M. C. de; RIBEIRO, M. A. & PENSO, M. A. Grupo Multifamiliar: espaço para escuta das familias em situação de abuso sexual. Psicologia em estudo, Maringá, v. 14, n. 1, jan/mar, 2009. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. (2019). Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil. 2a. Edição

MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.

PATIAS, N.D. e DELL'AGLIO. Prevalência de Exposição à Violência Direta e Indireta: um Estudo com Adolescentes de Colégios Públicos. Act.Colom.Psicol. vol.20 no.1 Bogotá Jan./June 2017. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-91552017000100112&script=sci_arttext&tlng=pt

Atenção Humanizada ao Abortamento: norma técnica/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

Nota Técnica Conjunta N. 01 NG/NDH/PROSUS/PROREG/MPDFT e NUDEM/DPD que dispõe Sobre Comunicação Externa Em Casos De Violência Contra Mulher DE 01/09/2020 - 1º OF-NDH disponível em Microsoft Word - Nota Técnica Lei 13.931 versão final 2.docx (mpdft.mp.br)

Portaria 2.282, de 27 de agosto de 2020, do Ministério da Saúde

Nota Técnica Conjunta n. 01/2022-NG/MPDFT – Orientações para a rede de atendimento e proteção às mulheres sobre as hipóteses de aborto legal, previstas no art. 128 do Código Penal (CP), e de aborto piedoso (ADPF 54/STF), e o dever de notificação compulsória e comunicação externa nos casos de suspeita de violência contra a mulher.

15. ANEXOS

ANEXO I - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA (Link para baixar a Ficha)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA

Nº

DEFINIÇÃO DE CASO: Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres, homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT. **Atenção** : Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares, de acordo com o **art. 13 da Lei no 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente**. Também são considerados de notificação compulsória todos os casos de violência contra a mulher (**Decreto-Lei no 5.099 de 03/06/2004, Lei no 10.778/2003**) e maus tratos contra a pessoa idosa (**artigo 19 da Lei no 10.741/2003**).

DADOS GERAIS

1 – Tipo de Notificação: 2 - Individual

2 – Agravo/Doença: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA | Código – (CID10): Y09 | 3 – Data da Notificação: ___/___/_____

4 – UF | 5 – Município de notificação | Código (IBGE)

6- Unidade Notificadora ☐ 1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros

7- Nome da Unidade Notificadora | Código da Unidade | 9- Data da ocorrência da violência: ___/___/_____

8- Unidade de Saúde | Código (CNES)

NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

10- Nome do paciente | 11- Data de Nascimento: ___/___/_____

12-(ou) Idade ☐ 1- Hora 2- Dia 3- Mês 4- Ano | 13- Sexo ☐ M- Masculino F- Feminino | 14- Gestante ☐ 1-1º Trimestre 2- 2ºTrimestre 3- 3º Trimestre 4- Idade gestacional Ignorada 5 -Não 6- Não se aplica 9 - Ignorado | 15- Raça/Cor ☐ 1-Branca 2- Preta 3- Amarela 4-Parda 5- Indígena 9- Ignorado

16- Escolaridade ☐
0-Analfabeto 1- 1º ao 5º ano incompleto do EF (antigo 1ª a 4ª série) 2- 5º ano completo do EF (antigo primário ou 1º grau)
3- 6º ao 9º ano incompleto do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4- Ensino Fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau)
5-Ensino Médio Incompleto (2º grau) 6- Ensino Médio Completo (2º grau) 7-Educação Superior Incompleta
8- Educação Superior Completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

17-Número do Cartão SUS | 18-Nome da Mãe

DADOS DE RESIDÊNCIA

19-UF | 20- Município de Residência | Código (IBGE)) | 21-Distrito/RA

22- Bairro | 23- Logradouro (rua, avenida, quadra...) | Código

24- Número | 25-Complemento (apto, casa,...) | 26-Geo Campo1

27- Geo Campo 2 | 28- Ponto de Referência | 29- CEP

30-(DDD) Telefone | 31-Zona ☐ 1-Urbana 2-Rural 3-Periurbana 9- Ignorado | 32- País (se reside fora do Brasil)

Dados Complementares

DADOS DA PESSOA ATENDIDA

33- Nome Social | 34-Ocupação

35- Situação Conjugal/Estado Civil ☐ 1 – Solteiro 2 - Casado/união consensual 3- Viúvo 4 – Separado 8- Não se aplica 9 – Ignorado

36- Orientação Sexual ☐ 1-Heterossexual 2- Homossexual(gay/lésbica) 3-Bissexual 8- Não se aplica 9-Ignorado | 37- Identidade de gênero ☐ 1-Travesti 2- Mulher Transexual 3-Homem Transexual 8-Não se aplica 9-Ignorado

38-Possui algum tipo de Deficiência/ transtorno? 1-Sim 2-Não 9-Ignorado ☐ | 39- Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno? 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado
☐ Deficiência Física ☐ Deficiência Visual ☐ Transtorno Mental ☐ Outras _____
☐ Deficiência Intelectual ☐ Deficiência Auditiva ☐ Transtorno de Comportamento

DADOS DA OCORRÊNCIA

40-UF | 41- Município de Ocorrência | Código (IBGE)) | 42-Distrito/RA

43- Bairro | 44- Logradouro (rua, avenida, quadra...) | Código

45- Número | 46-Complemento (apto, casa,...) | 47-Geo Campo3 | 48- Geo Campo 4

49-Ponto de Referência | 50 –Zona de Ocorrência ☐ 1-Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9-Ignorado | 51-Hora de Ocorrência (00:00-23:59 horas)

52- Local de Ocorrência ☐☐
01-Residência 04-Local de Prática Esportiva 07-Comércio/serviços 08-Insdústrias/Construção
02-Habitação Coletiva 05-Bar ou similar 09-Outro _____
03-Escola 06-Via Pública 99-Ignorado

53-Ocorreu outras vezes? ☐ 1-Sim 2-Não 9-Ignorado

54-A lesão foi autoprovocada? ☐ 1-Sim 2-Não 9-Ignorado

Mod.110.195 c.c. 11.000 Formato:210x297 07/2015 N. Prod.Gráfica/SES

VIOLÊNCIA

55-Essa violência foi motivada por: ☐☐
01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância Religiosa 88-Não se aplica
05-Xenofobia 06-Conflito Geracional 07-Situação de Rua 08-Deficiência 09-Outros 99-Ignorado

56-Tipo de Violência 1-Sim 2-Não 9-Ignorado

☐ Física ☐ Tráfico de Seres Humanos ☐ Intervenção Legal
☐ Psicológica/Moral ☐ Financeira/Econômica ☐ Outros:Tentativa de Suicídio
☐ Tortura ☐ Negligência/abandono ☐ Outros: Automutilações
☐ Sexual ☐ Trabalho Infantil ☐ Outros_____

57-Meio da Agressão 1-Sim 2-Não 9-Ignorado

☐ Força Corporal/Espancamento
☐ Enforcamento ☐ Envenenamento, intoxicação
☐ Obj. Contundente ☐ Arma de Fogo
☐ Obj. Pérfuro-Cortante ☐ Ameaça
☐ Substância/Obj. quente ☐ Outros

VIOLÊNCIA SEXUAL

58- Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado

☐ Assédio Sexual ☐ Estupro ☐ Pornografia Infantil ☐ Exploração Sexual ☐ Outros_____

59- Procedimento realizado 1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado

☐ Profilaxia DST ☐ Profilaxia Hepatite B ☐ Coleta de sêmen ☐ Contracepção de emergência
☐ Profilaxia HIV ☐ Coleta de sangue ☐ Coleta de secreção vaginal ☐ Aborto previsto em lei

DADOS DO PROVÁVEL AUTOR DA VIOLÊNCIA

60-Número de envolvidos ☐
1- Um
2-Dois ou mais
9-Ignorado

61- Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida 1-Sim 2-Não 9-Ignorado

☐ Pai ☐ Ex-Cônjuge ☐ Amigos/conhecidos ☐ Policial/agente da lei
☐ Mãe ☐ Namorado(a) ☐ Desconhecido(a) ☐ Própria pessoa
☐ Padastro ☐ Ex-namorado(a) ☐ Cuidador(a) ☐ Outros_____
☐ Madastra ☐ Filho(a) ☐ Patrão/Chefe
☐ Cônjuge ☐ Irmão(ã) ☐ Pessoal com relação institucional

62-Sexo do provável autor da agressão ☐
1-Masculino
2-Feminino
3- Ambos os Sexos
9-Ignorado

63-Suspeita de Uso de álcool ☐
1-Sim
2-Não
9-Ignorado

64- Ciclo de vida do provável autor da violência: ☐
1-Criança (0 a 9 anos)
2- Adolescente (10 a 19 anos)
3-Jovem (20 a 24 anos)
4-Pessoa adulta (25 a 59 anos)
5-Pessoa idosa (60 anos ou mais)
9- Ignorado

EVOLUÇÃO E ENCAMINHAMENTOS

65- Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado

☐ Rede de Saúde (Unidade Básica de Saúde, Hospital, outras)
☐ Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras)
☐ Rede da Educação (Creche, Escola, outras)
☐ Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras)
☐ Conselho Tutelar
☐ Conselho do Idoso
☐ Delegacia de Atendimento ao Idoso
☐ Centro de Referência dos Direitos Humanos
☐ Ministério Público
☐ Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente
☐ Delegacia de Atendimento à Mulher
☐ Outras Delegacias
☐ Justiça da Infância e da Juventude
☐ Defensoria Pública

66- Violência Relacionada ao Trabalho ☐
1-Sim 2-Não 9-Ignorado

67- Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) ☐
1-Sim 2-Não 8-Não se aplica 9-Ignorado

68- Circunstância da lesão
CID 10 – _____

69- Data de encerramento

Informações complementares e observações

Nome do acompanhante	Vínculo/grau de parentesco	(DDD) Telefone

Observações Adicionais:

Disque-saúde Ouvidoria Geral do SUS 136	TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180	Disque Direitos Humanos 100

Mód.110.195 Verso

ANEXO II - FORMULÁRIO INFORMATIVO DE SUSPEITA DE VIOLÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOA IDOSA E PESSOA INDÍGENA

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome:	DN:	Idade:
Mãe:		
Endereço:	Cidade:	
Telefone:		

2. CASO SUSPEITO DE VIOLÊNCIA:

( ) Sexual ( ) Negligência/Abandono ( ) Trabalho Infantil	( ) Psicológica ( ) Física ( ) Autoprovocada	( ) Outra _____

3. PROVÁVEL AUTOR:

Vínculo/grau de parentesco:	Sexo:	Ciclo de vida:

4. BREVE HISTÓRICO

Comunicamos informações recebidas nesta Unidade de Saúde como um caso suspeito de violência_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Portanto, encaminhamos para _____ para conhecimento e providências cabíveis.

"Ressaltamos que os dados contidos neste documento são informações pessoais confidenciais e sigilosas conforme estabelece a Lei Federal nº 12.527 art. 25, e a Lei Distrital nº 4.990/2012 art. 33, não podendo em hipótese alguma serem repassadas a pessoas estranhas, sob pena de responsabilização pessoal."

ANEXO III - FORMULÁRIO INFORMATIVO DE SUSPEITA DE VIOLÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA EM CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

VIOLÊNCIA SEXUAL, DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR CONTRA MULHERES

1. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA:

Nome:	DN:	Idade:
Mãe:		
Endereço:	Cidade:	
Telefone:		

2. Enquadramento da partilha de informações

Situação: ( ) com consentimento da vítima	
( ) sem consentimento da vítima	Motivo: ( ) Risco à vítima ou a comunidade. ( ) Outro:

3. CASO SUSPEITO DE VIOLÊNCIA:

( ) Sexual ( ) Patrimonial	( ) Psicológica ( ) Física	( )Outros:

3. PROVÁVEL AUTOR:

Vínculo/grau de parentesco:	Sexo:	Ciclo de vida:

4. SÍNTESE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

[DESCREVER ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA GESTÃO DE RISCOS COM RELAÇÃO AOS SEGUINTES TEMAS: HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA, HISTÓRIA PSICOSSOCIAL, AJUSTAMENTO PSICOSSOCIAL DO AGRESSOR, POSSÍVEIS AGRAVOS NA SAÚDE DA MULHER, JULGAMENTO PROFISSIONAL SOBRE O RISCO DE VIOLÊNCIA APRESENTADO].

5. FATORES DE RISCO IDENTIFICADO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS COM BASE NO FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO:

( ) Episódios de violências físicas graves
( ) Episódios de violências físicas
( ) Violência com uso de arma branca ou de fogo
( ) Agressão na gestação ou 18 meses após o parto
( ) Violência sexual com uso de força física ou grave ameaça
( ) Stalking (comportamento persecutorio/intimidatório)
( ) Episódios de ameaça de morte
( ) Ameaça de homicidio seguido de suicidio
( ) Violência contra familiares da vítima
( ) Autor com história criminal
( ) Descumprimento de ordem judicial (medida protetiva de urgência)
( ) Autor com história de violência contra outras mulheres
( ) Uso abusivo de substâncias ou álcool pelo autor
( ) Autor com transtorno mental e/ou ideação suicida
( ) Autor com situação laboral instável
( ) Autor com comportamento excessivamente ciumento e controlador
( ) Autor tem fácil acesso a arma de fogo
( ) Padrão de uso da violência para resolver conflitos pelo autor
( ) Isolamento social
( ) Grande diferença de idade entre vítima e autor
( ) Filhos de relacionamento anterior
( ) Vítima percebe-se em perigo
( ) Outros

ANEXO IV - FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - FONAR

FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Original aprovado pela Resolução Conjunta CNJ e CNMP n. 05/2020

PARTE I – ANÁLISE QUANTITATIVA
(Versão adaptada ao Distrito Federal)

Identificação das Partes

Órgão de Registro: _____
Nome da vítima: _____ Idade: _____
Escolaridade: _____ Nacionalidade: _____
Nome do(a) agressor(a): _____ Idade:_____
Escolaridade: _____ Nacionalidade: _____
Vínculo entre a vítima e o(a) agressor(a): _____
Data: _____/_____/_____

Bloco I: Sobre o histórico de violência

1-A e 1-B. O(A) agressor(a) já ameaçou você ou algum familiar com a finalidade de atingi-la?	( ) Sim, utilizando arma de fogo ( ) Sim, utilizando faca ( ) Sim, de outra forma ( ) Não
2-A. O(A) agressor(a) já praticou alguma(s) destas agressões físicas contra você? 2a. ( ) Soco 2b. ( ) Chute 2c. ( ) Tapa 2d. ( ) Empurrão 2e. ( ) Puxão de cabelo 2f. ( ) Outra. especificar: _____ 2g. Nenhuma agressão física ( )	
2-B. O(A) agressor(a) já praticou alguma(s) destas agressões físicas contra você? 2h. ( ) Queimadura 2i. ( ) Enforcamento 2j. ( ) Sufocamento 2k. ( ) Estrangulamento 2l. ( ) Tiro 2m. ( ) Afogamento 2n. ( ) Facada 2o. ( ) Paulada 2p. Nenhuma agressão física ( ) **3.** Você necessitou de atendimento médico e/ou internação após algumas dessas agressões? ( ) Sim, atendimento médico ( ) Sim, Internação ( ) Não	
4. O(A) agressor(a) já obrigou você a ter relações sexuais ou praticar atos sexuais contra sua vontade?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
5. O(A) agressor(a) persegue você, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida e as coisas que você faz? (aonde você vai, com quem conversa, o tipo de roupa que usa, etc.) ( ) Não ( ) Sim ( ) Não sei **6.** O(A) agressor(a) já teve algum destes comportamentos? 6a. ( ) Disse algo parecido com a frase: "se não for minha, não será de mais ninguém" 6b. ( ) Perturbou, perseguiu ou vigiou você nos locais que frequenta 6c. ( ) Proibiu você de visitar familiares ou amigos 6d. ( ) Proibiu você de trabalhar ou estudar 6e. ( ) Fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou *e-mails de* forma insistente 6f. ( ) Impediu você de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens (como documentos pessoais, carro) 6g. ( ) Teve outros comportamentos de ciúme excessivo e de controle sobre você 6h. ( ) Proibiu você de ir ao médico ou pedir ajuda a outros profissionais 6i. Nenhum dos comportamentos acima listados ( )	

7-A. Você já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo esse(a) mesmo(a) agressor(a)?	( ) Sim, no DF ( ) Não ( ) Sim, fora do DF
7-B. O(A) agressor(a) já descumpriu medida protetiva anteriormente?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
8. As agressões ou ameaças do(a) agressor(a) contra você se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei

Bloco II: Sobre o(a) agressor(a)

9. O(A) agressor(a) faz uso abusivo de álcool ou de drogas ou de medicamentos?	( ) Sim, de álcool ( ) Não ( ) Sim, de drogas ( ) Não sei ( ) Sim, de medicamentos
10. O(A) agressor(a) tem alguma doença mental comprovada por avaliação médica?	( ) Sim e faz uso de medicação ( ) Sim e não faz uso de medicação ( ) Não ( ) Não sei
11. O(A) agressor(a) já tentou suicídio ou falou em suicidar-se?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
12. O(A) agressor(a) está com dificuldades financeiras, está desempregado ou tem dificuldade de se manter no emprego?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
13. O(A) agressor(a) já usou, ameaçou usar arma de fogo contra você ou tem fácil acesso a uma arma?	Sim, usou ( ) Sim, ameaçou usar ( ) ( ) Sim, tem fácil acesso ( ) Não ( ) Não sei
14. O(A) agressor(a) já ameaçou ou agrediu seus filhos, outros familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas desconhecidas ou animais?	( ) Sim, filhos ( ) Sim, outros familiares ( ) Sim, amigos ( ) Sim, colegas de trabalho ( ) Sim, outras pessoas ( ) Sim, animais ( ) Não ( ) Não sei

Bloco III: Sobre você

15. Você se separou recentemente do(a) agressor(a), tentou ou manifestou intenção de se separar?	( ) Sim ( ) Não
16-A. Você tem filhos?	Sim, com o agressor ( ) Quantos?_____ ( ) Sim, de outro relacionamento. Quantos?_____ ( ) Não
17. Você está vivendo algum conflito com o(a) agressor(a) em relação à guarda do(s) filho(s), visitas ou pagamento de pensão?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
18. Seu(s) filho(s) já presenciaram ato(s) de violência do(a) agressor(a) contra você?	( ) Sim ( ) Não
19. Você sofreu algum tipo de violência durante a gravidez ou nos três meses posteriores ao parto?	( ) Sim ( ) Não
20. Você está grávida ou teve bebê nos últimos 18 meses?	( ) Sim ( ) Não

21. Se você está em um novo relacionamento, percebeu que as ameaças ou as agressões físicas aumentaram em razão disso?	( ) Sim ( ) Não
22. Você possui alguma deficiência ou doença degenerativa que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental? **22-B.** Você se considera uma mulher idosa?	( ) Sim ( ) Não Qual(is):_____ ( ) Sim ( ) Não
23. Com qual cor/raça você se identifica:	( ) preta ( ) parda ( ) indígena amarela/oriental ( ) branca ( )
28. Você se sente isolada de amigos, familiares, pessoas da comunidade ou trabalho?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei

Bloco IV: Outras informações importantes (não fatores de risco de agressão física potencialmente letal)

16-B. Qual a faixa etária de seus filhos? Se tiver mais de um filho, pode assinalar mais de uma opção:	( ) 0 a 11 anos ( ) 12 a 17 anos ( ) A partir de 18 anos
16-C. Algum de seus filhos é pessoa com deficiência?	( ) Sim ( ) Não
24. Você considera que mora em bairro, comunidade, área rural ou local de risco de violência?	( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
25. Qual sua situação de moradia?	( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cedida ou "de favor" Por quem? _____
26. Você se considera dependente financeiramente do(a) agressor(a)?	( ) Sim ( ) Não
27. Você quer e aceita abrigamento temporário?	( ) Sim ( ) Não

Declaro, para os fins de direito, que as informações supra são verídicas e foram prestadas por mim, _____

Assinatura da vítima/terceiro comunicante: _____

PARA PREENCHIMENTO PELO PROFISSIONAL:

( ) Vítima respondeu a este formulário sem ajuda profissional
( ) Vítima respondeu a este formulário com auxílio profissional
( ) Vítima não teve condições de responder a este formulário
( ) Vítima recusou-se a preencher o formulário
( ) Terceiro comunicante respondeu a este formulário.

O Formulário Nacional de Avaliação de Risco será preferencialmente aplicado pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência policial, ou, na impossibilidade, pela equipe do Ministério Público ou do Poder Judiciário, por ocasião do primeiro atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar. É facultada a utilização do modelo de Formulário Nacional de Avaliação de Risco por outras instituições, públicas ou privadas, que atuem na área da prevenção e do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco é composto de questões objetivas (Parte I) e subjetivas (Parte II), e será aplicado por profissional capacitado, admitindo-se, na sua ausência, o preenchimento pela própria vítima, tão somente, quanto às questões objetivas (Parte I). Após sua aplicação, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco será anexado aos inquéritos e aos procedimentos relacionados à prática de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para subsidiar a apreciação judicial de pedidos de medida protetiva de urgência e/ou cautelar, bem como a atuação do Ministério Público e dos demais integrantes da rede de proteção.

(Resolução Conjunta CNJ e CNMP n. 05/2020, art. 3º a 5º)

INFORMAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO E GESTÃO DO RISCO NO DF

ATENÇÃO!: Independentemente do preenchimento deste formulário ou de suas respostas, as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima devem ser apreciadas e a persecução criminal deve ter continuidade. Poucas respostas positivas não significam desnecessidade de intervenções de proteção pelo Sistema de Justiça. Especial atenção deve ser dada para não se subestimar a violência psicológica, que muitas vezes não possui tipos penais adequados para retratar sua gravidade, todavia possui grave impacto no adoecimento orgânico e mental de mulheres e na fragilização dos vínculos familiares e comunitários.

Avaliar risco significa investigar fatores de risco com objetivo de orientar decisões de modo a reduzir ou eliminar o risco de ocorrer novas violências. A avaliação dos dados da Parte I deste formulário é qualitativa e requer o julgamento do avaliador. Quanto maior o número de respostas positivas nos Blocos I, II e III, maior o risco de violência grave potencialmente letal. As respostas do Bloco IV não configuram fatores de risco de feminicídio ou lesão agravada e não devem ser contabilizados, apesar de fornecerem informações importantes para a compreensão dos fatos. As informações quantitativas da Parte I devem ser complementadas com a avaliação estruturada da Parte II.

O avaliador deve utilizar sua experiência e julgamento para avaliar se há fatores de risco que no caso avaliado representam sozinhos o aumento do risco. Exemplos de fatores de risco, descritos na literatura (Nicolls et al., 2013)[1] como itens que costumam representar risco independente de outros elementos são: histórico de violências, uso de faca ou arma de fogo, agressões físicas graves e ciúme excessivo (itens 1-A, 2-B, 3 e 6a, 6b e 6c). A questão 19 pode ser considerada uma modalidade de agressão física grave (2-B).

A partir da identificação dos fatores de risco objetivos (Parte I) e de sua avaliação estruturada (Parte II), deve ser selecionado o tipo de intervenção adequada para a gestão individualizada destes riscos, conforme diretrizes da Parte III. A critério do profissional, deve-se avaliar o encaminhamento do formulário aos destinatários dos encaminhamentos de proteção, preservado o sigilo perante terceiros.

A avaliação realizada por meio desse formulário constitui um recorte do fenômeno. Essa avaliação inicial não é definitiva. O risco pode alterar-se ao longo do tempo. Por isso, outras avaliações devem ser realizadas nos diversos serviços que compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A análise dos encaminhamentos de proteção deve ser feita no Judiciário, ao se deferir as medidas protetivas de urgência, no Ministério Público ou Defensoria Pública com a chegada dos autos de Medida Protetiva de Urgência, bem como por toda a rede. Os Blocos I, II e III da Parte I contam como fatores de risco de violência grave potencialmente letal. Deve ser considerado como fator de risco qualquer resposta nos parênteses sombreados. Cada quadro corresponde a um único fator de risco, de forma que várias marcações em um único quadro (ex: 2-A) contam apenas um ponto. As marcações NÃO SEI devem ensejar um aprofundamento da investigação na Parte II do formulário. Atentar que na questão 1 há dois quadros e cada qual indica fatores de risco distintos, assim como as questões 2-A e 2-B representam fatores de risco distintos. Quando duas questões estão no mesmo quadro, elas configuram o mesmo fator de risco e devem ser contadas uma única vez, como no caso das questões: 2-B e 3; 5 e 6; 19 e 20; 22 e 22-B. Na questão 13, as duas primeiras marcações (usou ou ameaçou usar arma de fogo) já estão computadas nas questões 1-A e 2.I, portanto não devem ser computadas novamente. Na questão 16-A, apenas a marcação de filhos de outro relacionamento deve ser considerada como fator de risco. Na questão 23, as opções "preta", "parda" e "indígena" devem ser computadas.

Anote a seguir a pontuação identificada:

Pontuação máxima: (Blocos I, II e III)	**24**	**Somatório da pontuação neste caso:**

1 Nicolls, Tonia L.; Pritchard, Michelle M.; Reeves, Kim A. & Hilterman, Edward (2013). Risk assessment in intimate partner violence: a systematic review of contemporary approaches. *Partner Abuse*, v. 4 (1).

PARTE II - AVALIAÇÃO ESTRUTURADA

(Preenchimento exclusivo por profissional capacitado)

INFORMAÇÕES: Essa avaliação deve ser conduzida por profissional com experiência em técnicas de entrevista e conhecimento sobre avaliação do funcionamento global e saúde mental. Nesta parte do formulário o/a profissional responsável pelo atendimento deverá registrar informações consideradas relevantes para a compreensão global da situação. O documento de avaliação estruturada consiste em um conjunto de perguntas que serão respondidas de forma descritiva e sucinta pela(o) profissional. O registro se fará a partir de informações que já foram prestadas pela vítima, acrescentadas de outras sobre suas condições físicas, emocionais e psicológicas. Ao final, um campo aberto permite o registro de informações adicionais e que sejam consideradas relevantes para entendimento da gravidade da situação e para a proteção da mulher.

1. Durante o atendimento a vítima demonstra percepção de risco sobre sua situação? A percepção é de existência ou inexistência do risco? (por exemplo, ela diz que o agressor pode matá-la, ou ela justifica o comportamento do agressor ou naturaliza o comportamento violento?). Anote a percepção e explique:

Avaliar a percepção da mulher sobre o risco e elementos que interferem nessa percepção (ex: distorção cognitiva ou negação da violência e do contexto de risco, estresse pós traumático ou outras condições de saúde que interferem na percepção do risco). Explicitar diferenças de percepção entre avaliador e vítima, quando houver.

_____

_____

_____

2. Existem outras informações relevantes com relação ao contexto ou situação da vítima e que possam indicar risco de novas agressões? (Por exemplo, a vítima tem novo(a) companheiro(a) ou tomou decisões que anunciam um rompimento definitivo com o agressor (pretende mudar de casa, bairro, cidade). Anote e explique:

Investigar a intenção e planos efetivos de separação, bem como dinâmica após a separação. Dimensões relevantes sobre esse tema são: vítima não se separa por medo, vítima planeja separação, comportamento do autor após anuncio de separação, após a separação autor agrediu ou ameaçou agredir pessoas que ajudaram a vítima, autor tem meio ou poder especial para encontrar a vítima em caso de separação, outros relacionamentos amorosos.

_____

_____

_____

3. Como a vítima se apresenta física e emocionalmente? (Tem sinais de esgotamento emocional, está tomando medicação controlada, necessita de acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico?) Descreva:

Avaliar funcionamento global e saúde física e mental da mulher (Ex: doenças crônicas, lesões e outros adoecimentos físicos decorrentes das violências, sintomas de alteração de humor, transtorno de estresse pós traumático, uso abusivo de álcool/drogas, ideação suicida, transtorno de personalidade, sintomas psicóticos), bem como uso de medicação e acesso a tratamentos.

_____

_____

_____

4. Existe o risco da vítima tentar suicídio ou existem informações de que tenha tentado se matar?

Investigar ideação e planos suicidas atuais e passados.

_____
_____
_____

5. A vítima ainda reside com o(a) agressor(a) ou ele tem acesso fácil à sua residência? Explique a situação.

Investigar rotina da vítima, comportamentos persecutórios e fácil acesso pelo autor a armas brancas e de fogo, se o autor tem poder ou meio especial para controlar ou acessar a vítima. Estas informações são essenciais para elaboração de plano de segurança pessoal.

_____
_____
_____

6. Descreva, de forma sucinta, outras circunstâncias que, na sua opinião, poderão representar risco de novas agressões, deverão ser observadas no fluxo de atendimento e ensejar a reavaliação de risco por outros profissionais.

Investigar outros fatores de risco como por exemplo: ideação suicida, uso abusivo de álcool e drogas e transtorno de personalidade do autor; agressão na gestação; orientação sexual ou identidade de gênero da vítima fomentam discriminação; agressor pertence a organização criminosa, grande diferença etária entre agressor e vítima, relacionamento não público.

_____
_____
_____

7. Quais são os encaminhamentos sugeridos para a vítima?

_____
_____
_____

8. A vítima concordou com os encaminhamentos?
Sim ( )
Não ( ) Por quê? _____

9. A vítima demonstra interesse em aderir aos encaminhamentos?
Sim ( )
Não ( ) Por quê? _____

Nome do(a) profissional _____ Cargo/função _____
Data de preenchimento ____/____/_____Serviço/órgão _____

ANEXO V - BASES LEGAIS

Serão consideradas as seguintes Normas, Leis e Portarias:

Aspectos Jurídicos do Atendimento às vítimas de violência sexual – Perguntas e respostas para profissionais de saúde, Ministério da Saúde (2011).

Brasil. Ministério da Saúde. Humanização do parto e do nascimento / Ministério da Saúde. Universidade Estadual do Ceará. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 465 p. : il. – (Cadernos HumanizaSUS ; v. 4) ISBN 978-85-334-2136-3

Código de Processo Penal Brasileiro (1940).

Constituição da República Federativa do Brasil (1988).

Decreto 39.087 de 29 de maio de 2018. Institui a Política Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Distrito Federal e dá outras providências.

Decreto n° 38.982 de 10 de abril de 2018. Altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências.

Decreto nº 37.057 de 14 de janeiro de 2016. Dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que especifica e dá outras providências.

Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências.

Decreto nº 7.958, de 13 de março de 2013, que estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde.

Diretrizes Nacionais Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e de Jovens para a promoção, proteção e recuperação da saúde. – 2010.

Lei 12.650 de 17 de maio de 2012 – Lei Joana Maranhão, que altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, com a finalidade de modificar as regras relativas à prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes.

Lei 12.845 1º de agosto de 2013 que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.

Lei 4.730, de 28 de dezembro de 2011, que cria a Notificação Compulsória de Violência contra a criança ou o adolescente.

Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Lei n. 6.259 de 30 de outubro de 1975. Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.

Lei n.º13.718, de 24 de setembro de 2018. Tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro.

Lei n° 11.829 de 25 de novembro de 2008. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet.

Lei n° 12.288 de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003.

Lei n° 13.104 de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos.

Lei n° 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância.

Lei n° 13.431, de 4 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Lei n° 13.721 de 2 de outubro de 2018. Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para estabelecer que será dada prioridade à 78 realização do exame de

corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

Lei n°12.015, de 7 de agosto de 2009. Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954, que trata de corrupção de menores.

Lei n°13.427, de 30 de março de 2017. Altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.

Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados.

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Lei nº 13.931, de 10 de dezembro de 2019. Altera a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, para dispor sobre a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. 79

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Norma Técnica Atenção Humanizada ao Abortamento, Ministério da Saúde (2011).

Norma Técnica que trata da Prevenção e Tratamento dos Agravos resultantes da Violência sexual contra Mulheres e Adolescentes, Ministério da Saúde (2012).

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, elaborada em 2004 pelo Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens –2005.

Portaria 1.271 de 06 de junho de 2014 que traz a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, agravos e eventos de saúde pública.

Portaria 485 de 1º de abril de 2014 que redefine o funcionamento do Serviço às Pessoas em Situação de violência no âmbito do SUS.

Portaria Ministerial de Consolidação nº 04 de 28 de setembro de 2017, Anexo V, que trata da notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas nos serviços de saúde públicos e privados.

Portaria n° 204 de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências.

Portaria nº 1.508/GM/MS, de 1º de setembro de 2005, que dispõe sobre o procedimento de justificação e a autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do SUS.

Portaria nº 1.944/GM/MS, de 28 de agosto de 2009, que institui, no âmbito do SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.

Portaria nº 1.968/GM/MS, de 25 de outubro de 2001, que dispõe sobre a notificação, às autoridades competentes, de casos de suspeita ou de confirmação de maus tratos contra crianças e adolescentes atendidos nas entidades do SUS.

Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011. Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde.

Portaria nº 2.406/GM/MS, de 5 de novembro de 2004, que institui serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher e aprova instrumento e fluxo para notificação.

Portaria nº 2.415, de 7 de novembro de 2014, do Ministério da saúde que inclui o procedimento Atendimento Multiprofissional para Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual e todos os seus atributos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS.

Portaria nº 737/GM/MS, de 16 de maio de 2001, que aprova, na forma do Anexo, a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências.

Portaria nº 773, de 19 de julho de 2018. Estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Ambulatorial Secundária.

Portaria nº 936, de 18 de maio de 2004, que define a estruturação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e a Implantação e Implementação de Núcleos de Prevenção à Violência.

Portaria nº 942, de 18 de novembro de 2019. Institui o Centro de Especialidades para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência sexual, Familiar e Doméstica - CEPAV.

Resolução nº 1/96 do Conselho de Saúde do Distrito Federal de 30 de abril de 1996, que estabelece o Hospital Materno Infantil de Brasília como hospital de referência para os casos de Aborto Previsto em Lei.